

SIMS

**Inventario Estructurado
de Simulación de Síntomas**

Manual



Michelle R. Widows

Glenn P. Smith

Adaptación: Héctor González Ordi y
Pablo Santamaría Fernández



Ediciones

SIMS

**Inventario Estructurado
de Simulación de Síntomas**



Manual

Michelle R. Widows

Glenn P. Smith

Adaptación: Héctor González Ordi y
Pablo Santamaría Fernández



TEA Ediciones, S.A.
Madrid, 2009

Título original: SIMS. *Structured Inventory of Malingered Symptomatology*
Psychological Assessment Resources, Florida, EE. UU.

Adaptación española: Héctor González Ordi y Pablo Santamaría Fernández

Copyright del original © 2005 by Psychological Assessment Resources, Florida (EE. UU.)
Copyright de la adaptación española © 2009 by TEA Ediciones, S. A. Madrid (España)
Adaptado y publicado con permiso de Psychological Assessment Resources, Florida (EE. UU.)

Diseño y maquetación: La Factoría de Ediciones, S. L. (Madrid)

ISBN: 978-84-7174-903-1
Depósito legal: M-22454-2009

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

Prólogo a la adaptación española	7
Agradecimientos	9
Ficha técnica	11
1. Introducción y descripción general	13
1.1. Definición, evaluación y tasas de prevalencia de la simulación	13
1.1.1. Definición de la simulación	13
1.1.2. Aplicación de la definición e indicadores en el proceso de evaluación	14
1.1.3. Modelos alternativos de evaluación	14
1.1.4. Ámbitos y prevalencia de la simulación	15
1.2. Instrumentos para la detección de la simulación	16
1.2.1. Entrevistas y tests	16
1.2.2. Medidas de <i>screening</i>	17
1.3. El SIMS como prueba de <i>screening</i> para la detección de la simulación	17
1.3.1. Ámbito de aplicación del SIMS y limitaciones de la prueba	18
1.3.2. Requisitos profesionales para el uso del SIMS	19
1.3.3. Seguridad y confidencialidad	19
1.3.4. Materiales del SIMS	20
2. Normas de aplicación y corrección	21
2.1. Normas de aplicación	21
2.2. Normas de corrección	22
3. Proceso de construcción original de la prueba y adaptación española	25
3.1. Construcción de los elementos	25
3.2. Selección de los ítems y construcción de las escalas	26
3.3. Muestra empleada en los estudios originales	26
3.4. Adaptación española	27
4. Fundamentación estadística	29
4.1. Muestras empleadas en la adaptación española	29
4.1.1. Muestra clínica y de análogos	30
4.1.2. Muestras de simuladores y casos clínicos en contextos médico-legales clasificados por criterios externos e independientes	31
4.1.3. Muestras de grupos clasificados por su grado de exageración de síntomas de acuerdo a sus puntuaciones en el MMPI-2	32
4.1.4. Muestras específicas de dolor crónico	33
4.1.5. Muestras de validez convergente con MMPI-2, MCMI-II y MCMI-III	34
4.2. Fiabilidad	34
4.2.1. Consistencia interna	34
4.2.2. Consistencia temporal: Estudio test-retest	35



4.3. Validez	35
4.3.1. Estructura factorial del SIMS	36
4.3.2. Estudios con análogos, muestras clínicas y grupos diagnósticos	38
4.3.2.1. Estudios originales	39
4.3.2.2. Estudios independientes	45
4.3.2.3. Estudios de la adaptación española	54
4.3.3. Estudios de convergencia con otras pruebas	77
4.3.3.1. Estudios originales	77
4.3.3.2. Estudios independientes	78
4.3.3.3. Estudios de la adaptación española	78
5. Normas de interpretación	81
5.1. La detección de simulación: Implicaciones y tipos de errores en el proceso	81
5.2. La detección de simulación con el SIMS: establecimiento de los puntos de corte de la adaptación española	83
5.3. Normas específicas de interpretación	85
5.3.1. Determinación de sospecha de simulación a partir de la puntuación Total en la prueba	86
5.3.2. Interpretación de las escalas	86
5.3.3. Consideraciones sobre la interpretación de los ítems	88
5.4. Caso ilustrativo	88
5.4.1. Descripción del caso	89
Bibliografía	93

Uno de los problemas adicionales objeto de atención médica que han de afrontar a diario los profesionales de la salud —como refiere el DSM IV— es la simulación de síntomas o enfermedades mediante conductas intencionadas de engaño y mentira o múltiples formas de exageración o distorsión de síntomas. Son conductas intencionadas y desarrolladas por determinados individuos con objetivos externos de fraude y búsqueda de beneficio, en general rentas, indemnizaciones e incapacidades, el retorno al país de origen con una incapacidad y la consiguiente renta o evitar determinadas responsabilidades.

El coste económico que representan estos comportamientos para el sistema socio-sanitario y económico de un país es incalculable. En primer lugar, a nivel del sistema sanitario en términos de coste directo por las múltiples pruebas médicas que han de realizarse, la medicación ineficaz, la ocupación de camas hospitalarias y los prolongados periodos de incapacidad transitoria. Y en términos indirectos por el tiempo que requieren del profesional y que sustraen de la atención a personas realmente enfermas, las numerosas exploraciones e informes, la formulación de demandas, peritaciones y los consiguientes juicios. En segundo lugar, a nivel social, puesto que una sociedad del bienestar ha de basarse en la participación y el trabajo de todos sus miembros, quienes han de educarse y desarrollarse hasta integrar en sus vidas una conciencia colectiva y unos compromisos comunes basados en valores de responsabilidad, solidaridad y trabajo. Las conductas citadas originan un grave coste social muy difícil de calcular, sólo parcialmente investigado hasta la actualidad por algunas compañías aseguradoras. A su vez, perjudican a toda la sociedad, en particular a quienes requieren de verdad recursos sanitarios, que son limitados. Sin duda, el destino de recursos al sistema sanitario se verá mermado por la desviación de éstos a quienes engañan, mienten o simulan estar enfermos.

El problema es aún más grave por el creciente aumento actual de estas conductas. A ello contribuyen muy diferentes factores. Destaquemos la crisis social que origina el desempleo, siempre presente en menor o mayor grado en las sociedades desarrolladas, en las que la garantía de una renta económica es precisa para subsistir; la frecuente precariedad del trabajo en muy diferentes sectores que siembra inseguridad en los individuos y en sus familias y que retrasa cada día más la autonomía, la independencia y la normal planificación de sus vidas; el aprendizaje social basado en la imitación por el conocimiento de rentas e incapacidades obtenidas por otros individuos en procesos semejantes; la inadecuación de las políticas y leyes que han desarrollado más los sistemas de reparación basados en la concesión de subsidios, indemnizaciones, rentas, incapacidades y pensiones, que los sistemas de rehabilitación médica y profesional, contribuyendo así al aprendizaje social de una subcultura de la indemnización y la incapacidad, de la pasividad y la dependencia frente a la participación y la actividad; el creciente aumento de profesionales cuya ética se sitúa en cotas mínimas, que activan y acentúan las citadas conductas y las expectativas de sus clientes, planteándose como objetivo el logro de la mayor incapacidad e indemnización posible, de cuya magnitud a su vez perciben sus honorarios; la mala praxis profesional que genera y multiplica las ideas de enfermedad e incapacidad y las consiguientes demandas; y en definitiva muy diversos factores individuales, puesto que, aún considerándose las razones expuestas, éstas han de germinar sobre factores individuales, familiares o grupales característicos.

En contextos socio-sanitarios, y quizá en otros contextos, las conductas de simulación han de ser entendidas como conductas intencionadas de engaño y fraude, con objetivos externos y explícitos de lograr rentas e indemnizaciones o una incapacidad que así lo asegure. Estas conductas son conocidas desde la antigüedad. Gisbert (1991) argumenta que hay referencias en la Biblia y en documentos de las antiguas Roma y Grecia en los que se cita que la simulación era característica para evitar la prisión y la ejecución. Rodríguez Marín (1957) se refiere a intentos de explicar la simulación en el *Tratado de los aires, de las aguas y de los lugares* de Hipócrates (460-377 A.C.) y en el *Tratado de las enfermedades simuladas* de Galeno de Pérgamo (129-199 A.C.).



Desde la antigüedad hasta nuestros días, numerosos trabajos han abordado este problema, entre otros, los publicados por el Dr. Héctor González Ordi, director de los trabajos que dan lugar a la publicación de esta importante herramienta diagnóstica que se presenta bajo el sello de una institución tan querida por la Psicología de nuestro país: TEA Ediciones. Desde la perspectiva de quien escribe estas páginas merecen destacarse los interesantes capítulos publicados por el Profesor González Ordi en el libro *Psicología de la Rehabilitación*, editado por la Fundación Mapfre en el año 1999. Hoy es posible reconocer que hay tantas posibilidades de simulación como fines imaginables: conseguir fármacos, evitar obligaciones laborales o militares, evadirse de la justicia, lograr indemnizaciones e incapacidades, etc. Delgado, Esbec y Rodríguez (1994) afirman que «la persona simuladora es aquella que de forma intencionada produce síntomas físicos y psicológicos motivada por la obtención de beneficios y objetivos concretos e identificables». La existencia de una ganancia concreta identificable en la peritación es, a juicio de estos autores, un indicio de sospecha. Los entornos que favorecen y multiplican la posibilidad de conductas de simulación son muy numerosos: contextos militares, carcelarios, centros y consultas médicas, mala práctica profesional o relaciones médico-enfermo coercitivas, contextos laborales, civiles y penales, accidentes de trabajo o de tráfico y reclamaciones al sistema público de salud y a las compañías aseguradoras, delincuencia y agresiones, problemas de pareja y matrimoniales, nulidades, testamentos y herencias, operaciones de compra y venta, etc.

Para su detección y diagnóstico muy diversos autores han propuesto diferentes indicadores —léanse los que propone el DSM IV— y que, bien constatados por los especialistas sanitarios, debieran ser suficientes para objetivar conductas de esta naturaleza y aceptados por los jueces. No obstante, y según la experiencia en escenarios judiciales del autor de estas líneas, no suelen ser considerados suficientes. Por ello han de enriquecerse los citados indicadores con otros aportados por autores de reconocido prestigio y autoridad, y con la información facilitada por guías y protocolos de evaluación y exploración clínica que incorporen las conclusiones de pruebas experimentadas y apoyadas en la correspondiente investigación científica. A ello, sin duda, viene a contribuir el *Inventario Estructurado de Simulación de Síntomas* —SIMS—, cuya adaptación española han llevado a cabo Héctor González Ordi, de la Universidad Complutense de Madrid, y Pablo Santa María Fernández, de TEA Ediciones. Como refieren en sus trabajos de adaptación, el SIMS «es una medida de autoinforme que consta de 75 ítems en formato verdadero-falso y que facilita la detección de patrones de simulación de síntomas psicopatológicos y neuropsicológicos». A este notable objetivo se suma TEA Ediciones pues incluye en su ya excelente catálogo una prueba más que, sin duda, contribuirá a facilitar y mejorar la evaluación e identificación de este problema.

Todo buen profesional de la salud ha de asumir entre sus responsabilidades evitar el fraude, el engaño y el consecuente gasto económico. Valores profesionales basados en el compromiso con principios morales individuales y sociales y en principios éticos en el desempeño de la actividad profesional son incompatibles con la tolerancia de la mentira y el fraude. Por ello, desde nuestro agradecimiento a los profesores que han adaptado la prueba que presentamos —en particular al Dr. Héctor González Ordi, a quien nos une una acen tuada amistad desde hace años— y a TEA Ediciones, destacar sin duda que el SIMS contribuirá a ayudar a quien en realidad lo requiere, puesto que identificar el fraude contribuye a su vez a defender los derechos justos de quienes de verdad sufren la adversidad de una enfermedad o de un accidente, o bien de otros problemas que afectan a la calidad de vida de las personas.

Madrid, febrero de 2009

Ángel Ruano Hernández
Doctor en Psicología
Especialista en Psicología Clínica
Psicoterapeuta de la EFPA/COP
Colegiado M – 00837

El SIMS fue originalmente creado como parte de mi tesis doctoral en la Universidad de Missouri-St. Louis. Por este motivo, quería agradecer a mi tutor, el Dr. Gary Burger, su orientación y guía en este proyecto, así como al resto del personal de la Universidad. También desearía expresar mi agradecimiento al Dr. Richard Rogers por su amistad y su consejo profesional tanto en los comienzos del SIMS como durante todo su desarrollo. Sin el apoyo y el asesoramiento de estos profesionales, el SIMS no habría pasado de ser una mera idea.

Me gustaría expresar también mi gratitud a aquellas personas que con sus valiosas aportaciones han contribuido al desarrollo de la prueba durante los estudios piloto, la recogida inicial de muestra y la investigación. Entre ellos se incluyen los doctores Ronald Brown, Kart West y David Berry. El SIMS se ha visto beneficiado enormemente de su inestimable juicio clínico y sus sugerencias.

Estoy en deuda con el doctor Randy Borum por su amistad, apoyo y ánimo para emprender el desafío que ha supuesto la publicación del SIMS.

Finalmente, gracias a mi familia. A mis hijos, Sean y Ryan, por recordarme lo que realmente es importante. A mi mujer y compañera, la Dra. Cindy Ochipa, que ha sido mi principal consejera y apoyo tanto en lo personal como en lo profesional, a ella le dedico mi más profundo agradecimiento, amor y consideración.

Glenn P. Smith

Un especial agradecimiento merecen los numerosos miembros del equipo editorial de PAR que con su tiempo y atención han contribuido a sacar a la luz esta obra: A April May por su experta ayuda con los permisos; a Melissa Messer por su destacada atención al detalle; a Richard Brummer y Scott Murphy, por su diestra dedicación a asegurar la calidad del producto; a Linda Jennings y Lisa Doelling por sus inestimables sugerencias en la edición y a Penny Smith, Becky Haines y Justin Smith por su atractiva composición tipográfica y presentación. El agradecimiento debe ser extendido también a los doctores Kart West y David Berry por sus comentarios y revisiones de la versión beta de este manual.

Estoy en deuda con el Dr. R. Bob Smith y Cathy Smith por su invitación a unirme a la gran familia que es PAR – ha resultado ser un sitio maravilloso en el que trabajar, rebotante de energía positiva, de estimulación intelectual y de personas con una gran calidad humana. También quería expresar mi agradecimiento personal al Dr. Travis White por permitirme estar vinculada a la publicación del SIMS y a los doctores White y Mark Ledbetter por su maravillosa guía y orientación.

Finalmente, me gustaría extender mi agradecimiento a mi familia y amigos, quienes me han apoyado incondicionalmente a lo largo de los años, tanto personal como profesionalmente. Gracias.

Michelle R. Widows

Agradecimientos de la adaptación española

Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a todos aquellos profesionales que con su colaboración han hecho posible esta adaptación española:

Pilar Capilla Ramírez
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
FREMAP Madrid II,
Madrid.

Pilar Fernández Marín
Servicio de Psicología del Hospital ASEPEYO,
Coslada (Madrid)

Juan Luis Blasco
Laura Gallardó
Instituto de Psicología Aplicada a la Salud-IPAS,
Valencia.

Francisca Denia Ruiz
Rosa Jurado Barba
Unidad de Neuropsicología. Servicio de Psiquiatría,
Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid

Deborah Calvo
José Caballero
Pericial Corporativa,
Madrid

Blanca Matalobos Veiga
Centro Integral Psico-Somático-CIPSO,
Madrid

José Manuel Hernández López
Dpto. Psicología Biológica y de la Salud,
Fac. de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid

José Luis Santos Ruiz
Psicólogo clínico y F.E.A.
Complejo hospitalario de Toledo

Susana Rozas Blanco
Neuropsicóloga
Asociación afectados lesión cerebral sobrevenida -
CEBRANO,
Siero (Asturias)

Federico Rodríguez del Ama
Psicólogo clínico
Hospital de FREMAP,
Sevilla

Magdalena Muguiro Loring
Psicóloga clínica
Instituto Salud Mental Pérez Espinosa Oria,
Llanera (Asturias)

Susana García Tardón
Psicóloga clínica
Centro Salud Mental Cangas Narcea,
Cangas del Narcea (Asturias)

Silvia Mateo Asin
Psicóloga clínica
AVANVIDA-CRPS Ordoiz de Estella,
Ordoiz de Estella (Pamplona)

Ana Isabel Ruiz González
Psicóloga clínica
AVANVIDA-CRPS Queiles de Tudela,
Queiles de Tudela (Pamplona)

Elena Fernández Herrero
María Otero Larrea
Cristina Monreal Guillorme
Psicólogas clínicas
AVANVIDA-CRPS Arga,
Pamplona

Isabel Bueso González
Psicóloga y Coordinadora del Equipo de Ajuste
Personal y Social
Centro Especial de Empleo OLIVER,
Zaragoza

- ☐ **Nombre:** SIMS, Inventario estructurado de simulación de síntomas.
- ☐ **Nombre original:** *SIMS, Structured Inventory of Malingered Symptomatology*.
- ☐ **Autores:** Michelle R. Widows y Glenn P. Smith.
- ☐ **Procedencia:** *Psychological Assessment Resources, PAR* (2005).
- ☐ **Adaptación española:** Héctor González Ordi (Universidad Complutense de Madrid) y Pablo Santamaría Fernández (Dpto. I+D de TEA Ediciones), 2009.
- ☐ **Aplicación:** Individual o colectiva.
- ☐ **Ámbito de aplicación:** Adultos.
- ☐ **Duración:** 10-15 minutos, aproximadamente.
- ☐ **Finalidad:** Instrumento de *screening* para la detección de simulación de sintomatología psicopatológica y neurocognitiva.
- ☐ **Baremación:** Puntos de corte para sospecha de simulación.
- ☐ **Material:** Manual, ejemplar de la prueba y clave de acceso (PIN) para la corrección por Internet.

1. Introducción y descripción general

El *Inventario estructurado de simulación de síntomas* (SIMS) es una prueba de autoinforme de 75 ítems diseñada con carácter multiaxial para ser utilizada como instrumento de *screening*¹ en la detección de la simulación, tanto en contextos clínicos como forenses. Su interpretación debe ser realizada por profesionales de la salud con un adecuado entrenamiento en la evaluación de casos donde se sospecha la posibilidad de simulación. El SIMS es una herramienta útil porque proporciona datos convergentes en la evaluación de la simulación y, al mismo tiempo, ayuda a determinar si es necesario realizar una evaluación más extensa y exhaustiva.

1.1. Definición, evaluación y tasas de prevalencia de la simulación

1.1.1. Definición de la simulación

La *American Psychiatric Association* (1980) definió oficialmente el término «simulación» en la tercera edición del *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* (DSM-III). Previamente, la ausencia de una definición oficial había favorecido la existencia de debates en torno a si la simulación era un verdadero trastorno mental o no (Bleuler, 1924, 1951; Eissler, 1951; Szasz, 1956; Wertham, 1949). El DSM-III establece que la simulación no es un trastorno mental *per se*, sino que debe entenderse como una condición que es «objeto de atención o tratamiento» (p. 331). En otras palabras, aunque la simulación no es un trastorno mental, presenta claras implicaciones psicológicas. Atendiendo a la nosología actual de la cuarta edición del *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales* (DSM-IV; *American Psychiatric Association*, 1994), la simulación se define como «la producción intencional de síntomas físicos o psicológicos falsos o exagerados, motivados por incentivos externos» (p. 683). Además, el DSM-IV indica a los clínicos que «sospechen firmemente» de la presencia de simulación cuando cualquier combinación de los siguientes indicadores esté presente:

1. Presentación en un contexto médico-legal.
2. Discrepancia acusada entre el estrés o la alteración explicados por la persona y los datos objetivos de la exploración médica.

1. **Nota de los adaptadores.** Mantenemos el uso del término inglés *screening* debido a su amplia aceptación en el campo de la salud. El término se refiere al uso de una estrategia para identificar síntomas y signos clínicos de manera temprana, rápida y eficaz, con el fin de que se reduzcan sus efectos adversos sobre la población.



3. Falta de cooperación durante la valoración diagnóstica e incumplimiento del régimen de tratamiento prescrito.
4. Presencia de trastorno antisocial de la personalidad.

Entre las condiciones diferenciales que deben considerarse en el caso de la simulación, se encuentran los trastornos facticios, motivados por incentivos internos (p. ej., asumir el «papel de enfermo»), y los trastornos somatoformes, cuya manifestación y sintomatología generalmente no se produce de forma intencional.

1.1.2. Aplicación de la definición e indicadores en el proceso de evaluación

La definición y los indicadores de sospecha de simulación establecidos en el DSM-IV han demostrado ser «minimalistas y de difícil aplicación» cuando se evalúa la presencia de simulación (Cunniën, 1997; p. 42), y algunos investigadores han afirmado que estos estándares son vagos e inadecuados (Hutchinson, 2001). La dificultad inherente al uso de estos estándares se centra en la determinación de la motivación interna frente a la externa, así como en la evaluación del grado en que la producción de los síntomas es voluntaria y en la suficiencia de los supuestos incentivos. Para complicarlo aún más, se debe tener en cuenta la variabilidad de los incentivos externos en diferentes circunstancias. Los distintos tipos de motivaciones externas pueden influir en la presentación de la simulación, como, por ejemplo, los esfuerzos para evitar un encausamiento judicial (Resnick, 2003) o los esfuerzos para obtener indemnizaciones económicas (Rogers, 1997). Adicionalmente, el DSM-IV sugiere que la presencia del trastorno de personalidad antisocial es un indicador potencial de simulación, a pesar de que en la actualidad no existe evidencia empírica que apoye dicha asociación (Rogers, Gillis y Bagby, 1990). En conjunto, estos aspectos han llevado a los clínicos a cuestionar la utilidad de basarse únicamente en los criterios DSM-IV para la evaluación de la simulación. Una meta-revisión de 1.040 estudios sobre simulación concluye que los criterios DSM-IV son demasiado limitados en su definición para ser considerados suficientemente fiables (Gerson, 2002). En consecuencia, el empleo aislado de los criterios diagnósticos DSM-IV puede llevar a incrementar el diagnóstico de falsos positivos por simulación (Rogers, 1990).

1.1.3. Modelos alternativos de evaluación

Como respuesta a las limitaciones de los criterios DSM-IV en la evaluación de la simulación, se han propuesto modelos alternativos que enfatizan específicamente el examen detallado de los datos de las pruebas y la concurrencia de la información antecedente disponible. DeClue (2002) apunta que «ninguna puntuación aislada o combinación de puntuaciones en un test» puede determinar por sí misma la presencia de simulación (p. 724), y recomienda la obtención de la mayor cantidad de datos posibles antes de establecer cualquier tipo de hipótesis. Rogers (1997) insiste en el uso tanto de un *modelo de umbral* como de un *modelo de decisión clínica* en el proceso de evaluación. El modelo de umbral implica detectar indicadores cualitativos durante el proceso de obtención de datos que lleven a una evaluación rigurosa de la posibilidad de simulación. Estos indicadores varían en función de la naturaleza de la condición que es objeto de simulación (p. ej., presencia de alucinaciones continuas en vez de intermitentes en el caso de una psicosis simulada). El modelo de decisión clínica estudia criterios explícitos que puedan conducir al diagnóstico de simulación. Por ejemplo, Rogers apunta que para que un criterio clínico produjera un diagnóstico firme de simulación debería implicar «una clasificación precisa del 90% o más de las personas evaluadas basada en amplios estudios de validación cruzada (...) hallazgos que sean congruentes con las teorías aceptadas» (p. 14). Estos modelos de evaluación permiten el estudio de mejor ajuste lineal no sesgado de la información y los datos disponibles durante el proceso de evaluación y, al mismo tiempo, permiten generar hipótesis de comprobación alternativas (Borum, Otto y Holding, 1993). Esta perspectiva basada en los datos difiere de lo que Rogers y Shuman (2000) describen como «modelo de comprobación de hipótesis», donde el diagnóstico de la conducta del individuo se formula al principio de la evaluación y es confirmado o refutado a través del proceso de evaluación subsiguiente.



El SIMS incorpora indicadores de umbral dentro de sus estrategias para la detección de simulación que han demostrado ser criterios explícitos de detección. También se recomienda el SIMS como parte integrante de un enfoque más amplio en el proceso de evaluación en el que se consideren hipótesis alternativas al patrón de respuestas evaluado. La obtención de información es parte del proceso global de evaluación en donde también se consideran los datos que mejor se ajusten al modelo. El empleo del SIMS en combinación con otros datos provenientes de otros instrumentos de evaluación, dentro de un contexto de evaluación amplia y extensa, es consistente con las recomendaciones de Hutchinson (2001) referidas a que la simulación debería ser multideterminada y, por lo tanto, requiere de más que una estrategia unidimensional para su detección. Tal y como apunta DeClue (2002), «las pruebas psicológicas, incluso aquellas con excelente sensibilidad y especificidad, no pueden sustituir a la investigación cuidadosa por parte del evaluador» (p. 724). Este enfoque puede reducir o eliminar muchos de los errores de juicio que se han producido en el proceso de toma de decisión diagnóstica, como los sesgos retrospectivos² (Weeding y Faust, 1989).

1.1.4. Ámbitos y prevalencia de la simulación

La prevalencia de la simulación es significativa y varía en función de los diferentes contextos, con estimaciones de las tasas probablemente atenuadas debido a que los simuladores exitosos consiguen evitar su detección. En muestras forenses, las tasas varían entre un 15,7% (Rogers, Sewell y Goldstein, 1994) y un 45% (Norris y May, 1998), con una tasa media, para este tipo de muestras, estimada en un 17,4% (Rogers, Salekin, Sewell, Goldstein, y Leonard, 1998). En los casos de lesión por traumatismo craneoencefálico, Martens, Donders y Millis (2001) informan de una incidencia de simulación de un 11%, aunque otros sugieren tasas tan elevadas como un 40% (Larrabee, 2003). En los casos de trastorno por estrés post-traumático que buscan recibir indemnizaciones, la tasa de simulación se ha estimado en un 75% (Burkett y Whitley, 1998), aunque otros estudios presentan tasas de simulación de un 7% en la población de pacientes psiquiátricos en general (Rogers, *et al.*, 1994; Rogers, *et al.*, 1998). Less-Haley (1997), utilizó los datos de los perfiles de 492 participantes que cumplimentaron el *Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota 2* (MMPI-2; Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen y Kaemmer, 1989) para investigar la incidencia de simulación en casos de daños o lesiones corporales, determinando que la prevalencia oscilaba entre un 20% y un 30%. Estas tasas son consistentes con los hallazgos de otros investigadores al examinar la incidencia de simulación en casos de lesiones o daños corporales (p. ej., Green, Rohling, Lees-Haley y Allen, 2001; Langeluddecke y Lucas, 2003).

Mittenberg, Patton, Canyock y Condit (2002) realizaron una encuesta a 131 miembros de la *American Board of Clinical Neuropsychology* con el fin de obtener tasas de prevalencia para la simulación en distintos contextos y áreas geográficas. A pesar de que la tasa de respuesta resultó un tanto decepcionante (fue de un 35%), los investigadores no encontraron diferencias significativas ni entre regiones geográficas, ni entre contextos de aplicación. Más bien, las mayores tasas de probable simulación estaban relacionadas con otro tipo de factores como la fuente de remisión (esto es, abogados defensores y compañías aseguradoras, fiscales en causas criminales, etc.). Los autores informaron de tasas de probable simulación y exageración de síntomas de un 29% en casos de lesiones o daños corporales, un 30% en reclamaciones por discapacidad, un 19% en casos criminales y un 8% en casos médicos.

2. **Nota de los adaptadores:** *Sesgo retrospectivo:* considerar, una vez conocido un resultado, que la probabilidad de que ocurriese el resultado, y no otros, era muy alta.



1.2. Instrumentos para la detección de la simulación

1.2.1. Entrevistas y tests

Existen tres tipos de instrumentos utilizados para la detección de la simulación: (a) entrevistas estructuradas, (b) instrumentos psicológicos generales o cognitivos y (c) pruebas o tests específicamente diseñados para la detección de simulación.

En relación con las entrevistas estructuradas, probablemente los dos instrumentos que han recibido una mayor atención sean la *Structured Interview of Reported Symptoms* (SIRS; Rogers, Bagby y Dickens, 1992) y la *Schedule of Affective Disorder and Schizophrenia* (SADS; Spitzer y Endicott, 1975). La SIRS utiliza una variedad de estrategias alternativas para detectar la presencia de simulación (p. ej., presencia de síntomas excepcionales o poco frecuentes, presencia de síntomas indiscriminados, presencia de síntomas obvios y descartados, presencia de síntomas improbables, etc.). La SADS pregunta sobre la naturaleza de los síntomas, centrándose especialmente en la consistencia sintomatológica como estrategia principal para la detección de simulación. Un estudio posterior de Rogers, Jackson, Salekin y Neumann (2003) condujo a la elaboración de escalas para la SADS (Combinación de síntomas y Selectividad de los síntomas) que han demostrado una eficacia moderada. Aunque «las entrevistas estructuradas representan un avance fundamental en la evaluación sistematizada de los trastornos y síntomas del Eje I» (Rogers, Jackson, *et al.*, 2003; p. 281), este método exige mucho tiempo y que el evaluador posea un buen entrenamiento.

Muchos instrumentos de evaluación objetiva de la personalidad presentan índices de validez que han demostrado ser útiles en la detección de la simulación, incluyendo el MMPI-2 (Elhai *et al.*, 2004; Guriel y Fremouw, 2003; Rogers, Sewell, Martin y Vitacco, 2003), y el *Inventario de evaluación de la personalidad* (PAI; Morey, 1991) (Calhoun, Earnst, Tucker, Kirby y Beckham, 2000). Sin embargo, otros como el *Inventario Clínico Multiaxial de Millon III* (MCMI-III; Millon, Millon y Davis, 1994) han demostrado resultados menos prometedores. Por ejemplo, Schoenberg, Dorr y Morgan (2003) calcularon la validez predictiva del MCMI-III para la detección de simulación, utilizando el punto de corte recomendado por Millon *et al.* (puntuación directa mayor de 178 en la Escala X), encontrando un valor predictivo positivo (VPP) de 0,0, y un valor predictivo negativo (VPN) de 63,1, así como una eficacia del test en total de solamente un 63,1%.

Los instrumentos de evaluación cognitiva se han utilizado también para detectar simulación. Varios de estos instrumentos han demostrado su eficacia, como es el caso del *California Verbal Learning Test* (CVLT; Delis, Kramer, Kaplan y Ober, 1987) (Sweet *et al.*, 2000), la *Escala de Memoria de Wechsler, tercera edición* (WMS-III; Wechsler, 1997b) (Langeluddecke y Lucas, 2003), el test de la *Figura Compleja de Rey*, el *Ensayo de Reconocimiento* (Meyers y Meyers, 1995) (Lu, Boone, Cozolino y Mitchell, 2003), el *Trial Making Test* de la *Batería Neuropsicológica Halstead-Reitan* (TMT; Reitan y Wolfson, 1985) (O'Bryant, Hilsabeck, Fisher y McCaffrey, 2003) y el *Test de palabras y colores, Stroop* (Golden, 1978) (Cannon, 2003). El empleo de pruebas combinadas también ha demostrado ser eficaz. (p. ej., Larrabee, 2003). Por ejemplo, Meyers y Volbrecht (2003) utilizaron nueve instrumentos de evaluación neuropsicológica, obteniendo un 83% de sensibilidad y un 100% de especificidad en una muestra de 796 sujetos litigantes. Investigadores como Rogers, Harrell y Liff (1993), Rohling, Langhinrichsen-Rohling y Miller (2003) y Williams (1998), han propuesto un conjunto de estrategias recomendables para ser utilizadas en el contexto de la evaluación neuropsicológica.

No obstante, a pesar de que tanto los instrumentos de evaluación objetiva de la personalidad como los instrumentos de evaluación cognitiva pueden resultar eficaces en la detección de la simulación, existen también ciertas limitaciones respecto a su utilización: (a) su aplicación conlleva mucho tiempo, (b) además requiere de un entrenamiento especializado y (c) a menudo son pruebas complejas de interpretar (Schinka y Forum, 1993, 1994).



1.2.2. Medidas de screening

En los últimos años, se han desarrollado un cierto número de instrumentos de *screening* para detectar simulación (puede encontrarse una revisión en Smith, 1997). Algunas medidas han sido específicamente desarrolladas para determinar la presencia de psicopatología general simulada (p. ej., el *Miller Forensic Assessment of Symptoms Test*, M-FAST; Miller, 2001) mientras que otras se han diseñado para situaciones específicas o dificultades particulares. Por ejemplo, el *Evaluation of Competency to Stand Trial-Revised* (ECST-R; Rogers, Tillbrook y Sewell, 2004) ha mostrado resultados prometedores como medida de *screening* en contextos forenses en los que es necesario establecer la competencia del individuo para ser juzgado (Rogers, Jackson, Sewell y Harrison, 2004). El *Test of Cognitive Abilities* (TOCA; Bender y Rogers, 2004) ha demostrado ser eficaz para identificar sujetos que simulan deterioro neurocognitivo. El M-FAST, un instrumento de 25 ítems desarrollado para evaluar simulación de psicopatología, obtuvo correlaciones altas con la SIRS y los índices de validez del MMPI-2 en una muestra de 50 acusados que fueron encontrados no competentes para ser juzgados (Miller, 2004). Finalmente, el *Test of Memory Malingering* (TOMM; Tombaugh, 1996) es un instrumento de *screening* que se utiliza para detectar simulación de síntomas neuropsicológicos.

1.3. El SIMS como prueba de *screening* para la detección de la simulación

Tal y como se afirmaba al inicio de este capítulo, el SIMS es una prueba de autoinforme de 75 ítems diseñada con carácter multiaxial para ser utilizada como instrumento de *screening* en la detección de la simulación de sintomatología psicopatológica y de alteraciones neurocognitivas, tanto en contextos clínicos como forenses. El SIMS es una herramienta útil porque proporciona datos convergentes en la evaluación de la simulación y, al mismo tiempo, ayuda a determinar si es necesario realizar una evaluación más extensa y exhaustiva.

Aunque instrumentos como el M-FAST han demostrado su utilidad en contextos clínicos (Miller, 2004), no es menos cierto que resulta necesario un instrumento que explore más de una faceta que la psicopatológica (p. ej., memoria/deterioro neurológico), porque los simuladores a menudo falsean síntomas en más de una condición. El SIMS está diseñado para evaluar síntomas tanto referidos al falseamiento de psicopatología como de funciones cognitivas (véase la tabla 1.1 referida a las escalas del SIMS). Más aún, el SIMS puede utilizarse en conjunción con otras medidas más generales de simulación para proporcionar datos convergentes, así como para ofrecer al clínico alternativas a los instrumentos disponibles. La mejor práctica clínica implica el uso de criterios diagnósticos múltiples en oposición a la utilización de un único test (Slick, Sherman y Iverson, 1999), así como la utilización de enfoques evaluativos que incluyan la combinación de tests especializados e indicadores de validez (Iverson, 2003).



Tabla 1.1: Descripción de las escalas y la puntuación total del SIMS

Escala	Descripción
Psicosis (Ps) (15 ítems)	Evalúa el grado en que el sujeto presenta síntomas psicóticos inusuales o extravagantes que no son típicos de la patología psicótica real.
Deterioro neurológico (Dn) (15 ítems)	Evalúa el grado en que el sujeto presenta síntomas de tipo neurológico ilógicos o muy atípicos.
Trastornos amnésicos (Am) (15 ítems)	Evalúa el grado en que el sujeto presenta síntomas relacionados con trastornos de memoria que son inconsistentes con los patrones de deterioro producidos por disfunción o daño cerebral real.
Baja inteligencia (Bi) (15 ítems)	Evalúa el grado en que el sujeto exagera su déficit intelectual al fallar preguntas sencillas de conocimiento general.
Trastornos afectivos (Af) (15 ítems)	Evalúa el grado en que el sujeto informa de síntomas atípicos de depresión y ansiedad.
Total (75 ítems)	Ofrece una puntuación resumen del nivel de simulación general.

1.3.1. Ámbito de aplicación del SIMS y limitaciones de la prueba

El SIMS se ha concebido para ser aplicado a adultos mayores de 18 años y se ha validado en muestras clínicas forenses, muestras clínicas psicopatológicas y muestras no clínicas. Las muestras utilizadas para su validación están formadas por adultos de ambos sexos, de diferentes edades y condiciones. Como resultado, el SIMS es un instrumento apropiado para explorar simulación de síntomas psicopatológicos y neurocognitivos en un amplio rango de contextos (p. ej., evaluaciones forenses, neuropsicológicas y médico-legales) y condiciones (ambulatorias, ingreso, instituciones psiquiátricas o penitenciarias, etc.).

Los profesionales que utilicen el SIMS deben tener en cuenta las siguientes limitaciones:

1. El SIMS es una prueba de *screening* de simulación de síntomas psicopatológicos y neuropsicológicos. Consecuentemente, el diagnóstico de simulación no debe hacerse únicamente de acuerdo a las puntuaciones obtenidas en el SIMS. Si los resultados del SIMS sugieren la posibilidad de simulación, acorde con los puntos de corte recomendados, el profesional debería proceder a realizar una evaluación más extensa y exhaustiva de la simulación. Específicamente, cuando se sospecha de simulación psicopatológica, puede ser interesante aplicar adicionalmente una entrevista estructurada validada, como la SIRS, con el fin de evaluar más pormenorizadamente la sintomatología existente. Medidas neuropsicológicas específicas, como el *Victoria Symptom Validity Test* (VSVT; Slick, Hopp, Strauss y Thompson, 1997) pueden aplicarse adicionalmente para obtener mayor información que apoye la hipótesis de simulación de síntomas neurocognitivos. La determinación de simulación solamente debe hacerse en el contexto de una evaluación extensa y exhaustiva, mediante la convergencia de diferentes fuentes de información que apoyen el diagnóstico, incluyendo la historia médica, psicosocial y psiquiátrica, la entrevista clínica, la comparación entre la información subjetiva de los síntomas y las pruebas y observaciones objetivas, los resultados de los cuestionarios psicológicos y de las pruebas específicas para detectar simulación, etc.



2. La discapacidad cognitiva significativa o los estados psicóticos severos pueden ser impedimentos a la hora de aplicar el SIMS. La persona evaluada debe ser capaz de: (a) prestar atención a lo largo del proceso de evaluación, (b) leer y comprender los ítems escritos en el ejemplar de la prueba y (c) responder a las preguntas del test. En algunos casos, la persona evaluada puede mostrar un déficit cognitivo genuino, como el retraso mental, y ser incapaz de completar el SIMS. En otras situaciones, la persona examinada puede presentar episodios de agitación o incoherencia, extremos atribuibles tanto a un trastorno mental genuino como a una posible simulación. En tales casos es recomendable la observación detallada del paciente, puesto que este tipo de auto-presentación extrema es difícil de mantener durante largos períodos de tiempo si el individuo es un simulador.
3. Si bien la utilidad del SIMS para la identificación de simuladores se ha comprobado en estudios con simuladores diagnosticados previamente frente a pacientes clínicos no simuladores, tanto en estudios internacionales como en estudios específicos con la adaptación española, es necesario seguir investigando con esta metodología más ampliamente y en diferentes contextos.
4. Aunque existe algún estudio forense con adolescentes (Rogers, Hinds y Sewell, 1996), es necesario un mayor esfuerzo investigador para ampliar y adaptar el SIMS a poblaciones de niños o adolescentes.

1.3.2. Requisitos profesionales para el uso del SIMS

El SIMS puede ser aplicado y corregido por personas sin una formación específica en psicología o psiquiatría forense, psicología clínica, psicoterapia o áreas relacionadas. El examinador deberá seguir cuidadosamente las instrucciones de aplicación y corrección que figuran en el capítulo 2 de este manual antes de aplicar el instrumento.

No obstante, de acuerdo con las normas del *Standards for Educational and Psychological Testing* (American Educational Research Association, American Psychological Association y National Council on Measurement in Education, 1999), la interpretación de la prueba y de los perfiles resultantes requiere una adecuada formación en psicología o psiquiatría forense, psicología clínica, psicoterapia o áreas relacionadas, así como un conocimiento extenso en la interpretación de pruebas psicológicas.

La utilidad y validez del SIMS dependen en buena medida de la cualificación y competencias del profesional o profesionales que utilicen este instrumento.

1.3.3. Seguridad y confidencialidad

Las personas que utilicen el SIMS son responsables de mantener la seguridad y confidencialidad del instrumento, tal y como se establece en los *Standards for Educational and Psychological Testing* (American Educational Research Association, American Psychological Association y National Council on Measurement in Education, 1999).

Toda la información referida a los ítems, puntos de corte recomendados, procedimiento de aplicación y corrección y las estrategias utilizadas en la prueba para la detección de simulación se considera sensible y confidencial. La exposición de dicha información a personas sin la cualificación adecuada puede comprometer seriamente la utilidad y validez del instrumento. Así, es muy importante que esta información no esté disponible en Internet, incluyendo páginas web, chats o listas profesionales. Igualmente, debe ponerse especial cuidado a la hora de presentar los resultados del SIMS en informes forenses, neuropsicológicos, psicológicos o psiquiátricos y médico-legales, con el fin de evitar que una amplia audiencia potencial no cualificada pueda tener acceso a los contenidos sensibles de la prueba. En el caso de que se detecte algún fallo en la



seguridad y confidencialidad de la prueba, deberá informarse a los **colegios profesionales** correspondientes o al editor de la adaptación de la prueba (TEA Ediciones) para que pueda subsanarse.

1.3.4. Materiales del SIMS

En el capítulo 2 se incluyen instrucciones específicas para proceder a la aplicación y corrección del SIMS. Los materiales que componen esta obra son los siguientes:

- S Manual.** En él aparecen las instrucciones de aplicación, corrección e interpretación de las puntuaciones que se deberán seguir para un correcto uso del SIMS. Además, se incluye la fundamentación teórica y estadística de la prueba.
- S Ejemplar de la prueba.** Contiene los elementos de la prueba y el espacio para dar la respuesta a cada uno de ellos. Los sujetos evaluados anotan en el ejemplar sus datos de identificación y sus respuestas a la prueba.
- S Clave de acceso (PIN) para la corrección por Internet.** Esta hoja contiene el código de acceso necesario para realizar la corrección del SIMS por Internet mediante *e-perfil*. Contiene también unas breves instrucciones sobre el uso de este sistema de corrección.

2. Normas de aplicación y corrección

2.1. Normas de aplicación

Para la aplicación del SIMS se requiere únicamente del ejemplar de la prueba y un bolígrafo o lapicero para anotar las contestaciones en el propio ejemplar de la prueba.

La habitación en la que se realice la aplicación deberá tener una ventilación e iluminación adecuadas. Asimismo se deberá asegurar la ausencia de distracciones durante el transcurso de la evaluación (ruidos, interrupciones, etc.) y garantizar la confidencialidad de las respuestas dadas. El SIMS debe ser preferiblemente aplicado individualmente para evitar, en la medida de lo posible, las potenciales influencias sociales de las evaluaciones colectivas.

La persona evaluada deberá rellenar en primer lugar los datos personales que se les solicite en los espacios dispuestos para ello en el ejemplar. Las instrucciones específicas necesarias para responder a la prueba aparecen en la propia portada del ejemplar. El examinador deberá enfatizar la necesidad de que se responda a todos los ítems que aparecen, sin dejar ninguno en blanco. El profesional dará al sujeto unas indicaciones generales que no revelen el propósito específico de la prueba. Las siguientes instrucciones, que aparecen a modo de ejemplo, pueden ser utilizadas como guía.

Las preguntas que va a tener que responder a continuación nos ayudarán a comprender mejor cómo se encuentra en este momento. Son preguntas estándar sobre distintas y variadas experiencias que las personas pueden llegar a tener. Puede que algunas se apliquen a su caso y otras no. Por favor, lea cada una de ellas y decida si habitualmente son ciertas en su caso o no. Por favor, responda a todos los ítems, incluso aunque alguno le resulte difícil o parezca no aplicarse a usted.

Si una persona evaluada pide aclaraciones acerca del contenido de algún ítem, podrá leerse en voz alta con él, pero no podrá darse ninguna explicación o interpretación del mismo. Con el objetivo de estandarizar las condiciones de aplicación, el examinador deberá mostrar al sujeto evaluado su interés en la comprensión que el propio sujeto haga del contenido del ítem.

Se tarda aproximadamente entre 10 y 15 minutos en responder al SIMS, aunque aquellos individuos que tratan de falsear conductas psicopatológicas pueden requerir algo más de tiempo. Una vez que la persona evaluada acabe la prueba, el profesional deberá revisar que haya respondido a todos los ítems y que lo haya hecho correctamente (por ejemplo, que no aparece marcado simultáneamente verdadero y falso en un mismo ítem). Si se diera alguno de estos casos, se le pediría al sujeto evaluado que responda a los ítems omitidos.



o que subsane los defectos encontrados (p. ej., que se decida por una de las dos alternativas en aquellos ítems con doble respuesta).

Aunque debe pedirse al sujeto evaluado que complete cualquier ítem previamente omitido, el evaluado puede indicar que es incapaz de responder a dicho ítem ya que no se aplica a su caso. En ese caso, el ítem omitido debe codificarse como «0». No obstante, el rechazo a responder o la incapacidad manifiesta para hacerlo pueden ser tenidas en cuenta y considerar la posibilidad de que dicha resistencia a responder refleje un intento deliberado de simulación.

Ha de tenerse en cuenta que la presencia de ítems omitidos en el cuestionario puede afectar a los resultados que se obtengan, por lo que es importante que el evaluado responda a todas las preguntas y no deje en blanco ningún ítem. Es responsabilidad del aplicador asegurarse de este aspecto antes de proceder a su corrección y tener en cuenta que su presencia puede afectar a la interpretación de los resultados que se obtengan (incluso con un número relativamente pequeño como tres respuestas en blanco). En todo caso, si en el conjunto del inventario hay más de 15 respuestas en blanco, se considerará un protocolo no válido y el sistema de corrección no permitirá la obtención de las puntuaciones.

2.2. Normas de corrección

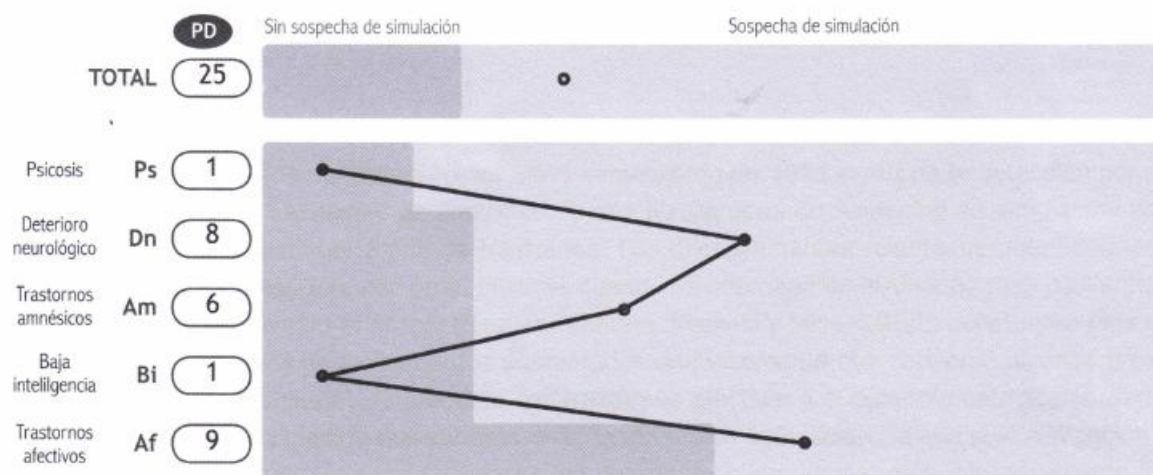
Una vez que la prueba ha sido cumplimentada se procede a su corrección. En el caso del SIMS se ha optado por ofrecer procedimientos de corrección automática que reduzcan al máximo tanto el tiempo que el profesional debe emplear en tareas mecánicas como el número de errores que se cometen en este tipo de labores. También se protege de este modo la plantilla del instrumento, aspecto especialmente sensible en el caso de una prueba de este tipo.

El procedimiento de corrección del SIMS se realiza mediante Internet. En este caso el profesional únicamente deberá seguir las instrucciones que aparecen en la hoja con el código de acceso para la corrección que se entrega al adquirir los ejemplares del SIMS. Una vez que haya accedido al sistema de corrección, el profesional únicamente deberá introducir las respuestas dadas por el sujeto en el ejemplar y el sistema realizará todas las labores de corrección y puntuación de las distintas escalas. También generará finalmente un perfil gráfico con las puntuaciones obtenidas por la persona evaluada y su posición con respecto a los puntos de corte establecidos, además de ofrecer un breve informe interpretativo de dichas puntuaciones. En la figura 2.1 puede observarse un ejemplo del perfil obtenido con este sistema de corrección. Puede advertirse cómo obtiene puntuaciones superiores a los puntos de corte (y por lo tanto dentro del área de sospecha de simulación) tanto en el Total como en las escalas Deterioro neurológico, Trastornos amnésicos y Trastornos afectivos. En el capítulo 5 de este manual el profesional podrá encontrar información detallada sobre cómo proceder a interpretar los resultados obtenidos en la prueba.



Figura 2.1. Perfil del SIMS de D.F.B.

PERFIL		Nombre: D.F.B.
		Edad: 49 años Sexo: Mujer Fecha de aplicación: 02/04/2009
		Baremo: Adaptación española
		Responsable de la aplicación:



La puntuación total en el SIMS resulta superior a la recomendada como punto de corte para determinar la existencia de sospecha de simulación. El individuo contesta con frecuencia a ítems referidos a síntomas atípicos en pacientes con trastornos psicopatológicos o neurocognitivos genuinos, lo que hace sospechar que pueda estar simulando. El perfil del SIMS refleja un patrón centrado en la presentación de síntomas de tipo neurológico ilógicos o muy atípicos, síntomas relacionados con trastornos de memoria que son inconsistentes con los patrones de deterioro producidos por disfunción o daño cerebral real y síntomas atípicos de depresión y ansiedad. Se recomienda una evaluación más extensa y exhaustiva con el fin de confirmar esta sospecha.



TEA Ediciones

Copyright © 2009 by TEA Ediciones, S.A.
Informe generado desde www.teacorrige.com
Prohibida la reproducción total o parcial. Todos los derechos reservados.

3. Proceso de construcción original de la prueba y adaptación española

Los trabajos originales de construcción del SIMS comenzaron en 1991 a raíz de la detección por parte de sus autores de la necesidad de contar con una nueva prueba de *screening* de simulación de síntomas que cubriera distintas áreas de trastornos. Los decepcionantes resultados obtenidos, en términos de tasas de detección, con otras pruebas cuando se utilizaban en el «mundo real» (Gillis, Rogers y Bagby, 1991), como por ejemplo el *M test* (Beaber, Marston, Michelli y Mills, 1985), acentuaron esta necesidad. Además, no se disponía de instrumentos sustentados empíricamente que cubrieran algunas áreas de simulación como eran los problemas de memoria, los trastornos afectivos y el deterioro neurológico. También era deseable disponer de una medida que cubriera distintas áreas de simulación, ya que la investigación existente sobre este tema mostraba que habitualmente las personas solían simular más de un trastorno o condición (p. ej., Anderson, Trethowan y Kenna, 1956; Hunt y Older, 1943; Schretlen, 1987). Aunque más recientemente habían aparecido nuevos instrumentos con un sólido respaldo empírico (p. ej., SIRS), habitualmente requerían un amplio tiempo de aplicación y un cierto nivel de sofisticación en su aplicación y corrección. Era necesario disponer de una prueba más breve y sencilla que a su vez ofreciera unas adecuadas tasas de detección de simulación en los estudios empíricos que con ella se realizaran. Con este objetivo se creó el SIMS, con el de ofrecer una prueba breve, fiable y válida de la simulación de distintas áreas de síntomas psicológicos y neuropsicológicos.

3.1. Construcción de los ítems

En una primera fase de desarrollo del SIMS (Smith, 1993), se construyó un banco inicial de 200 ítems a partir de la revisión de la literatura científica sobre las características cualitativas de los simuladores (Anderson *et al*, 1956; Drob, Berger y Weinstein, 1987; Goodwin, Alderson y Rosenthal, 1971; MacDonald, 1976; Ossipov, 1944; Resnick, 1984; Rogers, 1988; Seamons, Howell, Carlisle y Roe, 1981; Seigel y West, 1975; Wachspress, Berengerg y Jacobson, 1953) y de los instrumentos existentes que evaluaban específicamente simulación (p. ej., SIRS, *M Test*) o que contenían escalas de validez para evaluar estilos de respuesta (p. ej., MMPI). Cada ítem potencial fue creado y modificado de acuerdo a la demostración empírica de su habilidad distintiva para caracterizar una de las cinco áreas de simulación recogidas (esto es, psicosis, deterioro neurológico, amnesia, baja inteligencia y trastornos afectivos), avalada al menos por los resultados de dos estudios independientes.



3.2. Selección de los ítems y construcción de las escalas

El siguiente paso que se siguió en la construcción del SIMS (Smith, 1993) fue solicitar a nueve psicólogos clínicos que clasificaran cada uno de los ítems iniciales en cinco categorías diferentes de patologías (psicosis, trastornos afectivos, problemas de memoria, deterioro neurológico, baja inteligencia, otra categoría, combinaciones de categorías anteriores). Aquellos ítems en los que el acuerdo fue igual o superior a dos tercios (un 66,7%) fueron asignados a dicha categoría. Aquellos que no obtuvieron este nivel de acuerdo fueron descartados. Aunque existía la opción de clasificarlos en otras categorías creadas ex profeso para el ítem, ninguna categoría nueva generada alcanzó un índice de acuerdo de dos tercios en ningún ítem. Este procedimiento fue seguido con el objetivo de establecer un primer cribaje de los ítems que no fuera arbitrario y que a su vez contribuyera a la validez de constructo de las escalas. Este mismo procedimiento es el que han seguido otros investigadores en el desarrollo de múltiples pruebas, tales como la escala Obvio-Sútil del MMPI (Weiner, 1948), la *Escala de dependencia* (Navran, 1954) o el *M test* (Beaber, Marston, Michelli y Mills, 1985).

Una vez establecida esta primera clasificación, se seleccionaron los 15 ítems de cada escala que mayores porcentajes de acuerdo mostraban. Dado que se pretendía partir de un número igual de ítems por escala y que la escala que menor número de ítems tenía (Deterioro neurológico) era 15, se estableció este número de ítems por escala. Aunque el criterio inicial fue del 66,7% de acuerdo, los ítems finalmente seleccionados en esta fase mostraron índices de acuerdo interjueces iguales o superiores al 88,9%.

Los valores de acuerdo interjueces obtenidos en cada una de las escalas (Cohen, 1960; Fleiss, 1971, 1981) fueron de 0,89 en la escala Psicosis, 0,94 en Trastornos afectivos, 0,76 en Deterioro neurológico, 0,83 en Trastornos amnésicos y 0,78 en Baja inteligencia. De acuerdo a Lansis y Koch (citados en Fleiss, 1981) valores de 0,75 «pueden considerarse como índices de acuerdo excelentes más allá de los valores esperados por azar» (p. 218).

3.3. Muestra empleada en los estudios originales

La versión original del SIMS fue aplicada inicialmente en un estudio de análogos (véase capítulo 4 para una explicación de este tipo de estudios) a una muestra de 476 universitarios procedentes de facultades diferentes de cuatro universidades distintas de Estados Unidos (Smith, 1993). Los estudiantes participaron voluntariamente a cambio de la convalidación de clases. La media de edad de los participantes fue de 24,4 años (rango de 17 a 66 años), siendo la mayoría de ellos mujeres (71%) y de los dos primeros cursos universitarios (53,4% de primer curso y 34,2% de segundo curso). Los ingresos por familia tuvieron una moda comprendida entre 30.000 y 40.000 dólares anuales (rango de 0 a más de 100.000 dólares).

Los participantes en el estudio fueron asignados aleatoriamente al grupo control de respuesta honesta o a uno de los siete grupos experimentales: simulación de psicosis, simulación de amnesia, simulación de depresión, simulación de baja inteligencia, simulación de deterioro neurológico y simulación de mal estado general. A cada uno de los grupos de simuladores (a excepción del de simulación de un mal estado general) se les dio una descripción de la condición particular que debían simular (psicosis, amnesia...) así como hipotéticos contextos en los que esta simulación se veía incentivada (p. ej., un delincuente convicto que desea acortar su condena). Al grupo de simulación de mal estado general se le dio unas instrucciones relativamente generales donde simplemente se les pedía que simularan «anormalidad», con el objetivo de disponer, de este modo, de un grupo que emulara el tipo de simulación más investigado en aquel momento y que reflejara la mezcla de síntomas simulados que es habitual encontrarse en contextos clínicos. La existencia de este grupo también permitió comparar las respuestas dadas cuando se simulaban condiciones específicas y cuan-



do simplemente se simulaba «estar mal». A los participantes asignados al grupo control (respuesta honesta) simplemente se les solicitó que respondieran sinceramente a las preguntas de la prueba.

Una vez que los participantes leían las instrucciones específicas a su grupo, respondían al SIMS y a otro conjunto de pruebas de detección de simulación.

A partir de las respuestas de la muestra anteriormente descrita se estableció qué alternativa de cada ítem (esto es, verdadero o falso) puntuaba como indicadora de simulación. Para ello se consideraron las respuestas de cada uno de los seis grupos de simulación. En los ítems de cada escala se puntuaba aquella alternativa que mayor índice de atracción tenía entre su grupo específico de simulación. Así, por ejemplo, para determinar qué alternativa puntuaba en los ítems de la escala de psicosis, se estudiaba qué porcentaje de respuesta había tenido cada alternativa en el grupo de simulación de psicosis y se elegía aquella con un mayor valor. Estos estudios permitieron determinar el sentido de cada ítem y establecer, de este modo, la versión definitiva de la prueba.

3.4. Adaptación española

Al igual que los autores originales hicieron en su momento, los adaptadores sintieron la misma necesidad de solventar la escasa presencia de instrumentos específicos para detectar simulación que estuvieran adecuadamente adaptados a la población española y que mostraran una buena base psicométrica en cuanto a fiabilidad, validez y precisión predictiva se refiere. Téngase en cuenta que la investigación básica y aplicada sobre la detección de simulación es un ámbito de interés relativamente reciente en nuestro país y que existen muy pocos instrumentos de evaluación disponibles para ayudar al profesional a realizar dicha tarea. Como ejemplo, la primera selección monográfica de trabajos profesionales y de investigación sobre la detección de simulación en una revista profesional de gran difusión aparece en 2005 en *Papeles del Psicólogo* (AA.VV., 2005). Así mismo, en la práctica profesional el instrumento de referencia en la detección de simulación es el MMPI-2, pero como argumentan acertadamente Schinka y Borum (1993, 1994) su aplicación conlleva mucho tiempo, se requiere de un entrenamiento especializado y a menudo es una prueba compleja de interpretar. TEA Ediciones ha tratado de facilitar la interpretación del MMPI-2 para los profesionales que no conozcan a fondo dicha prueba mediante sus informes interpretativos informatizados, tanto para el MMPI-2 (González Ordí y Gómez Segura, 2002) como para el MMPI-A (González Ordí, 2005), así como mediante la traducción y edición de textos especializados complementarios (Nichols, 2002). Aún así, la creciente aparición de instrumentos más específicos para la detección de simulación a nivel internacional en las últimas dos décadas (véase Rogers 1997 y 2008b; Rogers y Bender, 2003) y la ausencia de adaptaciones adecuadamente tipificadas en nuestro país, motivaron que TEA Ediciones iniciara una línea de investigación y adaptación de instrumentos específicos en la detección de la simulación que contribuyera a llenar un espacio vacío que se antojaba relevante y cubriera la necesidad de este tipo de evaluación psicológica en contextos forenses, médico-legales y clínicos.

Así, la adaptación española del SIMS surgió con la intención de emular a su original proporcionando a los psicólogos de habla española una herramienta breve, fiable y válida para la detección de la simulación de síntomas psicopatológicos y neurocognitivos, de rápida aplicación, sencilla interpretación y gran versatilidad, adaptándose a las diferentes necesidades que requieran los ámbitos clínico general, médico-legal y forense-pericial.

Los estudios con la adaptación española comenzaron en 2006, un año después de que *Psychological Assessment Resources* editara la prueba en los EE.UU., con una primera traducción del cuestionario y su aplicación a muestras de estudiantes universitarios (González Ordí y Matalobos Veiga, 2006). A partir de ahí, se han rea-



lizado diversos estudios durante estos tres años que han incluido colaboraciones con distintas universidades españolas, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, hospitales, centros de salud mental, asociaciones de pacientes y centros privados de psicología clínica y psicología forense, que han contribuido a obtener una muestra total de más 1.000 casos de distintas procedencias y contextos que son la base de la tipificación española (una descripción detallada de la composición de esta muestra puede encontrarse en el capítulo 4 de este manual).

Los resultados parciales de muchos de estos estudios han ido publicándose en distintas revistas y presentándose en diversos congresos nacionales e internacionales (véase capítulo 4 de este manual). Entre los estudios incluidos realizados para esta adaptación cabe destacar los estudios de validación en los que se comparan los resultados de los grupos control, clínico y simulador en contextos de análogos y en contextos médico-legales, así como aquellos de validez convergente en muestras forenses con pruebas bien establecidas y conocidas de evaluación como son el MMPI-2, el MCMI-II y el MCMI-III.

4. Fundamentación estadística

Las cualidades psicométricas obtenidas en los distintos estudios que se han realizado con el SIMS son las que determinan el grado de confianza que puede tener un profesional en la prueba. En este capítulo se mostrará la información más relevante a este respecto¹.

En primer lugar se informará de las **muestras** utilizadas en los distintos estudios realizados con la adaptación española.

En segundo lugar aparecen los **estudios de fiabilidad** de la prueba. Estos informan de la precisión y exactitud de las puntuaciones obtenidas. Esta información permite responder a las preguntas: *¿Con qué precisión evalúa el SIMS a una persona? ¿Qué grado de error se puede estimar que contienen las puntuaciones obtenidas con el SIMS?*

En tercer lugar aparecen los **estudios de validez**. Estos estudios pretenden responder a la pregunta: *¿Qué inferencias o conclusiones podemos extraer que estén apoyadas empírica y teóricamente a partir de los resultados de la prueba?* Los resultados ofrecidos determinan qué conclusiones e inferencias son oportunas extraer del test y cuáles no, así como la adecuación y pertinencia de las decisiones que se tomen de acuerdo a los resultados obtenidos con el SIMS. Como se mostrará en este apartado, la evidencia acumulada sobre el SIMS es amplia y procede de diversas fuentes: estudios originales, estudios propios realizados en la adaptación española y estudios independientes publicados en revistas y congresos científicos. En este apartado se tratará de sintetizar la información disponible al respecto.

4.1. Muestras empleadas en la adaptación española

Durante el proceso de adaptación española de la prueba se recogió una muestra total de 1.005 casos, con una edad media de 31,9 años ($Dt=13,2$; rango de 17 a 71 años). La muestra estaba compuesta en un 66,4% por mujeres y procedía de 16 centros u organizaciones diferentes que colaboraron en los distintos estudios, entre ellos muchos de los potenciales lugares donde se aplicaría el SIMS (mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, hospitales, centros de salud mental, asociaciones de pacientes y centros privados de psicología clínica y psicología forense).

1. Otros aspectos claves de la fundamentación estadística tales como las fases de creación de la prueba y la selección de elementos han sido ya tratados en el capítulo anterior.



Esta muestra global se utilizó tanto para los estudios de fiabilidad como para el análisis de su estructura interna o factorial. La muestra descrita estuvo en realidad compuesta de muestras específicas destinadas a evaluar aspectos definidos de la validez del SIMS. A continuación se describe cada una de las muestras y sus principales características.

4.1.1. Muestra clínica y de análogos

Las estrategias de investigación que mayor solidez han demostrado en el estudio de la simulación son los diseños de investigación con «análogos» y con grupos diagnósticos (*known-groups*), especialmente si se utilizan combinadamente (Rogers y Bender, 2003).

En los *estudios análogos*, los participantes son asignados de manera aleatoria a las condiciones experimentales de «simulación» y de «control», recibiendo instrucciones específicas acerca del estilo de respuesta que deben adoptar al responder a las pruebas de evaluación. A los participantes asignados a algún grupo de simulación se les pide que actúen «como si» realmente sufrieran el trastorno que se les indica. En este tipo de estudios es recomendable emplear también una muestra clínica para determinar si las diferencias se deben a la simulación o a la existencia de una determinada patología. En el caso de la adaptación española del SIMS se contó con ambos tipos de muestras, tanto la de estudios análogos como la muestra clínica que sirviera de referencia.

La muestra de estudios análogos estaba compuesta por sujetos «normales» (sin patología previa diagnosticada) que fueron asignados aleatoriamente a las condiciones de «control» o «simulación».

La muestra de «controles» fue instruida para que respondieran honestamente a la prueba. Estuvo compuesta por 147 sujetos con edades comprendidas entre los 17 y los 62 años (edad media=23,6; Dt=8,8), siendo un 70,7% mujeres.

La muestra de «simuladores» estuvo compuesta por 326 sujetos con edades comprendidas entre los 17 y los 63 años (edad media =22,5; Dt=6,9), siendo un 75,5% mujeres. Esta muestra total fue subdividida en distintas condiciones experimentales y a cada uno de esos grupos se les instruyó específicamente para que simularan un tipo de trastorno o problema diferente con unos determinados incentivos hipotéticos (p. ej., obtener una indemnización, una baja laboral, una reducción de condena...) acordes al trastorno concreto. En la tabla 4.1 pueden observarse los grupos establecidos. En el apartado de estudios análogos de la adaptación española, que se incluye más adelante en este mismo capítulo, se describen con más detalle cada una de las condiciones simuladas por cada grupo de sujetos.

Tabla 4.1. Composición de la muestra de análogos por grupos experimentales de simulación (N=326).
Datos de la adaptación española

Grupo análogo de simulación	Composición		Edad			Sexo % mujeres
	n	%	Media	Dt	Rango	
Enajenación mental por psicosis	64	20	21,2	6,2	17-51	91
Accidente	120	37	20,4	3,2	17-38	67
Problemas de memoria	6	2	41,3	17,0	25-63	50
Retraso intelectual	45	14	23,6	2,9	21-33	84
Problemas emocionales	53	16	23,7	8,0	19-59	72
Mal estado general	4	1	40,3	5,9	37-49	75
Patología dolorosa	34	10	24,0	8,7	19-55	76
Total	326	100	22,52	6,92	17-63	75,5



La muestra clínica (casos con algún trastorno psicológico o neurológico diagnosticado previamente) fue recogida en centros de salud mental, hospitales, asociaciones de afectados y centros de rehabilitación psicosocial (CRPS). Estuvo compuesta por 152 sujetos con edades comprendidas entre los 17 y los 71 años (edad media 42,5; Dt=12,6), de los cuales un 50,7% eran mujeres.

De cada caso de la muestra clínica se solicitó su diagnóstico para posteriormente ser agrupados en las categorías que aparecen en la tabla 4.2. Se puede advertir cómo la mayoría de la muestra se clasificó dentro de la categoría de psicosis (30%), deterioro neurológico (22%) y trastornos afectivos (44%).

Tabla 4.2. Composición de la muestra clínica por grupo diagnóstico de pertenencia (N=152). Datos de la adaptación española

	Composición		Media	Edad		Sexo % mujeres
	n	%		Dt	Rango	
Psicosis	45	30	41,0	12,3	19-71	42
Deterioro neurológico	33	22	45,5	13,1	18-71	29
Baja inteligencia	2	1	20,0	0,0	—	100
Trastornos afectivos	67	44	43,1	11,6	17-62	63
Trastornos de la personalidad	5	3	36,2	18,2	23-68	80
Total	152	100	42,5	12,6	17-71	50,7

4.1.2. Muestras de simuladores y casos clínicos en contextos médico-legales clasificados por criterios externos e independientes

En la adaptación española del SIMS se pudo contar con la colaboración de distintas organizaciones y profesionales que trabajaban en contextos médico-legales (mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, centros privados de psicología clínica y forense) que debían determinar en su labor profesional si una persona estaba simulando su sintomatología o por el contrario era un caso clínico con una patología «real».

A estos profesionales se les pidió que aplicaran el SIMS a sujetos que previamente habían sido clasificados, aplicando los criterios de sospecha clínica de presencia de posible simulación (véase Samuel y Mittenberg, 2006), como simuladores o como casos clínicos. El objetivo era poder estudiar la capacidad discriminativa de la adaptación española del SIMS en contextos reales de evaluación y con criterios externos de expertos independientes.

Se contó con una muestra de 61 casos, de los cuales 27 fueron clasificados como clínicos y 34 como simuladores. En la tabla 4.3 aparecen los principales datos demográficos de ambos grupos.

Tabla 4.3. Composición de la muestra de simuladores y clínicos en contextos médico-legales clasificados por jueces independientes (N=61). Datos de la adaptación española

	n	%	Media	Edad		Sexo % mujeres
				Dt	Rango	
Simulador	34	56	37,9	9,7	23-59	59
Clínico	27	44	38,3	11,2	18-59	37
Total	61	100	38,1	10,3	18-59	49,2



4.1.3. Muestras de grupos clasificados por su grado de exageración de síntomas de acuerdo a sus puntuaciones en el MMPI-2

Se contó también con otra muestra de pacientes procedente de contextos médico-legales a los que se les había aplicado el MMPI-2 y el SIMS. Dichos pacientes habían sido derivados por diversas mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a centros privados de psicología clínica para que, con la ayuda del tratamiento psicológico adecuado, pudieran reincorporarse a la vida laboral activa. La muestra estaba compuesta por 305 casos. Los casos fueron clasificados en virtud de si presentaban o no un patrón de exageración de síntomas en dos grupos de 32 y 273 casos respectivamente.

Esta clasificación fue realizada a partir de sus resultados en el MMPI-2 y se consideraba la existencia de un patrón de exageración de síntomas cuando el individuo obtenía una puntuación T en la escala F mayor o igual a 70 y una puntuación en el índice F-K mayor o igual a +5 (puntuación directa).

Las escala F o de infrecuencia ha demostrado su utilidad para identificar eficazmente individuos que pretenden presentarse de forma poco favorable (mala imagen), simulando o sobredimensionando deliberadamente síntomas psicopatológicos (Bury y Bagby, 2002; Elhai, Naifeh, Zucker, Gold, Deutsch y Frueh, 2004; Strong, Greene y Schinka, 2000). De hecho, esta escala contiene ítems seleccionados para detectar estilos de respuesta atípicos o inusuales, ya que el contenido de sus ítems está centrado en síntomas extravagantes o inusuales de psicopatología severa (Nichols, 2002).

El índice F-K de Gough (1950) se obtiene sustrayendo la puntuación directa de la Escala K de validez respecto de la puntuación directa de la escala F de validez (F menos K). Si el índice es positivo a partir de un determinado punto de corte el sujeto evidenciaría una tendencia a la exageración deliberada de síntomas (mala imagen); si el índice es negativo a partir de un determinado punto de corte, el individuo mostraría una tendencia a la negación o encubrimiento de síntomas (buena imagen).

Para considerar que presentaban un patrón de exageración de síntomas los participantes debían cumplir conjuntamente los criterios en estas dos escalas de validez del MMPI-2. Se optó por aplicar este criterio por considerar que tanto la escala F como el índice F-K son fáciles de calcular y existe una tipificación española de los mismos. Así mismo, la utilización de criterios multiescalares derivados de un mismo test ha demostrado ser una estrategia predictiva eficaz para discriminar entre sujetos simuladores y no simuladores (Meyers, Millis y Volkert, 2002; Aguerrevere, Greve, Bianchini y Meyers, 2008).

Asumiendo que el patrón de exageración de síntomas psicopatológicos es un constructo dimensional (Walters, Rogers, Berry, Miller, Duncan, McCusker, Payne y Granacher, 2008), podemos situar a los individuos en un continuo con un extremo inferior, encubrimiento de síntomas o defensividad, y un extremo superior, exageración de síntomas o simulación. Greene (2008) codifica dimensionalmente las puntuaciones en las diversas escalas de validez del MMPI-2 asignando el percentil 1 a la defensividad y el percentil 99 a la simulación. Utilizando los baremos de este autor calculados para población clínica, al criterio de $F \geq 70$ le correspondería un percentil entre 90 y 95 y al criterio de $F-K \geq +5$ le correspondería un percentil de 90, ambos muy próximos al extremo de exageración de síntomas o simulación.

En la tabla 4.4 se pueden observar las características tanto de la muestra total como de cada uno de los grupos establecidos por su nivel de exageración de síntomas, evaluados mediante el MMPI-2.



Tabla 4.4. Composición de la muestra de casos en contextos médico-legales clasificados por sus puntuaciones en el MMPI-2 en exageración de síntomas (N=305). Datos de la adaptación española

	n	Media	Edad Dt	Rango	Sexo % mujeres
G. sin exageración de síntomas	273	39,5	10,5	17-65	65
G. con exageración síntomas	32	39,3	11,8	20-58	63
Total	305	39,4	10,6	17-65	64,6

4.1.4. Muestras específicas de dolor crónico

Unos de los campos relevantes para el estudio de la simulación es el dolor crónico. Algunos estudios sugieren que la incidencia de la simulación de dolor es significativamente alta, estimándose los rangos de prevalencia entre un 25% y un 30% tanto para fibromialgia (Gervais, Russell y Green, 2001) como para dolor crónico en general (Gervais, Green, Allen *et al*, 2001). De hecho, es en los trastornos asociados al dolor (fibromialgia, fatiga crónica, dolor crónico o trastornos somatoformes) donde se encuentra una mayor incidencia de la simulación, representando más de la mitad (66%) de los casos de simulación de patologías (González Ordi, Capilla Ramírez y Matalobos Veiga, 2008).

En el estudio realizado por Capilla Ramírez, González Ordi y Santamaría Fernández (2008) se analizó precisamente la capacidad del SIMS para la detección de la simulación de sintomatología física y psicopatológica asociada a patología dolorosa crónica.

Para ello se contó con una muestra compuesta de 55 pacientes con dolor crónico litigantes, atendidos en el centro sanitario Fremap Madrid II (ITCC), clasificados en dos grupos (dolor de espalda litigante, fibromialgia litigante), 30 voluntarios con dolor crónico de espalda no litigantes del programa de educación postural de la Universidad Francisco de Vitoria y 146 estudiantes universitarios sin patología dolorosa crónica diagnosticada, que sirvieron como grupo control. En la tabla 4.5 se incluyen los datos descriptivos de edad y sexo de cada uno de los grupos considerados. Se consideró que los grupos litigantes podían presentar indicadores de simulación ya que no mostraban ningún tipo de evidencia física (fisiopatológica) que explicara adecuadamente sus quejas somáticas y estaban inmersos en procesos legales con el fin de obtener un beneficio económico, pensión por discapacidad, indemnizaciones por parte de aseguradoras, prolongación de bajas laborales, etc. La comparación de los resultados del SIMS en los grupos litigantes y no litigantes (y en relación al grupo control) nos permitirá establecer la capacidad de la prueba para detectar aquellos sujetos con indicios de estar simulando sus síntomas en el contexto del dolor crónico.

Tabla 4.5. Composición de las muestras específicas de dolor crónico (N=85). Datos de la adaptación española

	n	Media	Edad Dt	Rango	Sexo % mujeres
Dolor de espalda litigante	25	44,0	13,0	21-64	64
Fibromialgia litigante	30	47,7	9,2	26-64	90
Dolor de espalda no litigante	30	40,6	8,2	27-65	77
Grupo control	147	23,6	8,8	17-62	71



4.1.5. Muestras de validez convergente con MMPI-2, MCMI-II y MCMI-III

En un quinto grupo de estudios se dispuso de una muestra de 453 sujetos a los que se les había aplicado el SIMS junto con otras pruebas clásicas como son el MMPI-2, el MCMI-II y el MCMI-III. A partir de estos datos se analizó la convergencia de las puntuaciones obtenidas con el SIMS con las puntuaciones clásicamente consideradas del MMPI-2, el MCMI-II y el MCMI-III para la evaluación de la simulación. Los casos provenían de contextos reales de evaluación en mutuas de trabajo, aseguradoras o consultas de psicología forense. En la tabla 4.6 pueden observarse los descriptivos de edad y sexo de cada una de las muestras de las que se dispusieron para este estudio.

Tabla 4.6. Composición de la muestra de los estudios de validez convergente con MMPI-2, MCMI-II y MCMI-III (N=453).
Datos de la adaptación española

	n	Media	Edad Dt	Rango	Sexo % mujeres
SIMS - MMPI 2	305	39,3	10,8	14-65	65
SIMS - MCMI II	81	37,3	11,5	14-63	59
SIMS - MCMI III	67	35,8	10,3	16-60	75

4.2. Fiabilidad

El concepto general de fiabilidad hace referencia a la consistencia y la precisión relativa con que las puntuaciones extraídas de un instrumento de medida (p. ej., un test, una escala, un reloj) estiman los atributos de algo (p. ej., ver Martínez-Arias *et al*, 2006). La fiabilidad es un concepto clave en las teorías psicométricas y de medición puesto que se relaciona con la utilidad práctica de todos los tipos y sistemas de medida. Todas las medidas contienen cierto error, ya sean medidas de objetos o de constructos. El estudio de la fiabilidad de las puntuaciones en el test se centra en la estimación de la cantidad de error asociada con la obtención de la puntuación. En este apartado se trata la fiabilidad de las puntuaciones del SIMS con respecto a dos fuentes de error: su consistencia interna y su consistencia temporal.

4.2.1. Consistencia interna

Los estudios de consistencia interna reflejan el grado de homogeneidad entre los ítems que componen un test. Puesto que el propósito de esta prueba es medir una característica concreta, una habilidad o un dominio de contenido, cuanto más se relacionen unos elementos con otros, menor error habrá en el test. En la medida en que los elementos de una prueba sean distintos y no se relacionen unos con otros será más probable que estén midiendo aspectos distintos y la cantidad de error será mayor debido a la heterogeneidad de los elementos.

En los estudios realizados con el SIMS se estudió la fiabilidad entendida como consistencia interna con la muestra total de 1.005 participantes, obteniendo resultados satisfactorios. El coeficiente alfa de fiabilidad de la puntuación total del SIMS fue de 0,94. Los valores de los coeficientes en las escalas que lo componen oscilaron entre 0,65 y 0,90. Las escalas de Psicosis, Trastornos amnésicos y Deterioro neurológico mostraron unos excelentes resultados (superiores a 0,80 en los tres casos), mientras que Trastornos afectivos y Baja inteligencia tuvieron valores inferiores que aconsejan manejar mayores intervalos de confianza en la interpretación de las puntuaciones de dichas escalas.



Tabla 4.7. Coeficientes de fiabilidad del SIMS. Datos de la adaptación española

	Coeficiente alfa de Cronbach
Total	0,94
Psicosis (Ps)	0,90
Deterioro neurológico (Dn)	0,85
Trastornos amnésicos (Am)	0,90
Baja inteligencia (Bi)	0,69
Trastornos afectivos (Af)	0,65

4.2.2. Consistencia temporal: Estudio test-retest

La estabilidad de las puntuaciones (que en ocasiones recibe el nombre de error de muestreo temporal) se refiere al grado en el que la ejecución de los sujetos evaluados con el test es constante a lo largo del tiempo, y se suele estimar utilizando el método test-retest. Este procedimiento consiste en aplicar el test a un grupo de personas y, pasado un tiempo, volver a evaluar a las mismas personas para comparar posteriormente los resultados de ambas evaluaciones. La información disponible sobre la estabilidad temporal del SIMS proviene de los datos de su adaptación holandesa (Merckelbach y Smith, 2003) en la que se aplicó el SIMS a 24 universitarias con un intervalo temporal entre ambas aplicaciones de 3 semanas. La correlación test-retest de la puntuación total fue de 0,72 (Merckelbach y Smith, 2003), dato que indica una satisfactoria consistencia temporal, especialmente si se tiene en cuenta que el coeficiente alfa obtenido en dicha adaptación fue de 0,72, lo que haría que el valor de esta correlación corregida por atenuación (una vez controlados los errores de medida de consistencia interna) fuera de 0,99. No obstante, aunque existan expectativas razonables basadas en estos datos de que los valores que se obtuvieran con la adaptación española serían iguales o superiores (dados los valores más elevados obtenidos de consistencia interna), será deseable que en un futuro se lleven a cabo estudios específicos que evalúen este aspecto.

4.3. Validez

De acuerdo con los *estándares para la evaluación educativa y psicológica* (AERA, APA y NCME, 1999), la validez hace referencia a «... el grado en el que los datos y la teoría apoyan *las interpretaciones de las puntuaciones en el test* que hacen los usuarios del mismo» (cursiva añadida al original, p. 9). Reynolds (1998) definió la validez de forma parecida, argumentando que ésta hace referencia a la adecuación y la precisión de la interpretación de los resultados en un test, expresados habitualmente como una puntuación.

El presente capítulo constituye una revisión de los distintos tipos de evidencias relacionadas con la validez de la interpretación de las puntuaciones obtenidas con el SIMS. Se comenzará estudiando la estructura interna de la prueba y su coherencia con la estructura de cinco escalas hipotetizada. En segundo lugar se abordarán los distintos estudios que se han realizado con el SIMS empleando muestras clínicas y de análogos. Como ya se comentó con anterioridad, las estrategias de investigación que mayor solidez han demostrado en el estudio de la simulación son los diseños de investigación con «análogos» y *known-groups* o grupos diagnósticos, especialmente si se utilizan combinadamente (Rogers y Bender, 2003). Se revisarán los estudios originales, los estudios independientes publicados posteriormente y los estudios acometidos durante la adaptación española. En tercer lugar se estudiará su convergencia con otras puntuaciones ya establecidas como indicadores de simulación como son algunas escalas del MMPI-2, del MCMI-II y del MCMI-III.



4.3.1. Estructura factorial del SIMS

Uno de los aspectos normalmente considerados en el análisis de la validez de una prueba es su estructura interna. Su estudio permite desvelar en qué medida la estructura hallada empíricamente se adecua al constructo o constructos hipotetizados que se pretende evaluar. Habitualmente la relación entre los ítems y su agrupación se estudia mediante el análisis factorial. Ésta es una técnica eficaz para identificar los constructos latentes a partir del análisis de las intercorrelaciones de los ítems de la prueba.

En el caso de la adaptación española del SIMS se sometieron a análisis factorial las intercorrelaciones existentes entre los distintos ítems de la prueba empleando para ello el programa Factor (Lorenzo-Seva y Ferrando, 2006) que permite el cálculo y uso de la matriz de correlaciones tetracóricas entre los ítems. Como método de estimación se empleó ULS y como método de rotación *Oblimin direct normalizada*. Como procedimiento para la estimación del número de factores a extraer se utilizó PA-MBS, una extensión del análisis paralelo que genera múltiples matrices de correlación aleatorias utilizando muestras *bootstrapped* marginalmente (Lattin, Carroll y Green, 2003). Este método indicó como conveniente la extracción de siete factores. Cada ítem fue asignado a aquel factor en el que obtuvo una mayor saturación. A continuación se describen cada uno de los factores obtenidos.

El *primer factor* se denominó de *simulación de baja inteligencia* ya que estuvo formado por la mayoría de los ítems de la escala Baja inteligencia (11 de 15 ítems) y un ítem de la escala de trastornos amnésicos. Este último ítem («No puedo recordar si estoy casado o no») tuvo una saturación en este factor de 0,42 y en el factor de *simulación de trastornos amnésicos* de 0,32.

El *segundo factor* que se obtuvo podría considerarse complementario del primero, ya que estaba compuesto por tres de los cuatro ítems de Baja inteligencia que no se incluían en el primer factor. Específicamente incluía aquellos ítems que exigían valorar si dos cosas eran similares o no (p.ej., «El oro y la plata son similares porque ambos son metales»). Los análisis realizados en la adaptación española han sugerido que estos ítems presentan algunas características diferenciales con respecto al resto de los que componen esta escala de Baja inteligencia cuando se solicita esta solución factorial de 7 factores.

El *tercer factor* estuvo formado íntegramente por ítems de Deterioro neurológico, por lo que se decidió etiquetarlo como de *simulación de deterioro neurológico*; más de la mitad de los ítems de esta escala tenían su máxima saturación en este factor (8 de sus 15 ítems).

El *cuarto factor* se denominó *simulación de trastornos afectivos* ya que estuvo formado por prácticamente todos los ítems de la escala de Trastornos afectivos (12 de 15 ítems) y un ítem de Deterioro neurológico. Este último ítem («La comida no me sabe igual que antes») tuvo una saturación en este factor de 0,34 y en el factor de simulación de deterioro neurológico de 0,23.

El *quinto factor* estaba formado íntegramente por los tres ítems restantes de la escala de Trastornos afectivos. El contenido de estos ítems, a diferencia del resto de la escala, giraba en torno a momentos o actividades de superación de la depresión o estados emocionales negativos (p. ej., «Incluso estando deprimido la mayor parte del tiempo, me siento mejor por la mañana tras una buena noche de sueño» o «Aunque las cosas estén realmente mal, trato de mantenerme esperanzado hasta que mejoren»).

El *sexto factor* fue denominado factor de *simulación de psicosis* y estuvo compuesto por todos los ítems de la escala de Psicosis (15 ítems) y dos ítems de Deterioro neurológico («Siento un zumbido constante en mis oídos» y «A veces cuando escribo un número de teléfono, me doy cuenta de que los números salen al revés aunque yo no lo intente»).



El séptimo factor fue etiquetado como de *simulación de trastornos amnésicos* y estuvo compuesto por prácticamente todos los ítems de la escala de Trastornos amnésicos (14 de sus 15 ítems), un ítem de Baja inteligencia («El mayor problema que tengo es que las cosas son difíciles de entender para mí») y cuatro ítems de Deterioro neurológico.

Los resultados obtenidos muestran cierta evidencia y respaldo a la estructura de cinco escalas consideradas en el SIMS (Widows y Smith, 2005), si bien matizan algunos aspectos específicos. Los ítems de cada una de las escalas se agrupan mayoritariamente en un mismo factor, reflejando la coherencia empírica de cada escala y respaldando la agrupación realizada de los ítems en las mismas. Esto es especialmente claro en las escalas de Psicosis y Trastornos amnésicos que aparecen nítidamente reflejadas en el análisis factorial. Los ítems de la escala de Deterioro neurológico, al igual que ocurría en los estudios originales de la prueba (Widows y Smith, 2005), aparecen algo más difuminados y relacionados con los factores de simulación de psicosis y de trastornos amnésicos. Finalmente, los ítems de las escalas de Baja inteligencia y Trastornos afectivos, se agrupan empíricamente en su mayoría en sus respectivos factores, si bien parecen existir pequeños conjuntos de ítems que abarcan aspectos específicos de la simulación de esos trastornos cuando se extrae esta solución de 7 factores.

En la tabla 4.8 aparecen las intercorrelaciones entre las escalas del SIMS. Tal y como se indicaba anteriormente puede advertirse la alta relación existente entre las puntuaciones de Deterioro neurológico con otras escalas (especialmente Psicosis y Trastornos amnésicos), siendo estas tres escalas las que mayores correlaciones tienen con la puntuación total del SIMS. La escala de Trastornos amnésicos tiene también notables correlaciones con Baja inteligencia y Trastornos afectivos.

Tabla 4.8. Intercorrelaciones entre las escalas del SIMS. Datos de la adaptación española

	Psicosis	Deterioro neurológico	Trastornos amnésicos	Baja inteligencia	Trastornos afectivos
Escalas del SIMS					
Total	0,83	0,88	0,88	0,63	0,70
Psicosis		0,65	0,66	0,48	0,42
Deterioro neurológico			0,71	0,41	0,62
Trastornos amnésicos				0,52	0,52
Baja inteligencia					0,23
Trastornos afectivos					

Nota. N= 1.005. Todas las correlaciones son significativas a un nivel de 0,01.

En general, las altas correlaciones que se muestran entre las escalas respaldan la obtención de una puntuación total del SIMS como mejor síntesis de la información proporcionada por las escalas y siguiente nivel jerárquico de análisis. El procedimiento PA-MBS, comentado anteriormente e implementado en el programa Factor (Lorenzo-Seva y Ferrando, 2006), aconsejaba la extracción de un único factor a partir del análisis factorial de las escalas empleando como método de estimación ULS. Tal y como se muestra en la tabla 4.9 este primer factor explicaría un 62,6% de la varianza total.



Tabla 4.9. Autovalores obtenidos en el análisis factorial exploratorio de las escalas del SIMS. Datos de la adaptación española

Factor	Autovalor	% explicado de varianza	% acumulado de explicación de la varianza
1	3,13	62,6	62,6
2	0,82	16,3	
3	0,47	9,5	
4	0,32	6,4	
5	0,26	5,4	

En su conjunto, estos datos, junto con los que se presentarán en apartados posteriores que muestran la sensibilidad de cada escala a cada área de simulación específica, aportan evidencias de la adecuación de la estructura en cinco escalas y respaldan empíricamente el uso aplicado de la misma.

4.3.2. Estudios con análogos, muestras clínicas y grupos diagnósticos

Las estrategias de investigación que mayor solidez han demostrado en el estudio de la simulación son los diseños de investigación con «análogos» y con grupos diagnósticos, especialmente si se utilizan combinadamente (Rogers y Bender, 2003).

En los estudios análogos, los participantes son asignados de manera aleatoria a las condiciones experimentales de «simulación» y de «control», recibiendo instrucciones específicas acerca del estilo de respuesta a adoptar al responder a las pruebas de evaluación, actuando «como si» en el caso del grupo de simulación. En este tipo de estudios, es recomendable emplear también una muestra clínica para determinar si las diferencias se deben a la simulación o a la existencia de una determinada patología. Sin embargo, este tipo de diseño adolece de algunas limitaciones: además de no perseguir una compensación económica (generalmente) o al menos no resultar tan relevante para el individuo como en situaciones naturales (Calhoun *et al.*, 2000; Edens *et al.*, 1989; Frueh y Kinder, 1994), los sujetos no tienen tanta experiencia en estos protocolos de evaluación puesto que no han sido reiteradamente evaluados, no han observado a otros pacientes y no disponen de tanto tiempo para preparar su evaluación (Strauss *et al.*, 2002; Vickery *et al.*, 2001). Así, los estudios análogos tienen una elevada validez interna pero limitada validez externa.

La segunda estrategia de grupos diagnósticos (*known-groups*) se basa en que un grupo de personas identificadas o clasificadas como simuladores, mediante jueces independientes, se comparan con pacientes clínicos o sujetos controles. En este caso, los estudios presentan alta validez externa y una menor validez interna.

Adicionalmente, aunque existen muy pocos estudios a tal efecto, existe la posibilidad de combinar las estrategias de estudios análogos y grupos diagnósticos, incluyendo además un grupo control y una muestra clínica representativa de referencia sobre la patología física o psicológica objeto de la simulación, para estudiar ampliamente el espectro de respuestas posibles pertinentes: desde la respuesta honesta del grupo control no clínico hasta la respuesta de simulación pura de los estudios análogos pasando por los puntos intermedios que son los grupos clínicos y los grupos de simuladores en contextos reales.

En los estudios del SIMS, tanto en los originales como en los de la adaptación española, se han empleado ambos diseños de investigación (análogos y de grupos diagnósticos) para analizar la capacidad de la prueba para clasificar correctamente a los sujetos en grupos de simuladores y no simuladores. Además en los estu-



dios de la adaptación española se han combinado los resultados de ambos estudios, tal y como se sugería previamente, para ofrecer una perspectiva global de la capacidad del SIMS.

A continuación se presentarán en este apartado los estudios llevados a cabo inicialmente por los autores originales (Widows y Smith, 2005) para, a continuación, mencionar los principales resultados de los diferentes estudios independientes de validación que han sido llevados a cabo sobre el SIMS (Merckelbach y Smith, 2003; Edens, Otto y Dwyer, 1999; Poythress, Edens y Watkins, 2001; Lewis, Simcox y Berry, 2002; Heinze y Purisch, 2001; Rogers, Hinds y Sewell, 1996; Rogers, Jackson y Kaminski, 2005; Jelacic, Hessels y Merckelbach, 2006; Geraerts, Jelacic y Meckelbach, 2006; Jelacic, Merckelbach, Candel y Geraerts, 2007; Jelacic, Peters y Merckelbach, 2007; Vitacco, Rogers, Gabel y Munizza, 2007; Edens, Poythress y Watkins-Clay, 2007; Alwes, Clark, Berry y Granacher, 2008; y Rogers, 2008b).

Finalmente se incluirán los estudios específicos realizados con la adaptación española de la prueba (González Ordi y Santamaría Fernández, 2008; González Ordi, Santamaría Fernández y Matolobos Veiga, 2008; Fernández Marín, González Ordi y Santamaría Fernández, 2008; y Capilla Ramírez, González Ordi y Santamaría Fernández, 2008).

4.3.2.1. Estudios originales

ESTUDIO DE SIMULACIÓN DE SMITH (1993) Y SMITH Y BURGER (1997)

En este estudio se contó con una muestra de 238 estudiantes universitarios extraídos aleatoriamente de la muestra descrita en el apartado 3.3. Los participantes en este estudio fueron asignados aleatoriamente a un grupo de control (o respuesta honesta) o a uno de los siguientes grupos experimentales: simulación del mal estado general, simulación de psicosis, simulación de deterioro neurológico, simulación de amnesia, simulación de baja inteligencia y simulación de depresión.

Se calcularon las puntuaciones medias en las escalas del SIMS de cada uno de estos grupos (tabla 4.10). Las diferencias encontradas fueron significativas como puede advertirse en la tabla 4.11. Además se realizó la prueba de rango múltiple de Duncan ($\alpha=0,05$) para especificar qué grupos se diferenciaban significativamente entre sí en cada una de las escalas de la prueba, de forma que pudiera estudiarse la concordancia entre la estructura hipotetizada del SIMS y los resultados en los grupos experimentales.

En todos los casos el grupo control fue el que obtuvo puntuaciones significativamente inferiores al resto de grupos. En general, las puntuaciones más altas en cada escala fueron obtenidas por el grupo de simulación de mal estado general y el grupo experimental específico de dicha escala (p. ej., el grupo de simulación de psicosis en la escala Psicosis). Como excepción a este patrón, los grupos de simulación de psicosis y deterioro neurológico obtuvieron puntuaciones medias similares en la escala Deterioro neurológico del SIMS y el grupo de simulación de psicosis obtuvo puntuaciones similares en las escalas Psicosis y Amnesia del SIMS, sugiriendo que aquellos individuos que son instruidos para simular síntomas de psicosis o de trastornos mentales graves tienden a asignarse síntomas de múltiples dominios. Por otro lado, el grupo de simulación de deterioro neurológico obtuvo una mayor puntuación en la escala Trastornos amnésicos que en la escala Deterioro neurológico, indicando que este grupo de simulación enfatizó la pérdida de memoria asociada al daño neurológico y cerebral.



Tabla 4.10. Puntuaciones medias y desviaciones típicas en las escalas del SIMS de los grupos experimentales y control. Estudios originales de Smith (1993) y Smith y Burger (1997)

Escala del SIMS	Grupo experimental de simulación													
	Grupo control		Mal estado general		Psicosis		Deterioro neurológico		Amnesia		Baja inteligencia		Depresión	
	M	Dt	M	Dt	M	Dt	M	Dt	M	Dt	M	Dt	M	Dt
Total	7,7	3,7	53,9	13,8	48,4	14,5	43,2	13,8	36,2	10,2	37,0	14,1	29,9	12,3
Psicosis	0,8	1,0	12,7	2,1	11,8	3,7	7,0	5,2	3,0	4,0	4,9	4,2	3,1	3,8
Deterioro neurológico	1,0	1,0	10,9	3,9	9,2	4,3	8,7	3,9	5,2	3,3	5,8	3,5	5,5	3,3
Trastornos amnésicos	1,2	1,5	11,2	4,0	10,8	4,4	12,0	3,6	13,1	2,8	9,0	4,7	6,3	5,1
Baja inteligencia	1,4	1,2	9,4	4,3	8,0	3,6	7,7	3,7	8,6	3,2	10,8	2,0	3,2	2,4
Trastornos afectivos	3,3	2,0	9,8	2,9	8,6	2,9	7,9	3,0	6,2	3,1	6,5	3,9	11,8	1,5

Nota. N= 238. Aparece destacada en negrita la puntuación media de cada grupo en su escala específica (p. ej., del grupo de simulación de psicosis en la escala Psicosis del SIMS).

Tabla 4.11. Análisis de varianza (ANOVA) de las puntuaciones del SIMS en los distintos grupos experimentales considerados. Estudios originales de Smith (1993) y Smith y Burger (1997)

Escala del SIMS	F	g.l.	R ²
Total	39,8	7,230	0,57
Psicosis	39,3	7,230	0,54
Deterioro neurológico	24,3	7,230	0,43
Trastornos amnésicos	29,8	7,230	0,48
Baja inteligencia	34,9	7,230	0,51
Trastornos afectivos	26,6	7,230	0,45

Nota. N= 238. Todas las diferencias fueron significativas con un $p < 0,0001$.

Se calcularon también las medias y desviaciones típicas para el grupo general de simuladores (que incluía todas las condiciones experimentales) y el grupo control, tal y como aparecen en la tabla 4.12. Coherentemente con los análisis previos, el grupo global de simulación obtuvo puntuaciones superiores al grupo control en todas las escalas del SIMS, apoyando la idea de que el SIMS es capaz de discriminar entre aquellos que responden honestamente a la prueba y un grupo variado e indiferenciado de simuladores, tal y como se encontrarían probablemente en el mundo real.

Como síntesis, podría concluirse que el patrón general de las puntuaciones medias de los distintos grupos experimentales proporciona evidencias razonables sobre la capacidad de las escalas del SIMS para diferenciar entre a) la simulación de sintomatología de diferentes tipos y la respuesta honesta, b) la simulación indiferenciada de sintomatología y la respuesta honesta y c) entre tipos específicos de simulación de síntomas.



Tabla 4.12. Puntuaciones medias en las escalas del SIMS del grupo control y del grupo global de simuladores. Estudios originales de Smith (1993) y Smith y Burger (1997)

Escala del SIMS	Grupo control		Grupo de simulación	
	M	Dt	M	Dt
Total	7,7	3,7	37,5	14,9
Psicosis	0,8	1,0	6,0	5,2
Deterioro neurológico	1,0	1,0	6,7	4,0
Trastornos amnésicos	1,2	1,5	9,7	5,0
Baja inteligencia	1,4	1,2	6,9	3,9
Trastornos afectivos	3,3	2,0	8,2	3,5

Nota. N= 238.

A partir de este estudio también se establecieron los puntos de corte a considerar en la versión original de la prueba. Para su cálculo se empleó la muestra comentada anteriormente (238 casos extraídos aleatoriamente de la muestra total de 476 casos) y se replicaron sus resultados en la muestra de validación cruzada formada por los 238 casos restantes no incluidos en la muestra anterior.

El punto de corte de cada escala se determinó de forma que discriminara óptimamente a aquellos que respondían honestamente de los que estaban simulando. Para ello en cada escala se compararon las distribuciones de puntuaciones del grupo de respuesta honesta y el grupo de simuladores específicos de esa escala. En el caso de que ambas distribuciones de puntuaciones se solaparan, se elegía en su intersección aquel punto de corte que permitiera mayores tasas de acierto de clasificación en ambos grupos. Si las distribuciones no se solapaban, se elegía como puntuación de corte el punto medio entre ambas. De este modo se maximizaron las tasas de acierto de clasificación en ambos grupos. En la tabla 4.13 se pueden ver los puntos de corte que se obtuvieron con esta metodología.

Tabla 4.13. Puntos de corte recomendados por los autores originales (Widows y Smith, 2005)

Escala del SIMS	Puntos de corte para la versión original de la prueba
Total	>14
Psicosis	>1
Deterioro neurológico	>2
Trastornos amnésicos	>2
Baja inteligencia	>2
Trastornos afectivos	>5

Nota. N= 238.

Para comprobar la eficacia de los puntos de corte establecidos, se estudió su sensibilidad, especificidad y precisión en la clasificación de los participantes, tanto en la muestra inicial de estudio (n=238) como en la muestra de validación cruzada (n=238). El grupo de simulación se consideró globalmente, sin separar por trastorno simulado, tal y como es probable que se encontrara un profesional en su práctica cotidiana cuando utilizara los puntos de corte.



En la tabla 4.14 puede advertirse cómo el SIMS mostró altas tasas de eficiencia en la **correcta** clasificación de los grupos de simuladores y los grupos de respuesta honesta, tanto en la **puntuación total**, que fue la que mejor capacidad discriminatoria mostró (porcentaje de acierto en la clasificación del 95%) como en las de cada una de sus escalas (porcentajes de acierto en la clasificación que oscilaron entre el 75,1% de Psicosis y el 88,2% de Trastornos amnésicos).

Tabla 4.14. Sensibilidad y especificidad del SIMS en la muestra inicial de estudio. Estudio original de Widows y Smith (2005)

Escalas del SIMS	Sensibilidad (%)	Especificidad (%)	Eficiencia (%)
Total > 14	94,6	87,9	95,0
Psicosis > 1	81,8	76,1	75,1
Deterioro neurológico > 2	85,9	90,9	86,6
Trastornos amnésicos > 2	88,8	84,9	88,2
Baja inteligencia > 2	84,4	78,8	83,6
Trastornos afectivos > 5	76,1	90,9	78,2

Nota. n= 238.

Dado que los puntos de corte fueron establecidos a partir de la propia muestra inicial, cabría esperar que el estudio de sensibilidad, especificidad y eficiencia con esta muestra ofreciera resultados satisfactorios pero que quizás no se mantuvieran cuando fueran aplicados a otras muestras diferentes. Con el objetivo de valorar este aspecto, se aplicaron estos mismos puntos de corte a la muestra de validación cruzada (n=238) y se obtuvieron los resultados que aparecen en la tabla 4.15. Como puede observarse, los resultados siguen siendo muy satisfactorios con una eficiencia del 94,5% en el caso de la puntuación total del SIMS y con valores entre 74,4% y 88,7% correspondientes a Trastornos afectivos y Trastornos amnésicos respectivamente.

Tabla 4.15. Sensibilidad y especificidad del SIMS en la muestra de validación cruzada. Estudio original de Widows y Smith (2005)

Escalas del SIMS	Sensibilidad (%)	Especificidad (%)	Eficiencia (%)
Total > 14	95,6	87,9	94,5
Psicosis > 1	79,5	72,8	78,6
Deterioro neurológico > 2	85,4	75,8	84,0
Trastornos amnésicos > 2	88,3	90,9	88,7
Baja inteligencia > 2	85,4	51,5	80,7
Trastornos afectivos > 5	74,6	72,7	74,4

Nota. n= 238.

Estos resultados con la muestra de validación cruzada indicaron el alto nivel de eficiencia de la puntuación total del SIMS y sus escalas para diferenciar a las personas que responden honestamente a la prueba y aquellos que están simulando su sintomatología. La puntuación total se confirmó como el índice más efectivo, con valores de 95,0% y 94,5% respectivamente en las muestras inicial y de validación cruzada, respaldando la idea de que esta puntuación era la que más fiablemente podría usarse para discriminar entre ambos grupos.

ESTUDIO DE SIMULACIÓN DE MERCKELBACH Y SMITH (2003)

Merckelbach y Smith (2003) estudiaron las propiedades psicométricas de la adaptación holandesa del SIMS, que fue aplicada a un grupo de estudiantes universitarios de Psicología y a un grupo de pacientes psiquiátricos hospitalizados. La muestra 1 estuvo compuesta por 24 universitarias que fueron instruidas para respon-



der honestamente a todos los ítems del SIMS. A este grupo se le aplicó el SIMS en dos ocasiones diferentes, con un intervalo de tres semanas entre ambas. La muestra 2 estuvo formada por 182 universitarios instruidos también para responder honestamente al SIMS. A los sujetos de esta muestra se les aplicó adicionalmente pruebas de evaluación de la depresión y la ansiedad. La muestra 3 estuvo compuesta por un grupo de 10 pacientes psiquiátricos hospitalizados que respondieron sinceramente a la prueba y un grupo de 82 universitarios que fueron asignados a una de las cuatro condiciones experimentales: grupo control de respuesta sincera ($n=25$), grupo de simulación de amnesia ($n=28$), grupo de simulación de esquizofrenia ($n=14$) y grupo de simulación de problemas neurológicos ($n=15$). Al grupo de universitarios de la muestra 3 se les proporcionó una breve descripción del trastorno a simular así como un contexto que incitaba a la simulación y a evitar que fuera detectada.

Como puede verse en la tabla 4.16 aquellos que simulaban un trastorno psiquiátrico o cognitivo obtuvieron consistentemente las puntuaciones totales más altas en el SIMS, notablemente por encima de aquellos que respondían sinceramente a la prueba y de los pacientes psiquiátricos. Estas diferencias fueron además significativas y estudios *post hoc* de las puntuaciones indicaron que existían tres grupos que se diferenciaban significativamente entre sí. En primer lugar, con las puntuaciones más altas, estaba el grupo de simulación, a continuación el grupo de pacientes psiquiátricos y finalmente el grupo de respuesta sincera. Además en relación con la validez de cada una de las escalas específicas del SIMS, cada grupo de simuladores obtuvo puntuaciones más altas en la escala del SIMS relacionada con el trastorno simulado (p. ej., en la escala Psicosis aquellos participantes que simulaban esquizofrenia), con una interacción significativa entre el grupo de simulación y la escala.

Tabla 4.16. Puntuaciones medias en la escala total del SIMS en los estudios de la adaptación holandesa. Estudios originales de Merkelbach y Smith (2003)

Muestra	Total del SIMS	
	M	Dt
<i>Muestra 1</i>		
Respuesta sincera primera evaluación ($n=24$)	3,8	2,3
Respuesta sincera segunda evaluación ($n=24$)	3,4	3,4
<i>Muestra 2</i>		
Respuesta sincera ($n=182$)	5,8	3,9
<i>Muestra 3</i>		
Respuesta sincera ($n=25$)	5,1	4,5
Simulación amnesia ($n=28$)	34,8	9,9
Simulación esquizofrenia ($n=14$)	37,7	14,3
Simulación trastorno neurológico ($n=15$)	30,3	11,0
Pacientes clínicos ($n=10$)	11,4	5,8

Nota. Extraído de H. Merkelbach y G. P. Smith (2003). Diagnostic Accuracy of the Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS) in Detecting Instructed Malingering. *Archives of clinical Neuropsychology*, 18, p. 147. Adaptado con permiso del editor.

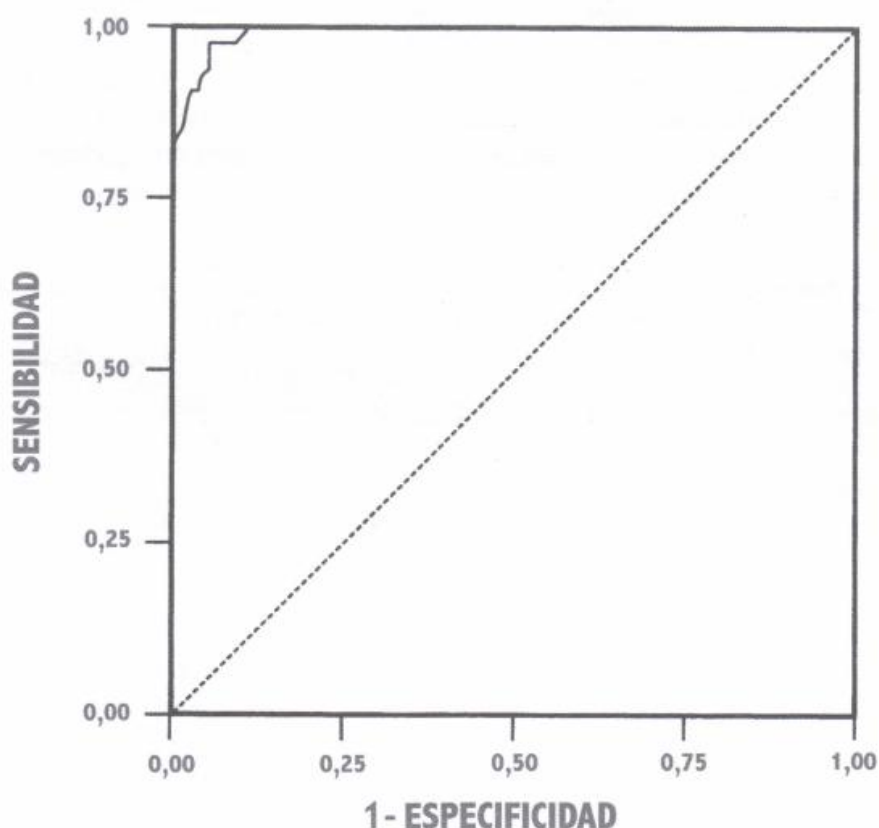
Merkelbach y Smith (2003) también emplearon curvas COR (curvas de características operativas del receptor) para estudiar la capacidad discriminativa del SIMS entre el grupo de simuladores y el grupo de respuesta sincera. Este tipo de análisis permite ilustrar gráficamente la sensibilidad y especificidad de la prueba en los distintos puntos de corte posibles a considerar (Mossman y Somoza, 1991). El área bajo la curva refleja la capacidad global de la prueba para discriminar en el conjunto de todos los posibles puntos de corte, siendo aquellos valores más altos indicativos de una mejor capacidad discriminativa. En otras palabras, el área bajo la curva puede ser descrita como la probabilidad de que un caso extraído aleatoriamente de la muestra



de simuladores obtuviera una puntuación más alta que un caso extraído aleatoriamente de la muestra de participantes que respondieron sinceramente. Valores del área bajo la curva superiores a 0,50 acompañados de niveles de significación inferiores a 0,05 indican que el test permite clasificar los casos mejor que lo que se haría simplemente por azar. Conforme la curva COR se aleje más de la diagonal del gráfico (línea de referencia de acierto por azar) mayor precisión proporcionará. Se puede evaluar el funcionamiento de cada punto de corte potencial observando la propia curva COR.

A partir de los datos de la muestra global de simuladores y de respuesta sincera de Merckelbach y Smith (2003) se generó la curva COR que aparece en la figura 4.1. Tal y como puede advertirse, la curva COR proporciona evidencias de la satisfactoria capacidad del SIMS para discriminar entre grupos de simuladores y de respuesta honesta. El valor del área bajo la curva (0,96) es también indicativo de esta excelente capacidad.

Figura 4.1. Análisis COR del SIMS. Estudios originales de Merckelbach y Smith (2003)



Merckelbach y Smith (2003) también estudiaron los índices de sensibilidad y precisión. La tabla 4.17 presenta los principales índices considerados utilizando un punto de corte para la puntuación total del SIMS de 16. Asumiendo una tasa de prevalencia de la simulación del 19%, comparable a la que se encuentra en contextos médicos legales reales, el SIMS demostró una excelente capacidad para identificar correctamente a los simuladores frente a los de respuesta honesta. En concreto el SIMS detectó correctamente al 93% de los simuladores (sensibilidad) y al 98% de los sujetos que respondieron sinceramente (especificidad). De aquellos identificados por el SIMS como simuladores, un 10% estaban respondiendo en realidad sinceramente (falsos positivos) y solo un 2% de los sujetos clasificados como de respuesta sincera eran realmente simuladores (falsos negativos). El conjunto de los datos mostró una adecuada evidencia de la capacidad del SIMS como prueba de *screening*.



Tabla 4.17. Precisión predictiva de la puntuación total del SIMS. Estudios originales de Merckelbach y Smith (2003)

Total SIMS > 16	Precisión
Sensibilidad	0,93
Especificidad	0,98
Valor predictivo positivo	0,90
Valor predictivo negativo	0,98

Nota. N=298. Extraído de H. Merckelbach y G.P. Smith (2003). Diagnostic Accuracy of the Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS) in Detecting Instructed Malingering. *Archives of clinical Neuropsychology*, 18, p. 147. Adaptado con permiso del editor.

En el estudio de Merckelbach y Smith (2003) también se aplicaron a los sujetos de la condición de respuesta sincera otras dos pruebas, el BDI (*Inventario de depresión de Beck*; Beck y Steer, 1987) y el STAI (*Cuestionario de Ansiedad estado-rasgo*; Spielberger, 1983). La puntuación total del SIMS obtuvo correlaciones significativas con la puntuación de depresión del BDI ($r=0,64$, $p<0,01$) y con la de ansiedad estado del STAI ($r=0,55$, $p<0,01$). No obstante, cuando se analizaron los sujetos que obtenían puntuaciones más altas en alguna de las dos pruebas (percentiles iguales o superiores a 90), el 84% ($n=19$) en el caso del BDI y el 89% ($n=19$) en el caso del STAI seguían siendo clasificados como no simuladores. Esto es, parece que los errores de clasificación de sujetos con altos niveles de ansiedad o depresión como simuladores fueron relativamente bajos en el SIMS de acuerdo a los datos de este estudio.

4.3.2.2. Estudios Independientes

ESTUDIO DE SIMULACIÓN DE EDENS, OTTO Y DWYER (1999)

Edens, Otto y Dwyer (1999) estudiaron la capacidad discriminativa del SIMS para detectar simuladores empleando para ello una muestra de 196 estudiantes universitarios. Los participantes completaron tanto el SIMS como el SCL-90-R (*Cuestionario de 90 síntomas*; Derogatis, 1975) en dos ocasiones contrabalanceadas, una de ellas en la que eran instruidos para simular y otra en la que se les pedía que respondieran sinceramente. En la condición de simulación los sujetos fueron asignados aleatoriamente a uno de los siguientes grupos: simulación de psicosis ($n=59$), simulación de depresión ($n=65$) o simulación de deterioro cognitivo ($n=72$). A cada participante se le daba una breve descripción de la condición que debía simular y se le indicaba que obtendrían un incentivo económico si conseguían que su simulación no fuera detectada.

En términos de su capacidad discriminativa, tal y como se puede observar en la tabla 4.18, los análisis realizados mostraron que los participantes obtenían puntuaciones notablemente superiores en la condición de simulación en las distintas escalas del SIMS, especialmente en la escala relacionada con la patología que se les había solicitado que simularan (p. ej., aquellos que se les indicaba que debían simular psicosis obtenían puntuaciones más altas en esta escala del SIMS).



Tabla 4.18. Puntuaciones medias y desviaciones típicas en las escalas del SIMS de los grupos experimentales y de respuesta sincera. Estudio independiente de Edens, Otto y Dwyer (1999)

	Condición experimental											
	Depresión ^a				Psicosis ^b				Deterioro cognitivo ^c			
	Respuesta sincera		Simulación		Respuesta sincera		Simulación		Respuesta sincera		Simulación	
Escalas del SIMS	M	Dt	M	Dt	M	Dt	M	Dt	M	Dt	M	Dt
Total	7,8	4,5	32,5	13,4	8,1	3,8	40,7	14,2	7,9	4,7	38,6	11,4
Psicosis	0,5	0,8	3,6	4,0	0,4	0,7	10,0	4,5	0,7	1,4	3,4	3,9
Deterioro neurológico	1,0	1,3	6,6	3,7	0,9	1,0	8,1	4,1	0,9	1,2	8,2	3,8
Trastornos amnésicos	0,9	1,4	8,1	4,7	1,1	1,5	8,8	4,6	0,8	1,6	12,3	3,6
Baja inteligencia	1,7	1,5	4,3	3,1	1,8	1,5	8,2	3,6	2,0	1,5	7,5	3,4
Trastornos afectivos	3,8	1,9	10,0	1,8	3,9	1,8	7,7	2,1	3,5	1,9	7,3	2,8

Nota. n^a= 65; n^b= 59; n^c= 72. Aparece destacada en negrita la puntuación media de cada grupo en su escala específica (p. ej., del grupo de simulación de psicosis en la escala Psicosis del SIMS). Extraído de J. F. Edens, R. K. Otto y T. Dwyer (1999). Utility of the Structured Inventory of Malingered Symptomatology in Identifying Persons Motivated to Maligner Psychopathology. *Journal of the American Academy of Psychiatry and the law*, 27, p. 329. Adaptado con permiso del editor.

También se calcularon los índices de sensibilidad y especificidad del SIMS empleando los puntos de corte sugeridos por los autores originales (Widows y Smith, 2005). En la tabla 4.19 se incluyen los índices obtenidos en cada condición experimental y en el conjunto global de todas las condiciones. Las distintas escalas del SIMS mostraron una satisfactoria sensibilidad en la identificación de la simulación del trastorno específico referido a la condición experimental con valores que iban desde 91,5% (sensibilidad de la escala Psicosis del SIMS en identificar a simuladores de psicosis) al 100% (sensibilidad de la escala Trastornos afectivos en la identificación de simuladores de depresión). Los valores de especificidad también fueron adecuados, con valores comprendidos entre el 81,5% (escala Trastornos afectivos) a 93,2 (escala Psicosis). En conjunto, la puntuación total del SIMS demostró una excelente capacidad para clasificar correctamente a los simuladores (sensibilidad = 96,4%) y a los no simuladores (especificidad = 91,3%).

Tabla 4.19. Sensibilidad y especificidad del SIMS. Estudio independiente de Edens, Otto y Dwyer (1999)

Escalas del SIMS y punto de corte	Condición experimental							
	Depresión ^a		Psicosis ^b		Deterioro cognitivo ^c		Grupo global de simulación ^d	
	Sensibilidad (%)	Especificidad (%)	Sensibilidad (%)	Especificidad (%)	Sensibilidad (%)	Especificidad (%)	Sensibilidad (%)	Especificidad (%)
Total > 14	92,3	89,2	98,3	93,2	98,6	91,7	96,4	91,3
Psicosis > 1	56,9	89,2	91,5	93,2	58,3	86,1	67,9	89,3
Deterioro neurológico > 2	83,1	89,2	89,8	93,1	94,4	93,1	89,3	91,8
Trastornos amnésicos > 2	83,1	90,8	84,7	88,1	95,8	91,7	88,3	90,3
Baja inteligencia > 2	66,2	69,2	83,1	72,9	91,7	71,8	80,6	71,3
Trastornos afectivos > 5	100,0	81,5	86,4	76,3	73,6	87,5	86,2	82,1

Nota. n^a= 65; n^b= 59; n^c= 72; n^d= 196. Aparecen destacados en negrita los índices de sensibilidad y especificidad de cada grupo en su escala específica (p. ej., del grupo de simulación de psicosis en la escala Psicosis del SIMS). Extraído de J. F. Edens, R. K. Otto y T. Dwyer (1999). Utility of the Structured Inventory of Malingered Symptomatology in Identifying Persons Motivated to Maligner Psychopathology. *Journal of the American Academy of Psychiatry and the law*, 27, p. 329. Adaptado con permiso del editor.



Con el objetivo de conocer con más detalle la precisión de las escalas del SIMS, Edens y colaboradores (1999) analizaron su relación con otras medidas de psicopatología, en concreto con el SCL-90-R. Tal y como aparece en la tabla 4.20 las correlaciones encontradas entre las escalas del SIMS y el índice GSI del SCL-90-R pueden considerarse entre bajas y moderadas. Los autores decidieron realizar análisis específicos de sensibilidad y especificidad del SIMS con aquellos sujetos que, de acuerdo al SCL-90-R, mostraban un alto nivel de problemas emocionales para evaluar la posible influencia de este tipo de variables en la efectividad de la clasificación realizada con el SIMS. Para ello se seleccionaron dos submuestras, la primera de ella compuesta por aquellos participantes que estaban actualmente en tratamiento psicológico o que lo habían estado en el pasado ($n=33$); la segunda formada por aquellos que mostraron un nivel significativo de sintomatología psicopatológica ($n=27$) de acuerdo a su puntuación en el índice GSI del SCL-90-R (se seleccionaron aquellos con puntuaciones T en GSI superiores a 45). En estos análisis se emplearon los puntos de corte sugeridos por los autores originales (Widows y Smith, 2005).

Tabla 4.20. Correlaciones entre las escalas del SIMS y el nivel de sintomatología psicopatológica. Estudio independiente de Edens, Otto y Dwyer (1999)

Escalas del SIMS	SCL-90-R (GSI)
Total	0,52
Psicosis	0,23
Deterioro neurológico	0,43
Trastornos amnésicos	0,28
Baja inteligencia	0,11
Trastornos afectivos	0,49

Nota. $N=196$. GSI = Índice global de gravedad o Índice sintomático general. Extraído de J. F. Edens, R. K. Otto y T. Dwyer (1999). Utility of the Structured Inventory of Malingered Symptomatology in Identifying Persons Motivated to Malingering Psychopathology. *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 27, p. 329. Adaptado con permiso del editor.

Como puede advertirse en la tabla 4.21, la puntuación total en el SIMS parece ser el mejor indicador de simulación, tal y como cabría esperar, con una clasificación correcta del 97% y el 100% de los simuladores en las submuestras de tratamiento psicológico y presencia de sintomatología psicopatológica respectivamente. Por otro lado respecto a su especificidad, el 9,1% y el 22,2% de los que respondieron sinceramente en las muestras de tratamiento psicológico y presencia de psicopatología respectivamente fueron clasificados erróneamente como simuladores. Esta mayor tasa de falsos positivos, especialmente en el caso de aquellos con presencia de psicopatología, junto con el alto nivel de sensibilidad (100% en este último caso) es coherente con los objetivos del SIMS de ser una prueba de *screening* que detecte los posibles simuladores para que después sean evaluados en mayor profundidad con pruebas que enfaticen más la especificidad y el valor predictivo positivo frente a las pruebas de *screening* que suelen primar la sensibilidad como primer filtro que son.



Tabla 4.21. Sensibilidad y especificidad del SIMS en participantes bajo tratamiento psicológico o con un alto nivel de sintomatología psicopatológica. Estudio independiente de Edens, Otto y Dwyer (1999)

Escala del SIMS	En tratamiento psicológico ^a		Presencia de sintomatología psicopatológica ^b	
	Sensibilidad (%)	Especificidad (%)	Sensibilidad (%)	Especificidad (%)
Total > 14	97,0	90,9	100,0	77,8
Psicosis > 1	60,6	90,9	77,8	58,2
Deterioro neurológico > 2	90,9	97,0	92,6	73,1
Trastornos amnésicos > 2	90,9	84,8	100,0	81,5
Baja inteligencia > 2	81,8	75,8	85,2	74,1
Trastornos afectivos > 5	84,8	72,7	92,6	51,9

Nota. n^a= 33; n^b= 27; ^a Puntuación T en GSI > 45 en condición de respuesta honesta. Extraído de J. F. Edens, R. K. Otto y T. Dwyer (1999). Utility of the Structured Inventory of Malingered Symptomatology in Identifying Persons Motivated to Malingering Psychopathology. *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 27, p. 329. Adaptado con permiso del editor.

ESTUDIO DE SIMULACIÓN Y GRUPOS DIAGNÓSTICOS DE POYTHRESS, EDENS Y WATKINS (2001)

Poythress, Edens y Watkins (2001) incluyeron el SIMS en un estudio más amplio sobre evaluación de la simulación y la psicopatía. Para ello contaron con una muestra de 116 reclusos varones que fueron subdivididos en las siguientes submuestras: a) Reclusos que respondieron en la condición de sinceridad a la prueba (n=30); b) Reclusos que respondieron en la condición de simulación a la prueba (n=30); c) Reclusos que se encontraban en la unidad psiquiátrica de la prisión y que respondieron sinceramente (n=30); y d) Reclusos que se encontraban en la unidad psiquiátrica de la prisión y que fueron clasificados por el equipo clínico como simuladores (n=26). Para la clasificación de los reclusos de la unidad psiquiátrica de la prisión como simuladores los clínicos de la unidad psiquiátrica emplearon un inventario basado en la SIRS (Rogers, Bagby y Dickens, 1992) con las ocho estrategias más habituales de simulación.

Todos los participantes fueron evaluados en este estudio con distintas medidas de simulación junto con escalas generales de psicopatía y psicopatología. Con el objetivo de hacer lo más reales posibles las condiciones de simulación de los reclusos de la muestra b, se les informó de que había un incentivo económico si conseguían no ser detectados como simuladores. Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que, de todas las medidas empleadas, la puntuación total del SIMS (punto de corte > 14) fue la que mejores resultados de clasificación obtuvo. Clasificó erróneamente como de respuesta honesta a solo un 10,3% de los reclusos que respondían en la condición de simulación y a un 15,4% de los simuladores de la unidad psiquiátrica (frente al porcentaje de errores de clasificación de la SIRS o del PAI que prácticamente quintuplicaban los del SIMS). Más recientemente, Edens, Poythress y Watkins-Clay (2007) han confirmado estos resultados en un estudio muy similar.

ESTUDIO DE GRUPOS DIAGNÓSTICOS DE LEWIS, SIMCOX Y BERRY (2002)

Lewis, Simcox y Berry (2002) evaluaron la eficacia de distintas pruebas habitualmente empleadas para la detección de la simulación, entre ellas el SIMS, en una muestra de 55 varones remitidos a evaluación psicológica para valorar si eran competentes para ser juzgados y su estado mental en el momento del delito. De acuerdo a los resultados de la SIRS (Rogers, Bagby y Dickens, 1992) los sujetos fueron clasificados como simuladores (n=24) o no simuladores (de respuesta sincera; n=31). Dado que en uno de los lugares de evaluación solo se aplicaron todas las pruebas a aquellos con sospechas de simulación, esos casos fueron excluidos de los análisis de las tasas de prevalencia de simulación. A partir del resto de los casos se calculó una tasa de prevalencia del 31,4% que fue considerada en los siguientes análisis de utilidad, de acuerdo a la detección de 16 simuladores de los 51 sujetos evaluados.

Los resultados del análisis multivariante de la varianza (MANOVA) indicaron que los simuladores obtuvieron puntuaciones significativamente superiores a las de los no simuladores en todas las escalas del SIMS (Lambda de Wilks=0,062, $F(5,49) = 149,31$, $p < 0,01$). Tal y como se puede observar en la tabla 4.22, las pruebas de t realizadas a continuación con cada escala del SIMS mostraron que en todas ellas había diferencias significativas entre las puntuaciones de ambos grupos. El tamaño del efecto de dicha diferencia (d de Cohen) fue mayor para la puntuación total que para las escalas de la prueba, tal y como cabría esperar, con un valor máximo de 3,0. La escala Psicosis obtuvo valores similares ($d=2,9$) mientras que las escalas Baja inteligencia y Trastornos afectivos fueron las que obtuvieron valores más bajos ($d=1,1$ y $d=1,8$ respectivamente). Este patrón de diferencias parece razonable en el contexto de evaluación y en los perfiles de simulación que cabría esperar.

Tabla 4.22. Puntuaciones medias en el SIMS del grupo de respuesta sincera y de simuladores. Estudio independiente de Lewis, Simcox y Berry (2002)

Escalas del SIMS	Respuesta sincera ^a		Simuladores ^b		t	d
	M	Dt	M	Dt		
Total	14,5	8,8	42,8	10,6	-10,8**	3,0
Psicosis	1,2	2,1	9,0	3,4	-10,0**	2,9
Deterioro neurológico	2,4	2,1	9,5	3,6	-9,2**	2,5
Trastornos amnésicos	2,5	3,5	9,5	3,6	-7,3**	2,0
Baja inteligencia	3,2	2,1	5,8	2,8	-3,9**	1,1
Trastornos afectivos	5,2	2,6	9,0	1,6	-6,7**	1,8

Nota. $n^s = 31$; $n^b = 24$ ** $p < 0,01$. Extraído de J. L. Lewis, A. M. Simcox y D. T. R. Berry (2002). Screening for Feigned Psychiatric Symptoms in a Forensic Sample by Using the MMPI-2 and the Structured Inventory of Malingered Symptomatology. *Psychological Assessment*, 14, p. 173. Adaptado con permiso del editor.

El análisis de regresión logística realizado señaló que la puntuación total del SIMS predecía significativamente el nivel de simulación tal y como era establecida por la SIRS ($R^2=0,61$, $odd-ratio=1,27$, $p<0,05$). Por otra parte, los autores también realizaron análisis de sensibilidad y especificidad de la puntuación total del SIMS (tabla 4.23) con un punto de corte de 16. Todos los simuladores fueron detectados por el SIMS como tales (sensibilidad = 100%) si bien se clasificaron erróneamente un 39% de sujetos no simuladores (respuesta sincera) como simuladores. Si tenemos en cuenta las tasas de prevalencia, el SIMS mostró un valor predictivo positivo atenuado, ya que solo el 54% de los sujetos identificados como simuladores por el SIMS eran realmente simuladores. Por el contrario, todos los individuos clasificados como no-simuladores eran realmente no-simuladores (valor predictivo negativo = 100%). Este perfil de clasificación se ajusta al objetivo de *screening* de la prueba que detecta a todo posible simulador (excluyendo solamente a aquellos que claramente tienen un patrón de respuesta honesta) para que en una segunda fase de evaluación se criben esos casos con medidas con mayores valores de especificidad y valor predictivo positivo.

Tabla 4.23. Precisión predictiva de la puntuación total del SIMS. Estudio independiente de Lewis, Simcox y Berry (2002)

Total SIMS>16	Precisión
Sensibilidad	1,00
Especificidad	0,61
Valor predictivo positivo	0,54
Valor predictivo negativo	1,00
Tasa de acierto	0,73

Nota. $N=51$. Extraído de J. L. Lewis, A. M. Simcox y D. T. R. Berry (2002). Screening for Feigned Psychiatric Symptoms in a Forensic Sample by Using the MMPI-2 and the Structured Inventory of Malingered Symptomatology. *Psychological Assessment*, 14, p. 173. Adaptado con permiso del editor.



ESTUDIO DE GRUPOS DIAGNÓSTICOS DE HEINZE Y PURISCH (2001)

Heinze y Purisch estudiaron la utilidad del SIMS en una muestra de 57 varones clasificados como simuladores de ser no competentes para ser juzgados. Estos sujetos habían sido identificados como tales en una muestra más amplia de 438 varones de acuerdo a una evaluación clínica que no incluía el SIMS entre sus instrumentos. La tasa de prevalencia en esta muestra es del 13%. El acuerdo interjueces entre el psicólogo evaluador y el equipo multidisciplinar de tratamiento en la clasificación de estos sujetos como simuladores fue alto (0,92).

Las puntuaciones medias en el SIMS de esta muestra fueron comparadas con las medias hipotéticas de poblaciones clínicas y de simuladores en el SIMS de acuerdo a una revisión bibliográfica de la información disponible a este respecto. Como puede advertirse en la tabla 4.24 las puntuaciones del grupo de simuladores de este estudio obtuvieron puntuaciones notable y significativamente superiores a las de una hipotética muestra clínica, lo que parece aportar evidencias de la capacidad del SIMS para diferenciar entre simulación y psicopatología. Por otro lado, cuando se comparan sus resultados con los de una hipotética muestra de simuladores se observa que obtienen puntuaciones ligeramente inferiores, siendo las puntuaciones del total y de la escala Psicosis significativamente inferiores. No obstante, estas comparaciones se encuentran seriamente limitadas por la falta de muestras específicas de control y referencia y por el uso de medias hipotéticas basadas en la revisión de la bibliografía existente.

Tabla 4.24. Puntuaciones medias en el SIMS del grupo de simuladores de incapacidad para ser sometidos a juicio y medias estimadas de la población clínica y de simuladores. Estudio independiente de Heinze y Purisch (2001)

Escala del SIMS	Simuladores ^a		Muestra clínica hipotética	t	Muestra de simuladores hipotética	
	M	ET			M	t
Total	33,66	2,30	8,09	11,12**	40,71	-3,70***
Psicosis	6,84	1,06	0,67	5,82**	9,95	-2,93***
Deterioro neurológico	6,97	0,62	1,00	9,63**	8,08	-1,79***
Trastornos amnésicos	9,26	1,04	1,05	7,89**	8,78	0,46***
Baja inteligencia	6,45	0,89	1,97	5,03**	6,20	0,28***
Trastornos afectivos	8,16	0,63	3,94	6,70**	7,69	0,75***

Nota. n^a= 57; ** p < 0,01; *** p < 0,005; ET=Error típico. Extraído de M. C. Heinze y A. D. Purisch (2001). Beneath the Mask: Use of Psychological Tests to Detect and Subtype Malingering in Criminal Defendants. *Journal of Forensic Psychology Practice*, 1, p. 31. Adaptado con permiso del editor.

La tabla 4.25 muestra las estimaciones de sensibilidad del SIMS en la detección de simuladores empleando unos puntos de corte específicos para su estudio (Heinze y Purisch, 2001) que son un punto inferiores a los recomendados por los autores originales. Los resultados muestran una razonable capacidad del SIMS para la detección de los simuladores en las distintas escalas consideradas, si bien en este estudio la puntuación total muestra una menor sensibilidad (0,87) que las escalas (con un rango de 0,89 a 1,00).



**Tabla 4.25. Sensibilidad de las escalas del SIMS para la detección de simuladores.
Estudio independiente de Heinze y Purisch (2001)**

Escalas del SIMS	Sensibilidad
Total > 13	0,87
Psicosis > 0	0,89
Deterioro neurológico > 1	1,00
Trastornos amnésicos > 1	1,00
Baja inteligencia > 1	1,00
Trastornos afectivos > 4	0,89

Nota. N=57. Extraído de M. C. Heinze y A. D. Purisch (2001). *Beneath the Mask: Use of Psychological Tests to Detect and Subtype Malingering in Criminal Defendants. Journal of Forensic Psychology Practice*, 1, p. 31. Adaptado con permiso del editor.

ESTUDIO DE SIMULACIÓN CON ADOLESCENTES DE ROGERS, HINDS Y SEWELL (1996)

El estudio de Rogers, Hinds y Sewell investigó por primera vez el SIMS con adolescentes. Para ello contaron con una muestra de 53 adolescentes con diagnóstico dual de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años y que habían sido remitidos por el juzgado para recibir tratamiento psicológico en una residencia. Los adolescentes cumplimentaron el SIMS junto con otras medidas de simulación en dos condiciones: respuesta sincera y simulación. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a una de las siguientes condiciones de simulación: a) esquizofrenia, b) depresión mayor y c) trastorno de ansiedad generalizada. Se les proporcionó a los participantes una descripción del trastorno a simular junto con sus principales síntomas y se les informaba que tendrían una compensación económica tanto por su participación como si conseguían evitar ser detectados como simuladores.

Los autores analizaron el valor predictivo positivo y negativo del SIMS obteniendo valores moderados, tal y como se puede observar en la tabla 4.26, en un contexto donde la tasa de simulación era del 50%. Utilizando un punto de corte >16 en la puntuación total, de los participantes clasificados como simuladores por el SIMS solo un 13% eran erróneamente clasificados al ser de respuesta sincera (valor predictivo positivo = 0,87). No obstante, un 38% de los identificados como de respuesta sincera eran realmente simuladores (valor predictivo negativo = 0,62). Ante estos resultados, los autores propusieron un aumento notable de los puntos de corte recomendados para obtener un mayor valor predictivo negativo aunque se redujera el valor predictivo positivo. De este modo podría mejorar su funcionamiento como prueba de *screening* que solo excluye a los que claramente son honestos y no están simulando (valor predictivo negativo próximo a 1) a cambio de incluir dentro de los seleccionados algunos que realmente no son simuladores (valor predictivo positivo más bajo). Con el objetivo de aumentar el valor predictivo negativo, los autores de este estudio propusieron un punto de corte para la puntuación total del SIMS de 40. En este caso se obtenía un valor predictivo positivo de 0,49 (de los clasificados como simuladores por el SIMS solo un 49% son realmente simuladores) y un valor predictivo negativo de 0,94 (de los clasificados como no simuladores por el SIMS el 94% eran efectivamente no simuladores, solo un 6% de los simuladores no eran detectados por el *screening*). Rogers y colaboradores optaban de este modo por potenciar el SIMS como prueba claramente de *screening* que incluyera a todos los posibles simuladores, reduciendo al máximo el valor predictivo negativo.



Tabla 4.26. Sensibilidad de las escalas del SIMS en adolescentes. Estudio independiente de Rogers, Hinds y Sewell (1996)

Escalas del SIMS	Punto de corte	Criterios propuestos		Punto de corte	Criterios óptimos	
		Valor predictivo positivo	Valor predictivo negativo		Valor predictivo positivo	Valor predictivo negativo
Total	> 16	0,87	0,62	> 40	0,49	0,94
Psicosis	> 2	0,77	0,70	> 9	0,43	0,91
Deterioro neurológico	> 3	0,83	0,62	> 8	0,57	0,94
Trastornos amnésicos	> 4	0,74	0,68	> 10	0,41	0,94
Baja inteligencia	> 4	0,58	0,81	> 7	0,28	0,93
Trastornos afectivos	> 5	0,91	0,70	> 7	0,68	0,91

Nota. N=57. Extraído de R. Rogers, J. D. Hinds y K. W. Sewell (1996). Feigning Psychopathology Among Adolescent Offenders: Validation of the SIRS, MMPI-A and SIMS. *Journal of Personality Assessment*, 67, p. 251. Adaptado con permiso del editor.

ESTUDIO DE GRUPOS DIAGNÓSTICOS Y SIMULACIÓN DE CLEGG (2007)

El estudio de Clegg (2007) contó con una muestra de 64 personas que estaban siendo evaluadas para la concesión de discapacidad en la seguridad social por deterioro funcional. La mayoría de los casos (88,4%) fueron diagnosticados primariamente de trastornos del estado de ánimo, siendo el resto, a excepción de un adulto con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastornos de ansiedad. Su edad media fue de 42,5 años ($Dt=11,9$), siendo el 62% de los casos mujeres. Además, se seleccionó una muestra de 63 personas procedente de diferentes entornos comunitarios que fueron asignadas aleatoriamente a un grupo de respuesta sincera o de simulación de depresión. Su edad media fue de 39,9 años ($Dt=15,2$), siendo el 68% de los casos mujeres.

Todos los individuos fueron evaluados con el SIMS, además de con otra prueba, el ADI (*Assessment of Depression Inventory*; Mogge y LePage, 2004). La muestra evaluada para la concesión de discapacidad fue también evaluada con la SIRS (*Structured Interview of Reported Symptoms*; Rogers, Bagby y Dickens, 1992), siendo clasificada a partir de sus resultados en esta entrevista como simuladores o de respuesta honesta. De los 64 casos, 36 fueron clasificados como de respuesta honesta y 20 como posibles simuladores. Los 8 casos restantes no pudieron ser clasificados claramente por la SIRS como simuladores o de respuesta honesta, por lo que fueron excluidos de los análisis.

La muestra comunitaria fue previamente evaluada con el SCL-90-R (Derogatis, 1975) para descartar la presencia de sintomatología psicopatológica. Tres casos fueron excluidos por este motivo, resultando la muestra final que se empleó en los análisis de 30 casos en la condición de respuesta honesta y 30 en la de simulación.

En la tabla 4.27 aparecen las medias y desviaciones típicas de cada grupo en el SIMS. Puede advertirse cómo existen notables diferencias entre las puntuaciones de los grupos de respuesta honesta (tanto de la muestra comunitaria como de la procedente de la valoración de discapacidad) y los grupos de simuladores, apuntando a la satisfactoria capacidad del SIMS para discriminar entre ambos grupos. La puntuación total del SIMS y la escala Trastornos afectivos fueron aquellas que mayores diferencias establecieron entre ambos grupos, tal y como cabría esperar puesto que éste era el ámbito de simulación.



Tabla 4.27. Puntuaciones medias y desviaciones típicas en las escalas del SIMS de los grupos experimentales y de respuesta sincera. Estudio independiente de Clegg (2007)

Escalas del SIMS	Respuesta honesta				Simulación				Tamaño del efecto d de Cohen	
	Muestra comunitaria (n=30)		Muestra valoración discapacidad (n=35)		Muestra comunitaria (n=30)		Muestra valoración discapacidad (n=20)		Muestra comunitaria (hon. vs. sim)	Muestra valoración discapacidad (hon. vs. sim)
	M	Dt	M	Dt	M	Dt	M	Dt	d	d
Total	7,7	2,9	17,1	6,6	26,6	14,6	30,2	9,1	1,8	1,6
Psicosis	0,2	0,4	0,5	1,3	2,7	4,5	3,4	3,5	0,8	1,1
Deterioro neurológico	1,3	1,6	4,2	2,7	5,6	4,6	6,0	3,1	1,3	0,6
Trastornos amnésicos	0,5	0,8	3,3	2,7	5,8	4,9	7,4	2,9	1,5	1,5
Baja inteligencia	1,4	1,5	2,6	2,4	2,8	2,3	3,6	2,4	0,7	0,4
Trastornos afectivos	4,4	1,5	6,6	1,8	9,6	1,7	9,7	1,6	3,3	1,8

Clegg (2007) estudió también la utilidad de la prueba en la clasificación en ambos grupos, obteniendo sus valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo para diversos puntos de corte alternativos del total del SIMS. En la tabla 4.28 se detallan los valores hallados para diversos puntos de corte. Se muestran los valores de los puntos de corte de >14 y >16, ya que son los que clásicamente se han manejado en la investigación con el SIMS, y el punto de corte de >19 que es el propuesto específicamente por Clegg para el uso del SIMS de acuerdo a sus resultados.

Para justificar su recomendación del punto de corte de 19 en el contexto de su estudio, Clegg afirma que ese punto de corte permite mejorar notablemente la especificidad (y por lo tanto el valor predictivo positivo), lo que conlleva descartar un mayor número de casos para una siguiente fase de evaluación, sin que esto afecte excesivamente a los niveles de sensibilidad y valor predictivo negativo. En palabras del propio Clegg (2007, p. 24): «Idealmente el punto de corte de un instrumento de *screening* debería obtener una casi perfecta sensibilidad y valor predictivo negativo a la vez que valores razonables de especificidad y valor predictivo positivo. Visto de este modo, el punto de corte de 14, en los casos de evaluación de discapacidad de este estudio, solo permitiría evitar la remisión a una evaluación más exhaustiva de un 20% del total de casos (11 de 55) (...) No obstante, utilizando el punto de corte de 19 se habría evitado realizar la evaluación más extensa a prácticamente la mitad de los individuos (un 47%), habiendo solo dos casos de falsos negativos».

Tabla 4.28. Precisión predictiva de la puntuación total del SIMS al clasificar a los participantes como del grupo de respuesta honesta o del grupo de simuladores. Muestra de evaluación de discapacidad. Estudio independiente de Clegg (2007)

Total SIMS	Punto de corte >14	Punto de corte >16	Punto de corte >19
Sensibilidad	1,00	0,95	0,90
Especificidad	0,37	0,51	0,69
Valor predictivo positivo	0,48	0,53	0,62
Valor predictivo negativo	1,00	0,95	0,92

Clegg (2007) estudió también la utilidad de los puntos de corte de cada una de las escalas, sin sugerir en este caso puntos de corte alternativos. Obtuvo los resultados que aparecen en la tabla 4.31. Tal y como cabría esperar las escalas que mayor sensibilidad presentan son Trastornos afectivos y Trastornos amnésicos.



cos, si bien obtienen también valores bajos de especificidad. Cabría plantearse, tal y como hizo el autor de este estudio con la puntuación total, aumentar el valor de punto de corte para obtener una mayor especificidad.

Tabla 4.29. Precisión predictiva de la puntuación en cada una de las escalas del SIMS al clasificar a los participantes como del grupo de respuesta honesta o del grupo de simuladores. Muestra clínica. Estudio independiente de Clegg (2007)

Escalas del SIMS	Punto de corte	Sensibilidad	Especificidad	Valor predictivo positivo	Valor predictivo negativo
Psicosis	> 1	0,65	0,94	0,87	0,83
Deterioro neurológico	> 2	0,80	0,40	0,43	0,78
Trastornos amnésicos	> 2	1,00	0,54	0,56	1,00
Baja inteligencia	> 2	0,70	0,63	0,52	0,79
Trastornos afectivos	> 5	1,00	0,29	0,44	1,00

4.3.2.3. Estudios de la adaptación española

ESTUDIO ANÁLOGO DE SIMULACIÓN DE GONZÁLEZ ORDI, SANTAMARÍA FERNÁNDEZ Y MATALOBOS VEIGA (2008)

Como se describió previamente en el apartado 4.1.1 de este capítulo, en los estudios de la adaptación española se contó con una muestra de 473 sujetos en un estudio análogo, de los cuales 147 fueron asignados al grupo control y 326 a las distintas condiciones experimentales de simulación. Los controles fueron instruidos para que respondieran honestamente a la prueba. Los simuladores análogos fueron subdivididos en distintas condiciones experimentales y a cada uno de esos grupos se les instruyó para que simularan un tipo de trastorno o problema diferente con unos determinados incentivos hipotéticos (p. ej., una reducción de condena por enajenación mental por psicosis, indemnización por accidente, baja laboral por problemas emocionales...), advirtiéndoles de que debían simular de una manera convincente, de forma que no se detectara que estaba mintiendo. Con este objetivo se incluyó el siguiente texto en todas las instrucciones de los grupos de simuladores: «(...) Nos gustaría que contestes a la prueba sin perder de vista esta intención, pero tratando de que las respuestas sean lo más convincentes posibles, es decir, sin que puedan detectar que estás mintiendo (...)».

El primer grupo de simuladores fue instruido para que simulara un *mal estado general* tanto psicológico como físico; el segundo grupo fue instruido para que simulara la existencia de un trastorno mental severo («te sientes como extraño, como si no fueras tú, como si tu mente estuviera fuera de control y hubieras perdido el juicio») que hace que no fueran responsables del delito violento que cometieron, con el objetivo de reducir la condena y el tipo de prisión asignada; este grupo se ha etiquetado como de *enajenación mental por psicosis*. El tercer grupo era informado de que habían tenido un accidente y que, aunque no tenían grandes secuelas, querían aparentar que estaban afectados seriamente por el accidente para conseguir una indemnización económica; se consideró como grupo de *simulación del deterioro neurológico*. Al cuarto grupo se le pedía que simulara *problemas de memoria* («quieres aparentar que de alguna manera tu memoria no funciona bien desde hace tiempo»). Al quinto grupo, etiquetado como de *retraso intelectual*, se le pidió que simulara una limitada inteligencia con el objetivo de conseguir una pensión o subsidio. El sexto grupo fue instruido para simular *problemas emocionales graves* con los que conseguir una baja laboral. El séptimo grupo, denominado de *patología dolorosa*, fue instruido para simular la presencia de dolores intensos en distintas partes del cuerpo que limitaban y dificultaban su vida («te encuentras psicológica y físicamente muy afectado porque sufres dolores intensos en distintas partes de tu cuerpo, como las articulaciones, la cabeza y otras zonas.Quieres aparentar que el dolor es bastante fuerte y continuo, que lo sufres a diario, que te irrita, te angustia y te deprime»).



Se calcularon las puntuaciones medias en las escalas del SIMS de cada uno de estos grupos (tabla 4.30). Las diferencias encontradas fueron significativas como puede advertirse en la tabla 4.31. Además se realizó la prueba de rango múltiple de Duncan ($\alpha=0,05$) para especificar qué grupos se diferenciaban significativamente entre sí en cada una de las escalas de la prueba, de forma que pudiera estudiarse la concordancia entre la estructura hipotetizada del SIMS y los resultados en los grupos experimentales.

En todos los casos el grupo control fue el que obtuvo puntuaciones significativamente inferiores al resto de grupos. En general, las puntuaciones más altas en cada escala fueron obtenidas por el grupo de simulación de mal estado general y el grupo experimental específico a la escala correspondiente (p. ej., el grupo de simulación de enajenación mental por psicosis en la escala Psicosis). Además resulta interesante observar el perfil de puntuaciones de cada grupo, advirtiendo cómo, por ejemplo, el grupo al que se le pidió que simulara que estaba padeciendo secuelas por un accidente obtuvo puntuaciones altas tanto en la escala Deterioro neurológico como en las escalas Trastornos amnésicos y Trastornos afectivos, de forma coherente a lo que cabría esperar que simulara este grupo experimental. El grupo de patología dolorosa obtuvo puntuaciones especialmente destacadas en las escalas Deterioro neurológico y Trastornos afectivos (como se verá más adelante en el estudio de Capilla Ramírez, González Ordi y Santamaría Fernández, 2008, se obtuvieron resultados similares en grupos de simuladores de dolor crónico en contextos médico-legales).

Como síntesis, podría concluirse que, de forma similar a lo obtenido en los estudios originales de la prueba, el patrón general de las puntuaciones medias de los distintos grupos experimentales proporciona evidencias razonables sobre la capacidad de las escalas del SIMS para diferenciar entre: a) la simulación de sintomatología de diferentes tipos y la respuesta honesta, b) la simulación indiferenciada de sintomatología y la respuesta honesta y c) entre tipos específicos de simulación de síntomas.

Tabla 4.30. Puntuaciones medias y desviaciones típicas en las escalas del SIMS de los grupos experimentales y control. Estudios de la adaptación española

Escalas del SIMS	Grupo experimental de simulación															
	Grupo control ¹		Mal estado general ²		Enajenación mental por psicosis ³		Accidente ⁴		Problemas de memoria ⁵		Retraso intelectual ⁶		Problemas emocionales ⁷		Patología dolorosa ⁸	
	M	Dt	M	Dt	M	Dt	M	Dt	M	Dt	M	Dt	M	Dt	M	Dt
Total	7,6	3,6	52,3	8,3	40,7	10,2	32,9	12,1	31,8	8,7	36,7	10,2	30,8	9,6	23,4	9,5
Psicosis	0,4	0,7	9,5	5,8	9,3	3,6	5,0	4,3	3,0	3,7	4,6	4,1	3,7	3,3	2,6	3,0
Deterioro neurológico	0,8	1,2	12,8	1,7	7,6	2,8	7,5	3,3	5,0	3,5	6,6	3,1	7,3	3,2	5,7	3,4
Trastornos amnésicos	0,8	1,2	11,3	3,1	10,0	4,0	6,6	4,0	12,8	2,1	9,4	3,4	6,2	3,6	3,2	3,6
Baja inteligencia	1,8	1,4	9,8	3,6	4,6	2,8	4,4	2,8	3,5	1,4	8,3	3,1	3,3	1,8	2,6	1,4
Trastornos afectivos	3,8	1,7	9,0	1,8	9,2	2,1	9,5	2,3	7,5	4,1	7,8	2,5	10,4	1,8	9,2	2,0

Nota. N= 443. n¹ = 147 n² = 4 n³ = 64 n⁴ = 120 n⁵ = 6 n⁶ = 45 n⁷ = 53 n⁸ = 34. Aparecen destacadas en negrita las puntuaciones medias y desviaciones típicas de cada grupo en las escalas específicas del SIMS relacionadas con la condición simulada (p.ej., del grupo de simulación de problemas emocionales en la escala de Trastornos afectivos del SIMS).



Tabla 4.31. Análisis de varianza (ANOVA) de las puntuaciones del SIMS en los distintos grupos experimentales considerados. Estudios de la adaptación española

Escalas del SIMS	F	g.l.	p	R ²
Total	134,8	7	> 0,001	0,67
Psicosis	54,9	7	> 0,001	0,45
Deterioro neurológico	85,7	7	> 0,001	0,56
Trastornos amnésicos	84,2	7	> 0,001	0,56
Baja inteligencia	49,4	7	> 0,001	0,43
Trastornos afectivos	108,1	7	> 0,001	0,62

Nota. N= 473.

Tabla 4.32. Grupos creados por la prueba de rangos múltiples de Duncan en las escalas del SIMS en los grupos experimentales y control. Estudios de la adaptación española

Escalas del SIMS	Grupo experimental de simulación							
	Grupo control ¹	Mal estado general ²	Enajenación mental por psicosis ³	Accidente ⁴	Problemas de memoria ⁵	Retraso intelectual ⁶	Problemas emocionales ⁷	Patología dolorosa ⁸
	M	M	M	M	M	M	M	M
Total	8 _e	52 _a	41 _b	33 _c	32 _c	37 _{bc}	31 _c	23 _d
Psicosis	0 _e	10 _a	9 _a	5 _b	3 _b	5 _b	4 _b	3 _{bc}
Deterioro neurológico	1 _d	13 _a	8 _b	7 _b	5 _c	7 _{bc}	7 _b	6 _{bc}
Trastornos amnésicos	1 _a	11 _{ab}	10 _b	7 _c	13 _a	9 _b	6 _c	3 _d
Baja inteligencia	2 _c	10 _a	5 _b	4 _b	4 _{bc}	8 _a	3 _{bc}	3 _c
Trastornos afectivos	4 _d	9 _{abc}	9 _{ab}	9 _a	8 _c	8 _{bc}	10 _a	9 _{ab}

Nota. N= 473. n¹ = 147; n² = 4; n³ = 64; n⁴ = 120; n⁵ = 6; n⁶ = 45; n⁷ = 53; n⁸ = 34. Las medias han sido redondeadas al entero más próximo. El subíndice (a, b, c, d, e...) indica a qué grupo pertenece la puntuación de acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Duncan. Los grupos son formados de modo que sean significativas las diferencias entre sus medias. El grupo etiquetado como "a" es el que obtiene una puntuación significativamente más alta, seguido por el grupo etiquetado como "b", seguido por el "c"... hasta el último grupo que se haya detectado en la prueba. Cuando aparecen dos subíndices juntos (por ejemplo, ab), indica que esos casos no se diferencian significativamente de ninguno de esos dos grupos (a y b) y por lo tanto debe ser etiquetada como perteneciente a ambos.

Aparecen destacadas en negrita las puntuaciones medias de cada grupo en las escalas específicas del SIMS relacionadas con la condición simulada (p. ej., del grupo de simulación de problemas emocionales en la escala Trastornos afectivos del SIMS).

Se calcularon también las medias y desviaciones típicas del grupo general de simuladores (que incluía todas las condiciones experimentales) y el grupo control y se calculó como medida del tamaño del efecto la *d* de Cohen denominada «diferencia típica» (Cohen, 1996). El tamaño del efecto informa de cuánto de grande es la diferencia existente entre dos grupos. Una vez que sabemos que una diferencia es significativa (es decir, es real y no debida al azar) cabe preguntarse cuál es su magnitud, su tamaño. Cohen (1988) sugirió como guía de interpretación de dichos tamaños los siguientes criterios: valores de *d* entre 0,20 y 0,49 son considerados como pequeños; valores entre 0,50 y 0,79 como moderados y valores de 0,80 y superiores como grandes. No obstante, Rogers (2008a) sugirió que en el contexto concreto de valoración de la capacidad discriminativa de instrumentos de simulación se emplearan otros criterios: valores de *d* entre 0,75 y 1,24 son considerados moderados; valores entre 1,25 y 1,50 como grandes y valores superiores a 1,50 como muy grandes.

Tal y como puede observarse en la tabla 4.33, los grupos control y de simuladores tienen puntuaciones notablemente diferentes en las escalas del SIMS siendo más altas las del grupo de simuladores, coherentemen-



te con las investigaciones previas. El tamaño del efecto puede clasificarse como «muy grande» en prácticamente todas las escalas, siguiendo los criterios de Rogers (2008a), a excepción de Baja inteligencia cuyo valor de d sería etiquetado como moderado. Estos resultados respaldan la idea de que el SIMS es capaz de discriminar entre aquellos que responden honestamente a la prueba y un grupo variado e indiferenciado de simuladores, tal y como podrían darse en el mundo real.

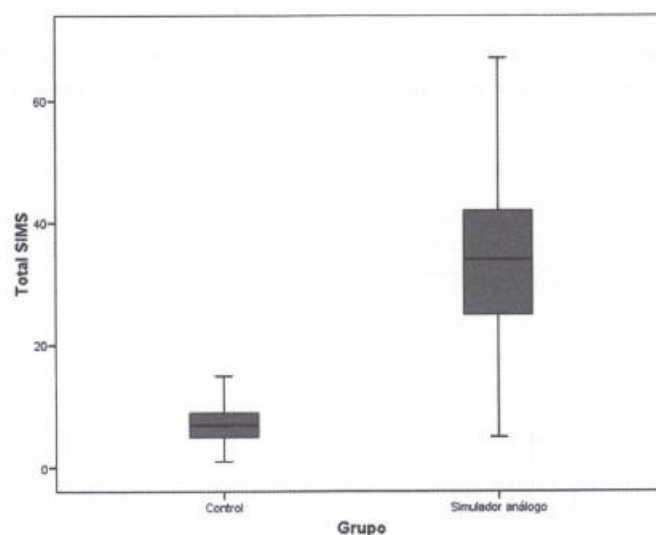
Tabla 4.33. Puntuaciones medias en las escalas del SIMS del grupo control y del grupo global de simuladores. Estudios de la adaptación española

Escalas del SIMS	Grupo control ^a		Grupo simulador ^b		d
	M	Dt	M	Dt	
Total	7,6	3,6	33,8	12,0	3,0
Psicosis	0,4	0,7	5,3	4,4	1,6
Deterioro neurológico	0,8	1,2	7,2	3,3	2,6
Trastornos amnésicos	0,8	1,2	7,4	4,3	2,1
Baja inteligencia	1,8	1,4	4,7	3,1	1,2
Trastornos afectivos	3,8	1,7	9,2	2,4	2,6

Nota. N=473; n^a = 147 ; n^b = 326.

En las figuras 4.2 y 4.3 aparecen representadas gráficamente las diferencias entre ambos grupos tanto en el total del SIMS (Figura 4.2) como en cada una de sus escalas (figura 4.3). Se puede apreciar que existen diferencias notables entre ambos grupos en todas las escalas, siendo especialmente marcadas en el caso de la puntuación total (figura 4.2). Tal y como se comentaba previamente, la escala Baja inteligencia es la que menores diferencias establece entre ambos grupos, aunque el tamaño del efecto evaluado con la d de Cohen sigue siendo «moderado» (Rogers, 2008a, tabla 4.33).

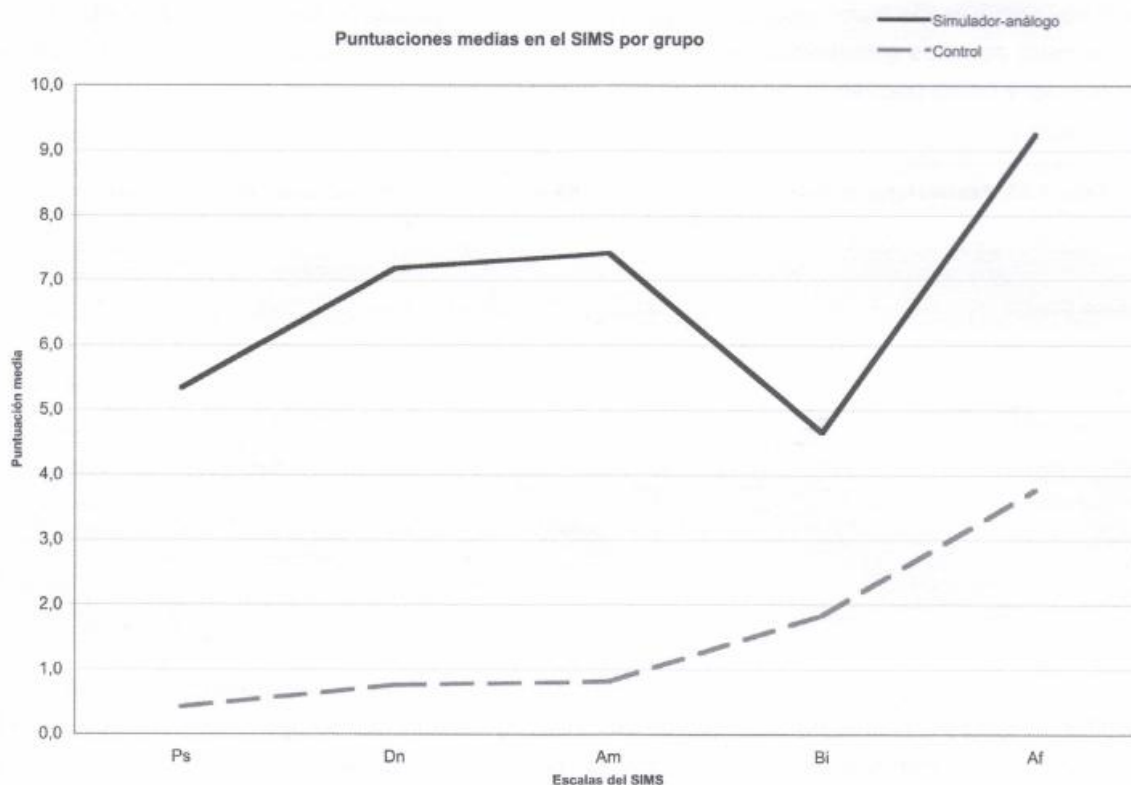
Figura 4.2. Diagrama de caja y bigotes² de la puntuación total en el SIMS en el grupo control y en el grupo de simuladores. Datos de la adaptación española



- Los diagramas de caja y bigotes son gráficos que representan la distribución de una puntuación en distintos grupos. La caja central indica el rango en el que se concentra el 50% central de los datos. Sus extremos son, por lo tanto, el 1º y 3º cuartil de la distribución (percentil 25 y 75). La línea central en la caja es la mediana. Los extremos de los «bigotes» que salen de la caja son los valores que delimitan el 95% central de los datos. De este modo representa en qué rango de puntuaciones se sitúan la mayoría de los sujetos en cada uno de los grupos.

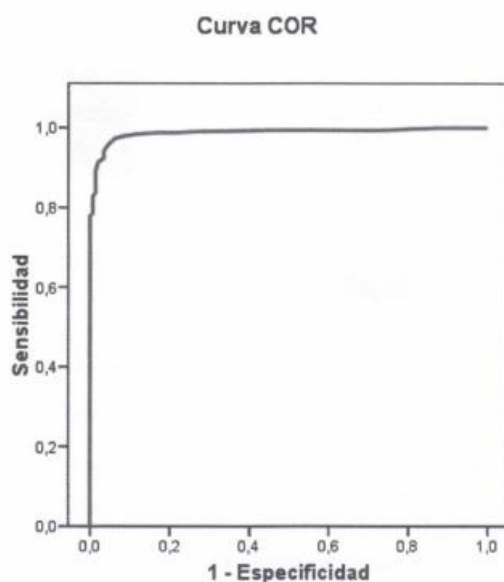


Figura 4.3. Puntuaciones medias en las escalas del SIMS en el grupo control y el grupo global de simuladores análogos. Datos de la adaptación española



También se realizaron curvas COR para examinar la utilidad del SIMS como herramienta predictiva a la hora de discriminar entre los participantes del grupo control y los del grupo simulador. En la figura 4.4 aparece la curva COR de la puntuación total del SIMS al clasificar a los sujetos en el grupo control o de simuladores. Como puede observarse, se aleja notablemente de la línea diagonal indicando un excelente nivel de clasificación.

Figura 4.4. Curva característica del receptor (COR) de la puntuación total del SIMS en la clasificación del grupo control y del grupo global de simuladores. Datos de la adaptación española





Se calcularon los índices de sensibilidad (el grado con que el SIMS detecta adecuadamente a los simuladores), especificidad (el grado con que el SIMS excluye correctamente a los sujetos de respuesta honesta) y el valor del área bajo la curva AUC (la probabilidad de que los sujetos seleccionados aleatoriamente como simuladores presentarán puntuaciones más elevadas en el SIMS que los sujetos seleccionados aleatoriamente como clínicos) que aparecen en la tabla 4.34. También se han incluido el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo considerando tasas de prevalencia del 30% de acuerdo a los estudios de Mittenberg, Patton, Canary y Condit (2002) en casos de evaluación de discapacidad.

Como puede observarse, utilizando el punto de corte propuesto por los autores originales (mayor de 14 puntos) el SIMS permite clasificar correctamente al 96% de los simuladores, clasificando erróneamente como simuladores sólo a un 5% (especificidad 0,95) de los sujetos del grupo de respuesta honesta o grupo control. Si se considera una tasa de prevalencia del 20%, el valor predictivo negativo (la probabilidad de que un resultado negativo en el test sea indicativo de respuesta honesta o sintomatología genuina) y positivo (la probabilidad de que un resultado positivo en el test sea indicativo de simulación) respaldan su uso como *screening* indicando que el 99% de los que obtengan una puntuación inferior o igual a 14 efectivamente no serán del grupo de simuladores sino del grupo de respuesta honesta (valor predictivo negativo), si bien sólo el 83% de los que superen ese punto de corte serán realmente del grupo de simuladores (valor predictivo positivo). Si se utiliza el punto de corte de 16 (propuesto en distintas investigaciones sobre la prueba), aumenta proporcionalmente su especificidad conforme se reduce su sensibilidad.

Tabla 4.34. Precisión predictiva de la puntuación total del SIMS al clasificar a los participantes como del grupo control o del grupo de simuladores análogos. Estudios de la adaptación española

Total SIMS	Punto de corte >14	Punto de corte >16
Área bajo la curva	0,99	
Sensibilidad	0,96	0,92
Especificidad	0,95	0,97
Valor predictivo positivo	0,89	0,93
Valor predictivo negativo	0,98	0,97

Nota. N=473 ($n_{\text{control}} = 147$; $n_{\text{simuladores}} = 326$). Se ha calculado el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo considerando una tasa de prevalencia de la simulación del 30% (Mittenberg, Patton, Canary y Condit, 2002).

Se estudió también la sensibilidad y la especificidad de los puntos de corte establecidos en cada una de las escalas (tabla 4.35). Para ello se comparó en cada caso el grupo control con el grupo específico de simulación relacionado con cada escala (p. ej., para estudiar la sensibilidad y especificidad de la escala Psicosis se emplea el grupo control y el grupo experimental de simulación de enajenación mental por psicosis). Si se consideran los puntos de corte propuestos por los autores originales, los valores obtenidos de sensibilidad específicos para cada grupo de simuladores son muy satisfactorios (desde 1,00 en el caso de la escala Trastornos amnésicos a 0,93 en el caso de la escala Deterioro neurológico), con valores también altos de especificidad (desde 0,93 en el caso de la escala Deterioro neurológico a 0,67 en la escala Baja inteligencia).

Los puntos de corte alternativos propuestos en la adaptación española aumentan la especificidad obtenida (oscilando sus valores entre 0,89 en Baja inteligencia y 0,97 en Psicosis y Deterioro neurológico) con una ligera reducción de su sensibilidad (oscilando entre 0,89 de Deterioro neurológico a 1,00 de Trastornos afectivos). Se considera que estos puntos de corte permiten obtener un mejor equilibrio entre la deseada sensibilidad y especificidad en los resultados de la adaptación española. De hecho, uno de los autores originales de la prueba ha sugerido recientemente como línea de investigación futura la necesidad de incrementar el



punto de corte de 14 a 16 (Smith, 2008). Como se verá más adelante, los estudios con grupos clínicos que se realizaron en esta adaptación confirmaron estas alternativas.

Tabla 4.35. Sensibilidad y especificidad del SIMS en grupo control y de simuladores análogos. Estudios de la adaptación española

Escala del SIMS	Área bajo la curva	Puntos de corte propuestos por los autores originales			Puntos de corte alternativos propuestos en la adaptación española		
		Punto de corte	Sensibilidad	Especificidad	Punto de corte	Sensibilidad	Especificidad
Psicosis ^a	0,98	> 1	0,94	0,90	> 2	0,92	0,97
Deterioro neurológico ^b	0,97	> 2	0,93	0,93	> 3	0,88	0,97
Trastornos amnésicos ^c	0,99	> 2	1,00	0,91	> 3	1,00	0,95
Baja inteligencia ^d	0,97	> 2	0,96	0,67	> 3	0,93	0,89
Trastornos afectivos ^e	0,99	> 5	1,00	0,89	> 7	0,94	0,97

Nota. Cada grupo experimental de simulación fue comparado con el grupo control ($n_{\text{control}} = 147$). $n^a = 64$; $n^b = 120$; $n^c = 6$; $n^d = 45$; $n^e = 53$.

ESTUDIO DE SIMULACIÓN Y GRUPOS DIAGNÓSTICOS DE GONZÁLEZ ORDI Y SANTAMARÍA FERNÁNDEZ (2008)

Como se describió en el apartado 4.1.1 de este capítulo, en los estudios de la adaptación española se dispuso de una muestra de 152 sujetos clínicos (casos con algún trastorno psicológico o neurológico diagnosticado previamente) evaluados con el SIMS y procedentes de centros de salud mental, hospitales, asociaciones de afectados y centros de rehabilitación psicosocial (CRPS). La mayoría de la muestra tenía diagnósticos clasificados dentro de las categorías de Psicosis (30% de los casos), deterioro neurológico (22% de los casos) y trastornos afectivos (44% de los casos).

Se compararon los resultados obtenidos por este grupo clínico con los del grupo global de simuladores análogos y controles anteriormente comentados. Se calcularon las medias y desviaciones típicas de cada grupo y una medida del tamaño del efecto que indicara la capacidad discriminativa de las escalas del SIMS para diferenciar entre el grupo clínico y el grupo global de simuladores. Como ya se comentó previamente, se calculó como medida del tamaño del efecto la d de Cohen denominada «diferencia típica» (Cohen, 1996), cuyos valores se interpretarán siguiendo las sugerencias específicas de Rogers (2008a): valores de d entre 0,75 y 1,24 son considerados moderados; valores entre 1,25 y 1,50 como grandes y valores superiores a 1,50 como muy grandes.

Tal y como se puede advertir en la tabla 4.36 la puntuación total del SIMS muestra una satisfactoria capacidad discriminativa entre el grupo clínico y el grupo de simuladores, encontrándose diferencias significativas (tabla 4.37). El grupo de simuladores obtiene puntuaciones notablemente más altas no sólo que el grupo control sino que el grupo de sujetos clínicos, apoyando la capacidad del SIMS para discriminar entre aquellos casos con algún tipo de trastorno real (síntomatología genuina) y aquellos que están simulándolo. En las figuras 4.5 y 4.6 aparecen ilustradas gráficamente estas diferencias tanto en la puntuación total del SIMS como en cada una de sus escalas.



Tabla 4.36. Puntuaciones medias en las escalas del SIMS del grupo control, del grupo clínico y del grupo global de simuladores. Estudios de la adaptación española

Escalas del SIMS	Grupo control ^a		Grupo clínico ^b		Grupo simuladores ^c		Tamaño del efecto clínicos frente a simuladores	
	M	Dt	M	Dt	M	Dt	d	Categoría
Total	7,6	3,6	18,5	9,7	33,8	12,0	1,4	Grande
Psicosis	0,4	0,7	1,9	2,3	5,3	4,4	1,0	Moderado
Deterioro neurológico	0,8	1,2	4,1	3,1	7,2	3,3	1,0	Moderado
Trastornos amnésicos	0,8	1,2	3,5	3,2	7,4	4,3	1,0	Moderado
Baja inteligencia	1,8	1,4	2,7	1,7	4,7	3,1	0,8	Moderado
Trastornos afectivos	3,8	1,7	6,4	2,6	9,2	2,4	1,1	Moderado

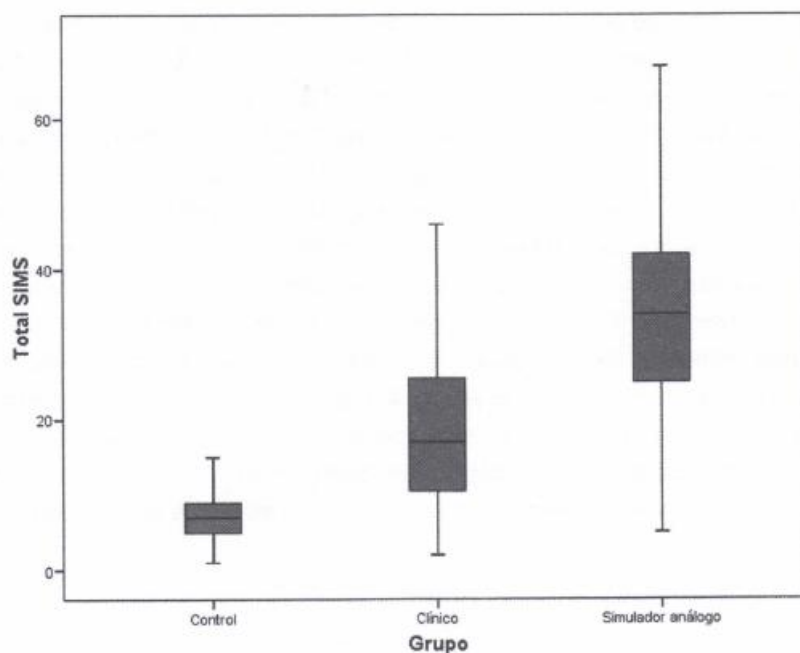
Nota. n^a= 147; n^b= 152; n^c= 326.

Tabla 4.37. Análisis de varianza (ANOVA) de las puntuaciones del SIMS en los grupos control, clínico y de simuladores análogos. Estudios de la adaptación española

Escalas del SIMS	F	g.l.	p	R ²
Total	379,5	2	> 0,001	0,55
Psicosis	125,5	2	> 0,001	0,29
Deterioro neurológico	261,5	2	> 0,001	0,46
Trastornos amnésicos	189,2	2	> 0,001	0,38
Baja inteligencia	76,8	2	> 0,001	0,20
Trastornos afectivos	312,3	2	> 0,001	0,50

Nota. N= 625.

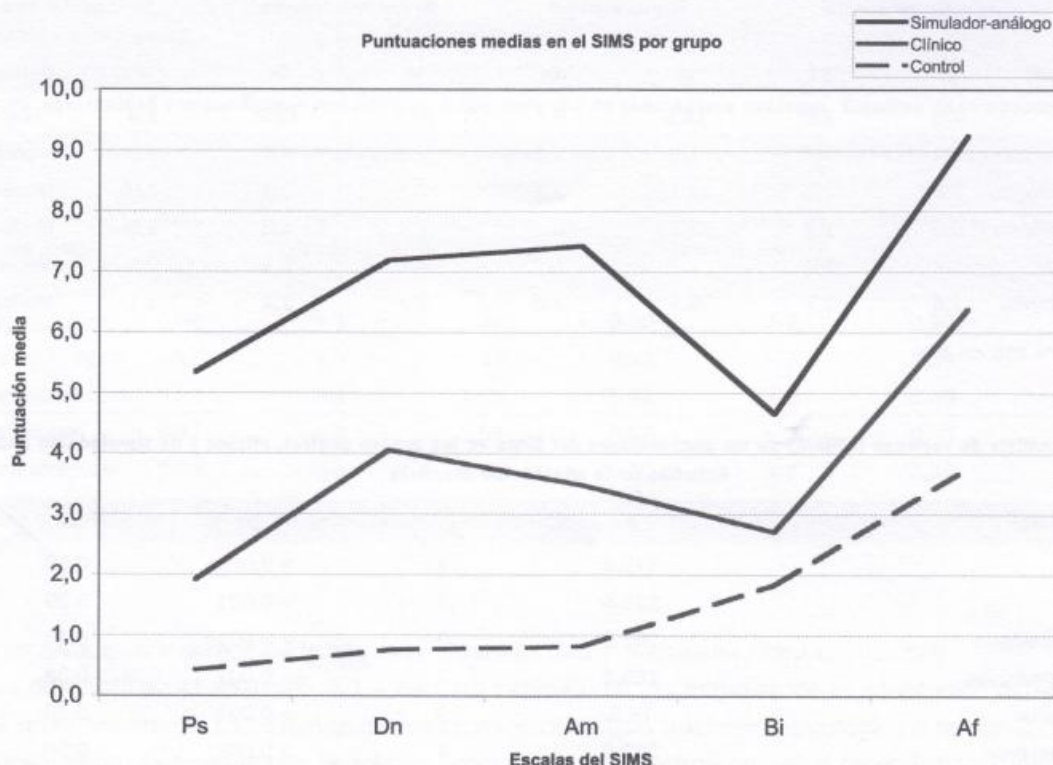
Figura 4.5. Diagrama de caja y bigotes³ de la puntuación total en el SIMS en los grupos control, clínico y de simuladores análogos. Datos de la adaptación española



3. Los diagramas de caja y bigotes son gráficos que representan la distribución de una puntuación en cada uno de los grupos. La caja central indica el rango en el que se concentra el 50% central de los datos. Sus extremos son, por lo tanto, el 1º y 3º cuartil de la distribución (percentil 25 y 75). La línea central en la caja es la mediana. Los extremos de los «bigotes» que salen de la caja son los valores que delimitan el 95% central de los datos. De este modo representa en qué rango de puntuaciones se sitúan la mayoría de los sujetos en cada uno de los grupos.



Figura 4.6. Puntuaciones medias en las escalas del SIMS en el grupo control y el grupo global de simuladores análogos. Datos de la adaptación española



Si dividimos a los grupos globales de clínicos y de simuladores por categorías y los comparamos⁴, tal y como aparece en la tabla 4.38, se puede advertir que el SIMS sigue mostrando una satisfactoria capacidad discriminativa tanto a nivel de la puntuación total como de la escala específica referida al trastorno simulado. Así la escala Psicosis muestra un gran capacidad discriminativa (d de Cohen=2,3) entre aquellos casos clínicos psicóticos y los que fueron instruidos para simular este trastorno; la escala de Deterioro neurológico también establece diferencias notables (d de Cohen=1,2) entre los casos clínicos y los simuladores de esta categoría diagnóstica y de simulación, al igual que obtienen puntuaciones medias marcadamente diferentes los casos clínicos y los simuladores de problemas emocionales en la escala Trastornos afectivos (d de Cohen=1,3). Estas diferencias también se observan en la puntuación total que sigue siendo un excelente marcador para diferenciar casos clínicos y simuladores en las distintas categorías consideradas (d de Cohen de 2,4; 1,6 y 1,0 respectivamente). En las figuras 4-7 a 4-9 aparecen ilustradas gráficamente estas diferencias. Es interesante mencionar también como el grupo de simulación de enajenación mental por psicosis también establece diferencias con el grupo clínico en la escala Trastornos amnésicos, ya que se les pide que digan «que no eran ellos, que estaban como idos». Igualmente en el grupo de simulación de consecuencias de un accidente también hay diferencias marcadas en Trastornos afectivos que es uno de los problemas que se inducen a simular.

4. Comparamos a los casos clínicos psicóticos con los sujetos a los que se les pidió que simularan enajenación mental por psicosis; a los casos clínicos de deterioro neurológico con aquellos a los que se les pidió que simularan trastornos posteriores a un accidente; a los casos clínicos de trastornos afectivos con aquellos a los que se les pidió que simularan problemas afectivos.

Tabla 4.38. Puntuaciones medias y desviaciones típicas en las escalas del SIMS de los grupos clínicos y de simuladores por categoría diagnóstica. Estudios de la adaptación española

Escalas del SIMS	Categoría																	
	Psicosis					Deterioro neurológico					Trastornos afectivos							
	Clínicos ^a		Simulación ^b		Tamaño del efecto	Clínicos ^a		Simulación ^b		Tamaño del efecto	Clínicos ^a		Simulación ^b		Tamaño del efecto			
M	Dt	M	Dt	d	Cat.	M	Dt	M	Dt	d	Cat.	M	Dt	M	Dt	d	Cat.	
Total	16,9	9,6	40,7	10,2	2,4	Muy grande	16,6	8,4	32,9	12,1	1,6	Muy grande	20,5	10,2	30,8	9,6	1,0	Moderado
Psicosis	2,3	2,3	9,3	3,6	2,3	Muy grande	1,0	1,8	5,0	4,3	1,2	Grande	1,9	2,2	3,7	3,3	0,6	—
Deterioro neurológico	3,7	3,1	7,6	2,8	1,3	Grande	3,8	2,6	7,5	3,3	1,2	Grande	4,6	3,3	7,3	3,2	0,8	Moderado
Trastornos amnésicos	2,8	2,5	10,0	4,0	2,2	Muy grande	3,9	3,4	6,6	4,0	0,7	—	3,9	3,5	6,2	3,6	0,6	—
Baja inteligencia	2,7	1,8	4,6	2,8	0,8	Moderado	2,1	1,3	4,4	2,8	1,1	Moderado	2,8	1,5	3,3	1,8	0,3	—
Trastornos afectivos	5,4	2,4	9,2	2,1	1,7	Muy grande	5,8	2,1	9,5	2,3	1,6	Muy grande	7,3	2,7	10,4	1,8	1,3	Grande

Nota. n^a= 45; n^b= 64; n^c= 33; n^d= 120; n^e= 67; n^f= 53. Aparece destacada en negrita la puntuación media de cada grupo en su escala específica (p. ej., del grupo de simulación de psicosis en la escala Psicosis del SIMS).



Figura 4.7. Puntuaciones medias en las escalas del SIMS en el grupo clínico de psicosis y en el grupo de simuladores de enajenación mental por psicosis. Datos de la adaptación española

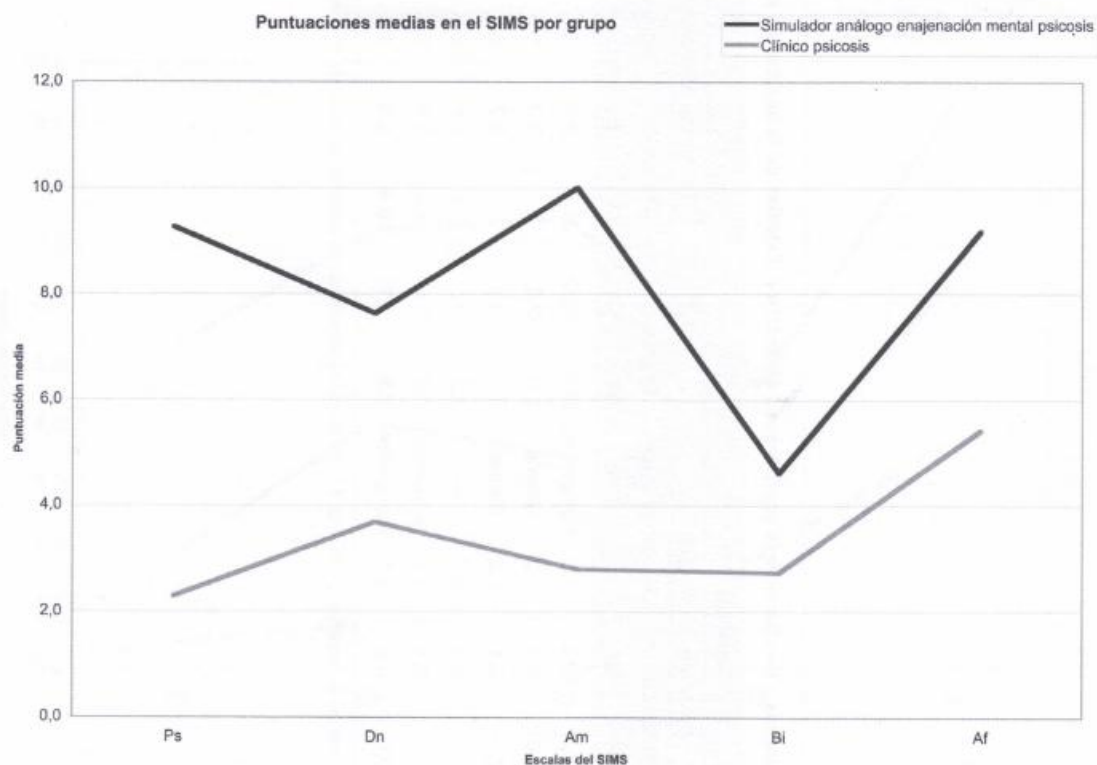


Figura 4.8. Puntuaciones medias en las escalas del SIMS en el grupo clínico de deterioro neurológico y en el grupo de simuladores de accidente. Datos de la adaptación española

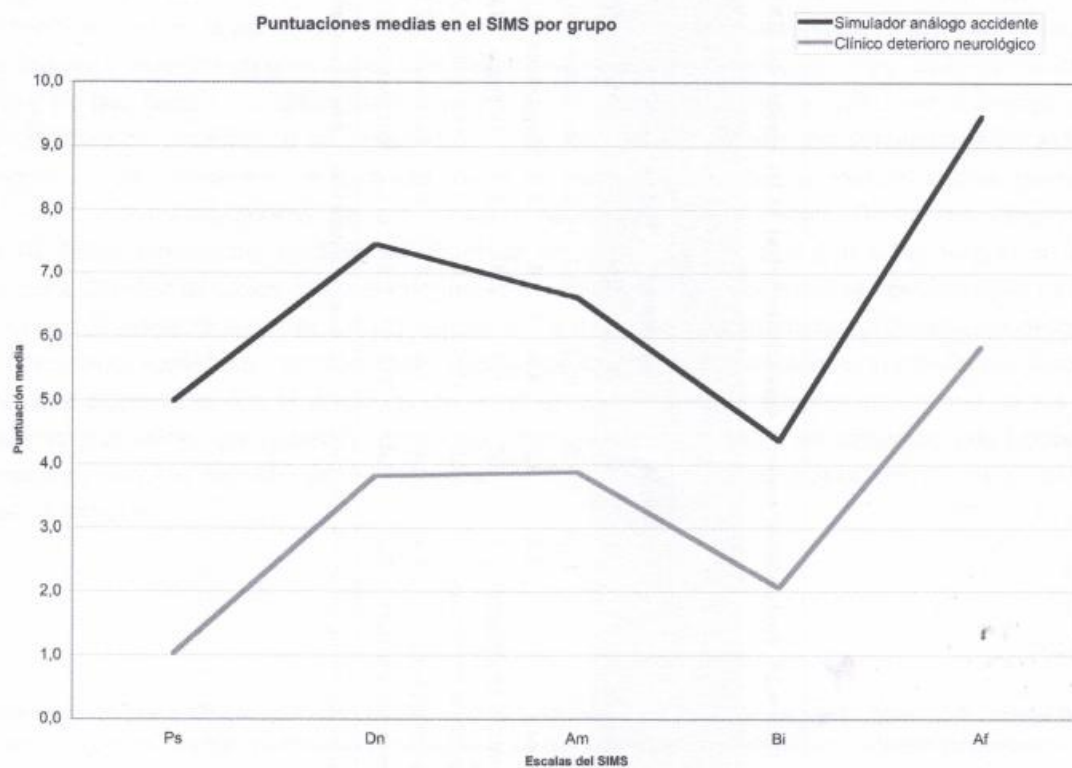
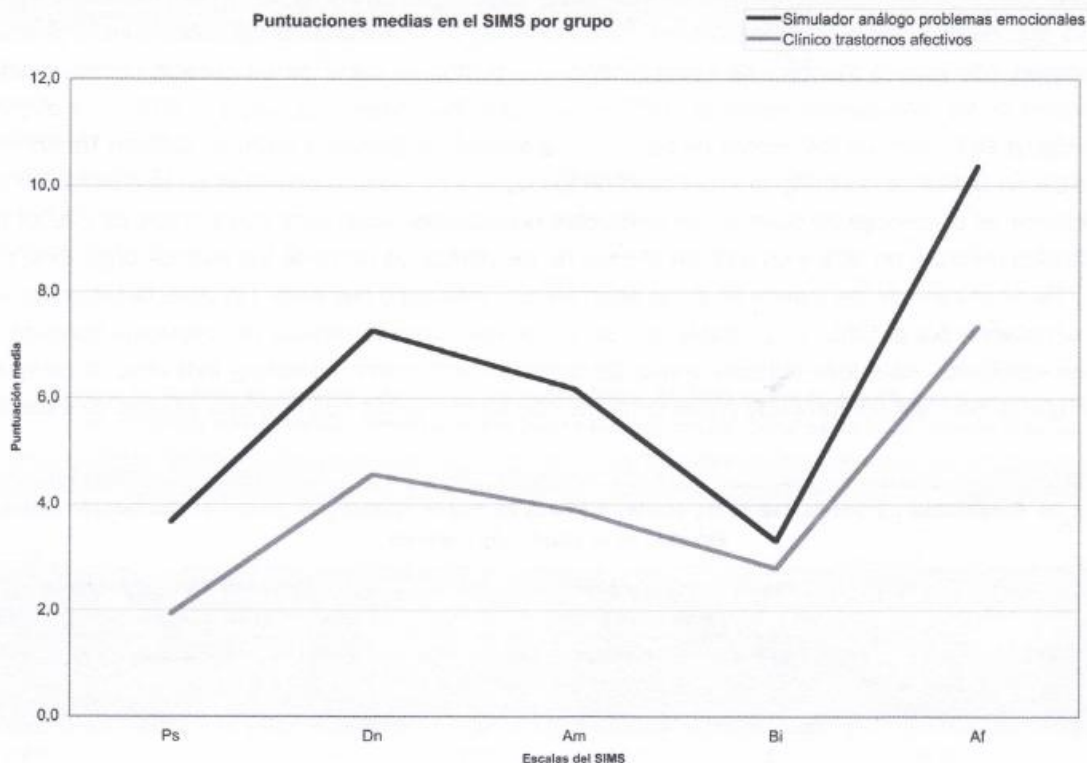




Figura 4.9. Puntuaciones medias en las escalas del SIMS en el grupo clínico de trastornos afectivos y en el grupo de simuladores de problemas emocionales. Datos de la adaptación española



Se estudió también la sensibilidad y especificidad para clasificar a los sujetos como casos clínicos o simuladores a partir de la puntuación total del SIMS. Los resultados aparecen en la tabla 4.39. Los datos que se muestran confirman la utilidad del SIMS como herramienta de *screening* que detecta al 96% de los simuladores (punto de corte > 14) o al 92% (punto de corte > 16) con menores porcentajes de especificidad (40%; punto de corte > 14 o 48% punto de corte > 16). Estos resultados concuerdan con valores predictivos positivos de 0,96 y 0,93 respectivamente y valores predictivos negativos de 0,41 y 0,43, indicando que aquellos casos detectados como con sospecha de simulación por el SIMS deberán ser confirmados posteriormente con otra prueba con mayores valores de especificidad y de valor predictivo positivo.

Tabla 4.39. Precisión predictiva de la puntuación total del SIMS con respecto al grupo clínico y al grupo de simuladores análogos. Estudios de la adaptación española

Total SIMS	Punto de corte >14	Punto de corte >16
Área bajo la curva	0,84	
Sensibilidad	0,96	0,92
Especificidad	0,40	0,48
Valor predictivo positivo	0,41	0,43
Valor predictivo negativo	0,96	0,93

Nota. N=473 ($n_{\text{clínico}} = 152$; $n_{\text{simuladores}} = 326$). Se ha calculado el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo considerando una tasa de prevalencia de la simulación del 30% (Mittenberg, Patton, canyock y Condit, 2002).



Cuando se estudió la sensibilidad y especificidad de cada escala al discriminar casos clínicos y simuladores, ambos específicos de esa escala, se obtuvieron los resultados que aparecen en la tabla 4.40. Solo aparecen valores para las escalas Psicosis, Deterioro neurológico y Trastornos afectivos ya que fueron los únicos en que se dispuso de una muestra clínica específica con un número suficiente de casos como para estudiar estos aspectos. Al igual que ocurría con la puntuación total, se confirma la alta sensibilidad del SIMS para la detección de los simuladores, con valores menores de especificidad. Los puntos de corte de las escalas permiten detectar a la gran mayoría de los simuladores (entre el 100% en la escala Trastornos afectivos y el 93% en la escala Deterioro neurológico en el caso de los puntos de corte de los autores originales; y entre un 94% en Trastornos afectivos y el 88% en Deterioro neurológico en el caso de los puntos de corte propuestos en la adaptación española). No obstante, el porcentaje de sujetos con respuesta honesta correctamente clasificados es inferior (índices de especificidad de entre un 30% y un 51% en el caso de los puntos de corte de los autores originales; entre un 49% y un 71% en el caso de los puntos de corte alternativos), indicando que entre los detectados como con sospecha de simulación por el SIMS es probable que se encuentren sujetos clínicos de respuesta honesta. El conjunto de los resultados de nuevo reiteran el uso de la herramienta como *screening* indicativo de sospecha de simulación que deberá ser comprobado posteriormente con herramientas con mayores valores de especificidad.

Tabla 4.40. Sensibilidad y especificidad de las escalas del SIMS en grupos clínicos y en grupos de simuladores análogos. Estudios de la adaptación española

Escala del SIMS	Área bajo la curva	Puntos de corte propuestos por los autores originales			Puntos de corte alternativos propuestos en la adaptación española		
		Punto de corte	Sensibilidad	Especificidad de corte	Punto	Sensibilidad	Especificidad
Psicosis ^a	0,98	> 1	0,94	0,51	> 2	0,92	0,71
Deterioro neurológico ^b	0,97	> 2	0,93	0,30	> 3	0,88	0,52
Trastornos afectivos ^c	0,99	> 5	1,00	0,31	> 7	0,94	0,49

Nota. ^a n_{clínico} = 45; n_{simuladores} = 64; ^b n_{clínico} = 33; n_{simuladores} = 120; ^c n_{clínico} = 67; n_{simuladores} = 53.

ESTUDIO DE GRUPOS DIAGNÓSTICOS EN CONTEXTOS MÉDICO-LEGALES CLASIFICADOS POR CRITERIOS EXTERNOS E INDEPENDIENTES DE FERNÁNDEZ MARÍN, GONZÁLEZ ORDI Y SANTAMARÍA FERNÁNDEZ (2008)

Tal y como se comentó en el apartado 4.1, en la adaptación española del SIMS se pudo contar con la colaboración de distintas organizaciones y profesionales que trabajaban en contextos médico-legales (aseguradoras, mutuas, consultas periciales forenses...) que debían determinar en su labor profesional si una persona estaba simulando su sintomatología o por el contrario era un caso clínico con una patología «real».

A estos profesionales se les pidió que aplicaran el SIMS a sujetos previamente clasificados como simuladores o casos clínicos. Esta clasificación se realizó siguiendo criterios de sospecha clínica de presencia o no de posible simulación (véase Samuel y Mittenberg, 2006). El objetivo de este estudio era comprobar la capacidad discriminativa de la adaptación española del SIMS en contextos reales de evaluación y comparar sus resultados con criterios externos de expertos independientes. En el apartado 4.1.2 se describen las características sociodemográficas de las muestras utilizadas en estos estudios.

Tal y como puede advertirse en la tabla 4.41 aparecieron notables diferencias entre las puntuaciones obtenidas por los grupos clasificados por jueces independientes como clínicos o simuladores, con un tamaño del efecto grande. Los resultados indican que los simuladores obtienen puntuaciones notablemente más altas que los sujetos clínicos, tanto en la puntuación total del SIMS como en las puntuaciones de las escalas. Además estas diferencias fueron significativas (tabla 4.42). La puntuación total media del SIMS del grupo simulador se encontró en el percentil 93 del grupo clínico. En las figuras 4.10 y 4.11 se muestran gráficamente estas diferencias.



Tabla 4.41. Puntuaciones medias en las escalas del SIMS del grupo clínico y del grupo de simuladores en contextos reales médico-legales clasificados por jueces independientes. Estudios de la adaptación española

Escalas del SIMS	Grupo clínico ^a		Grupo simulador ^b		Tamaño del efecto de las diferencias	
	M	Dt	M	Dt	<i>d</i>	Categoría
Total	11,7	4,6	23,2	8,9	1,6	Muy grande
Psicosis	0,4	0,6	2,2	2,3	1,1	Moderado
Deterioro neurológico	2,8	2,6	5,6	3,6	0,9	Moderado
Trastornos amnésicos	1,2	1,4	4,4	2,9	1,4	Grande
Baja inteligencia	1,8	1,3	2,9	1,8	0,7	Moderado
Trastornos afectivos	5,5	1,9	8,2	2,5	1,2	Moderado

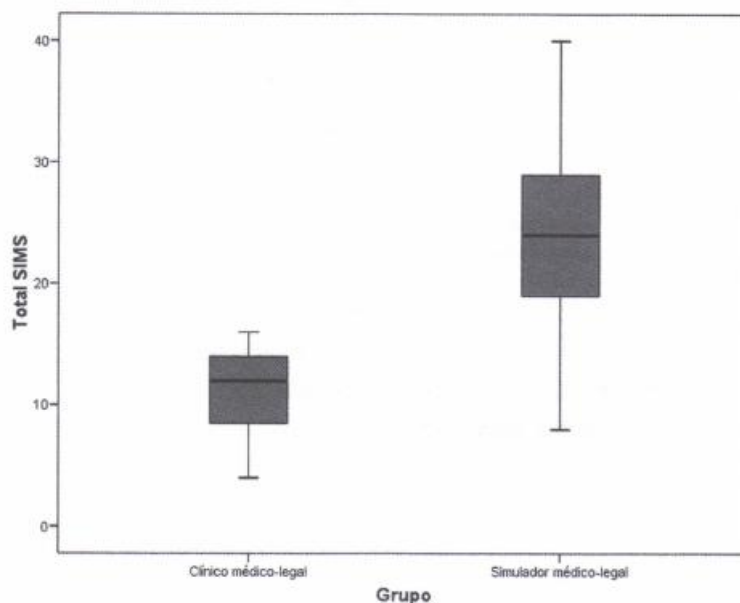
Nota. n^a= 27; n^b= 34.

Tabla 4.42. Análisis de varianza (ANOVA) de las puntuaciones del SIMS en los grupos clínicos y de simuladores en contextos médico-legales clasificados por jueces independientes. Estudios de la adaptación española

Escalas del SIMS	<i>F</i>	<i>g.l.</i>	<i>p</i>	<i>R</i> ²
Total	37,0	1	> 0,001	0,39
Psicosis	15,5	1	> 0,001	0,21
Deterioro neurológico	11,5	1	0,001	0,16
Trastornos amnésicos	27,5	1	> 0,001	0,32
Baja inteligencia	6,9	1	0,011	0,10
Trastornos afectivos	21,21	1	> 0,001	0,26

Nota. N= 61.

Figura 4.10. Diagrama de caja y bigotes⁵ de la puntuación total en el SIMS en los grupos clínico y simuladores procedentes de contextos médico legales y clasificados por jueces independientes. Datos de la adaptación española

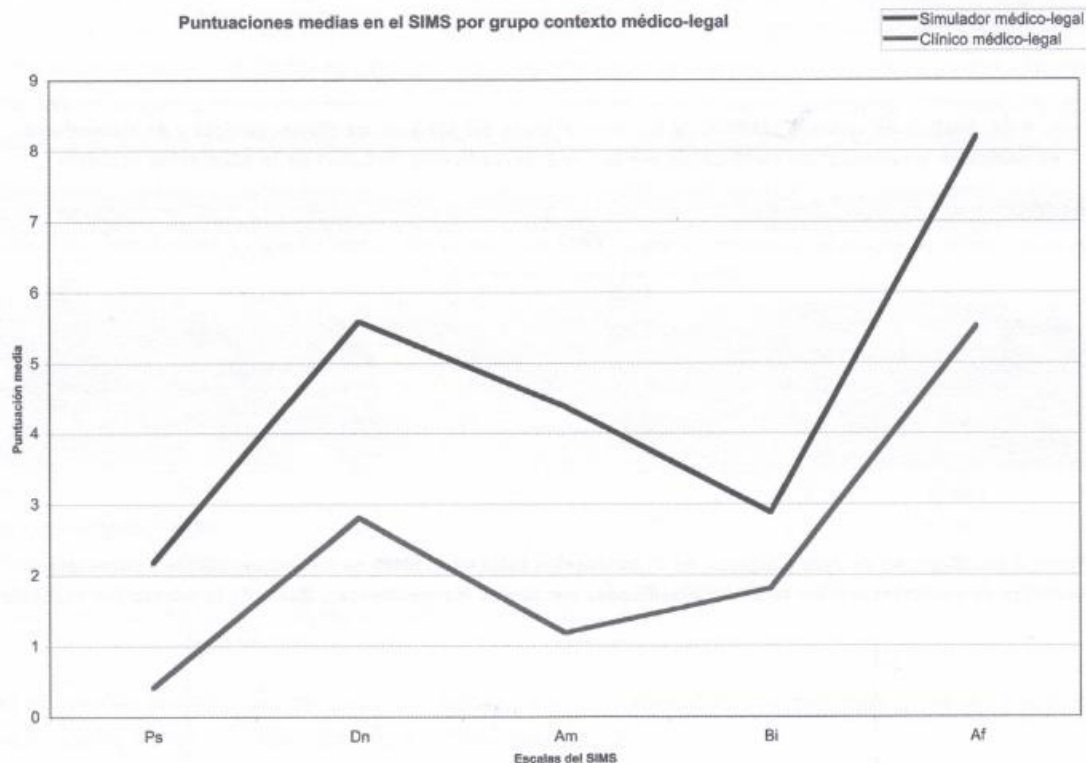


5. Los diagramas de caja y bigotes son gráficos que representan la distribución de una puntuación en cada uno de los grupos. La caja central indica el rango en el que se concentra el 50% central de los datos. Sus extremos son, por lo tanto, el 1º y 3º cuartil de la distribución (percentil 25 y 75). La línea central en la caja es la mediana. Los extremos de los «bigotes» que salen de la caja son los valores que delimitan el 95% central de los datos. De este modo representa en qué rango de puntuaciones se sitúan la mayoría de los sujetos en cada uno de los grupos.



En la figura 4.11 se observa cómo los perfiles de los sujetos clínicos y de los simuladores son prácticamente paralelos, ya que en principio ambos grupos presentaban una patología similar; sin embargo, los simuladores autoinforman consistentemente un mayor nivel de deterioro frente a los clínicos. Los simuladores presentan un mayor nivel de afectación ansioso-depresiva (escala Af, $d=1,2$), un mayor nivel de dolor, disfunciones somáticas y discapacidad (escala Dn, $d=0,9$), un mayor nivel de distorsiones cognitivas (escala Ps, $d=1,1$) y, sobretodo, un mayor nivel de problemas de memoria y confusión mental (escala Am, $d=1,4$).

Figura 4.11. Puntuaciones medias en las escalas del SIMS en el grupo clínico y en el grupo de simuladores en contexto médico-legales. Datos de la adaptación española



También se obtuvieron los valores de sensibilidad y especificidad para examinar la utilidad del SIMS como herramienta predictiva a la hora de discriminar entre los participantes del grupo «clínico» y los del grupo «simulador» clasificados por jueces independientes. También se calcularon los valores predictivos positivos y negativos utilizando como tasa de prevalencia la informada por Mittenberg, Patton, Canyock y Condit (2002), el 30%, en el caso de evaluaciones para discapacidad. Como puede advertirse en la tabla 4.43 se obtienen valores muy satisfactorios. Si se aplica el punto de corte propuesto por los autores originales ($Total > 14$) el 94% de los casos con puntuaciones inferiores al punto de corte serían realmente del grupo de respuesta honesta (valor predictivo negativo), y por lo tanto estarían correctamente clasificados. De los sujetos que obtuvieran puntuaciones por encima de ese punto de corte, un 66% serían simuladores, de acuerdo al criterio de jueces independientes (valor predictivo positivo). Si se aplica el punto de corte propuesto en la adaptación española ($Total > 16$), el 92% de los casos que cayeran por debajo de este punto de corte serían de respuesta honesta, mientras que el 83% de los que lo superaran serían realmente simuladores.



Tabla 4.43. Precisión predictiva de la puntuación total del SIMS en el grupo clínico y en el grupo simuladores en contextos médico-legales y clasificados por jueces independientes. Estudios de la adaptación española

Total SIMS	Punto de corte >14	Punto de corte >16
Área bajo la curva	0,88	
Sensibilidad	0,88	0,82
Especificidad	0,81	0,93
Valor predictivo positivo	0,66	0,83
Valor predictivo negativo	0,94	0,92

Nota. N=61 ($n_{\text{clínico}} = 27$; $n_{\text{simuladores}} = 34$). Se ha calculado el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo considerando una tasa de prevalencia de la simulación del 30% (Mittenberg, Patton, Canaryock y Condit, 2002).

El conjunto de estos resultados aportan un importante respaldo a la bondad discriminatoria de la adaptación española del SIMS para diferenciar entre sujetos clasificados por jueces independientes como casos clínicos genuinos o como simuladores y que han sido evaluados en contextos médico-legales reales.

ESTUDIO DEL PATRÓN DE EXAGERACIÓN DE SÍNTOMAS EN CONTEXTOS MÉDICO-LEGALES DE GONZÁLEZ ORDI, SANTAMARÍA FERNÁNDEZ, BLASCO Y GALLARDÓ (2008)

Tal y como se describió en el apartado 4.1.1, se contó también con una muestra de 305 sujetos procedentes de contextos médico-legales a los que se les había aplicado el MMPI-2 y el SIMS. Estos casos fueron clasificados en dos grupos en función de si presentaban o no un patrón de exageración de síntomas. Como ya se comentó anteriormente, esta clasificación fue realizada a partir de sus resultados en el MMPI-2, considerando casos con exageración de síntomas aquellos cuya puntuación directa en F-K era mayor o igual a 5 y cuya puntuación típica T en F era mayor de 70. 32 casos fueron clasificados con exageración de síntomas y 273 sin ese patrón.

En la tabla 4.44 aparecen las puntuaciones en el SIMS de ambos grupos. Tal y como puede observarse, la puntuación total marca diferencias muy notables entre ambos grupos al igual que las escalas Deterioro neurológico y Trastornos amnésicos. En las figura 4.12 y 4.13 aparecen representadas dichas diferencias.

Tabla 4.44. Puntuaciones medias en las escalas del SIMS de los grupos con y sin patrón de exageración de síntomas según el MMPI-2. Estudios de la adaptación española

Escalas del SIMS	Grupo sin exageración de síntomas ^a		Grupo con exageración de síntomas ^b		Tamaño del efecto de las diferencias	
	M	Dt	M	Dt	d	Categoría
Total	13,5	6,8	29,6	8,7	2,1	Muy grande
Psicosis	0,6	1,0	3,5	3,1	1,2	Moderado
Deterioro neurológico	2,7	2,7	8,2	2,8	2,0	Muy grande
Trastornos amnésicos	1,6	2,2	5,8	3,3	1,5	Muy grande
Baja inteligencia	2,2	1,4	3,3	1,7	0,6	—
Trastornos afectivos	6,4	2,6	8,8	1,8	1,1	Moderado

Nota. n^a= 273; n^b= 32.



Figura 4.12. Diagrama de caja y bigotes^a de la puntuación total en el SIMS en los grupos clasificados según su nivel de exageración de síntomas determinados por el MMPI-2. Datos de la adaptación española

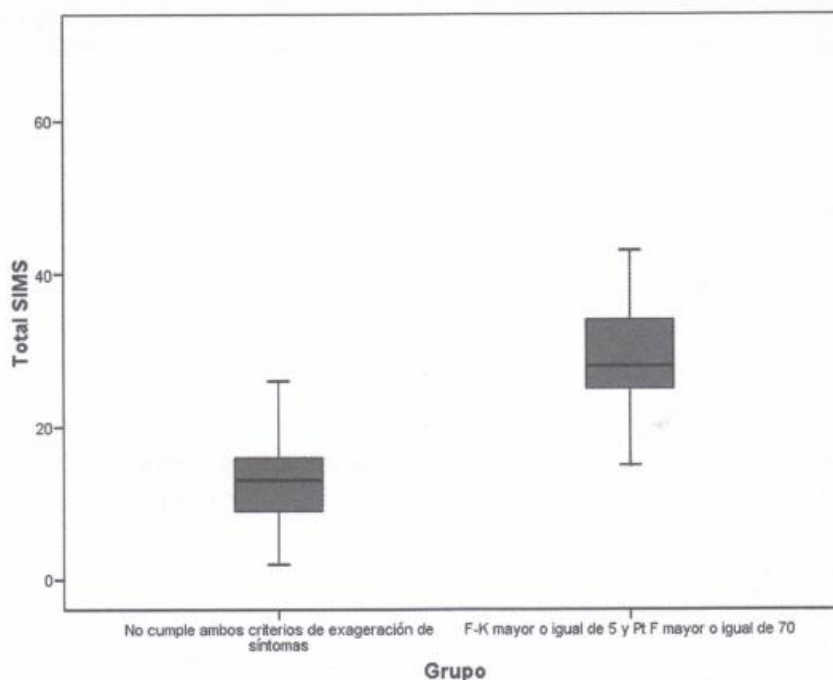
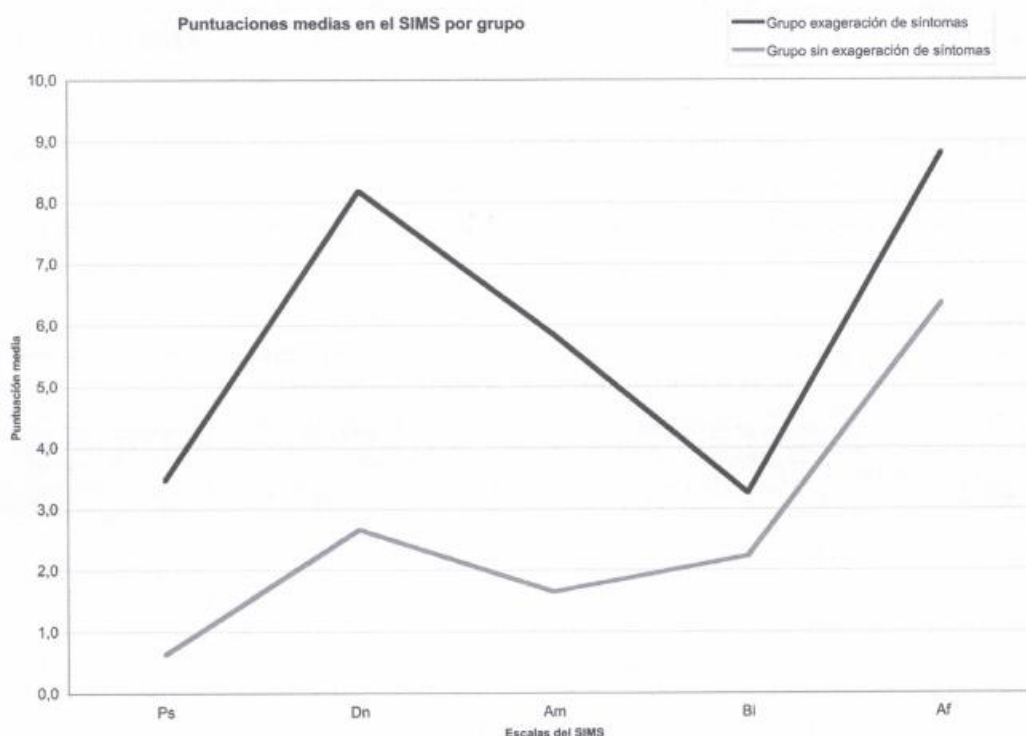


Figura 4.13. Puntuaciones medias en las escalas del SIMS en los grupos de exageración de síntomas determinados por el MMPI-2. Datos de la adaptación española



6. Los diagramas de caja y bigotes son gráficos que representan la distribución de una puntuación en cada uno de los grupos. La caja central indica el rango en el que se concentra el 50% central de los datos. Sus extremos son, por lo tanto, el 1º y 3º cuartil de la distribución (percentil 25 y 75). La línea central en la caja es la mediana. Los extremos de los «bigotes» que salen de la caja son los valores que delimitan el 95% central de los datos. De este modo representa en qué rango de puntuaciones se sitúan la mayoría de los sujetos en cada uno de los grupos.



También se estudió la capacidad clasificatoria de la prueba en estos grupos mediante el análisis de las curvas COR. Los resultados de estos análisis se muestran en la figura 4.14 y en la tabla 4.45. Como se puede observar en la figura 4.14 la curva COR de la puntuación total del SIMS se aleja notablemente de la diagonal y permite obtener valores satisfactorios de sensibilidad y especificidad (tabla 4.45), clasificando correctamente al 100% (punto de corte de 14) o al 97% (punto de corte de 16) de los simuladores y al 61% o al 75% de los sujetos sin exageración de síntomas (puntos de corte de 14 y 16 respectivamente).

Figura 014. Curva característica del receptor (COR) de la puntuación total del SIMS en la clasificación de los grupos de exageración de síntomas determinados por el MMPI-2. Datos de la adaptación española

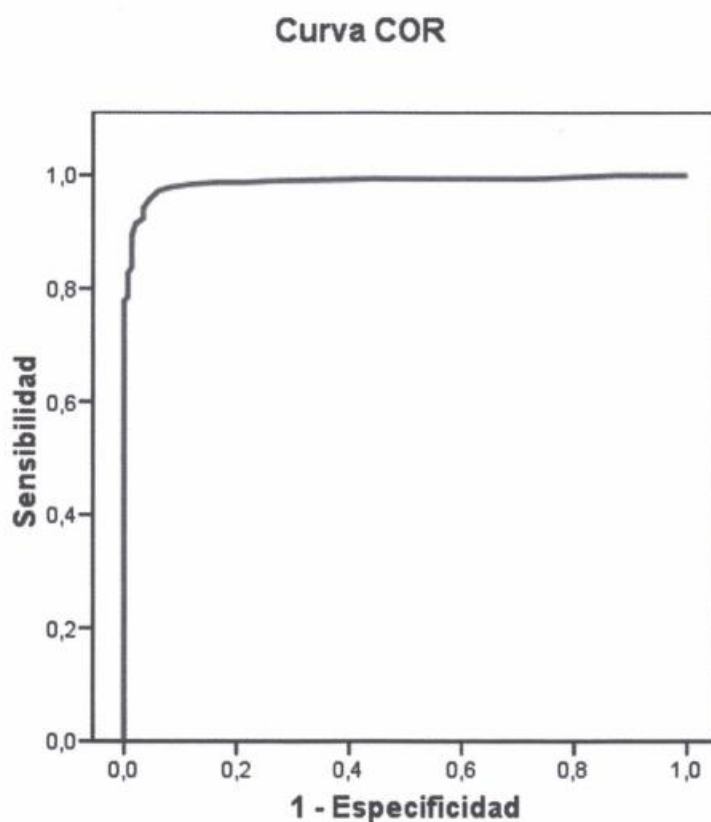


Tabla 4.45. Precisión predictiva de la puntuación total del SIMS en los grupos de exageración de síntomas determinados por el MMPI-2. Estudios de la adaptación española

Total SIMS	Punto de corte >14	Punto de corte >16
Área bajo la curva	0,94	
Sensibilidad	1,00	0,97
Especificidad	0,61	0,75
Valor predictivo positivo	0,52	0,62
Valor predictivo negativo	1,00	0,98

Nota. N=305 (n_{sin exageración} = 273; n_{con exageración} = 32). Se ha calculado el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo considerando una tasa de prevalencia de la simulación del 30% (Mittlenberg, Patton, Canyock y Condit, 2002).



ESTUDIO DE GRUPOS DIAGNÓSTICOS EN CONTEXTOS MÉDICO-LEGALES DE DOLOR CRÓNICO DE CAPILLA RAMÍREZ, GONZÁLEZ ORDI Y SANTAMARÍA FERNÁNDEZ (2008)

Unos de los campos más relevantes para el estudio de la simulación es el dolor crónico. Algunos estudios sugieren que la incidencia de la simulación de dolor es significativamente alta, estimándose los rangos de prevalencia entre un 25% y un 30% tanto para la fibromialgia (Gervais, Russell y Green, 2001) como para el dolor crónico en general (Gervais, Green, Allen *et al*, 2001). Mittenberg *et al* (2002) señalan que entre las patologías dolorosas más susceptibles de simulación se encuentran la fibromialgia y el dolor de carácter generalizado; Hamilton y Feldman (2001) incluyen la cervicalgia y el esguince. En el estudio realizado por Capilla Ramírez, González Ordi y Santamaría Fernández (2008) se analizó precisamente la capacidad del SIMS para la detección de la simulación de sintomatología física y psicopatológica asociada a patología dolorosa crónica.

Para ello se contó con una muestra compuesta de 55 pacientes con dolor crónico, atendidos en el centro sanitario Fremap Madrid II (ITCC), clasificados en dos grupos (dolor de espalda litigante, fibromialgia litigante) y 30 voluntarios con dolor crónico de espalda no litigante del Programa de educación postural de la Universidad Francisco de Vitoria. Se consideró como grupo control el ya descrito previamente en el apartado 4.1.1 compuesto por 147 sujetos «normales» (sin ningún trastorno psicológico o físico diagnosticado) a los que se asignó a esta condición y se les pidió que respondieran sincera y honestamente a la prueba.

En la tabla 4.46 aparecen las medias y desviaciones típicas de cada uno de estos grupos en el total del SIMS y en cada una de sus escalas. Se puede observar cómo el grupo de dolor crónico no litigante tiene puntuaciones similares al grupo control en la puntuación total (figura 4.15) y en prácticamente todas las escalas (figura 4.16), indicando que aquellos pacientes con dolor crónico pero que no están en litigios tienen un perfil de puntuaciones similares al grupo normal.

Sin embargo, el grupo de dolor crónico litigante sí obtiene puntuaciones más elevadas en el SIMS, tanto con respecto al grupo control como con respecto al grupo de dolor crónico no litigante. Estas diferencias aparecen tanto en la puntuación total de la prueba (figura 4.15; d de Cohen= 1,3) como particularmente en las puntuaciones de las escalas Deterioro neurológico (d de Cohen= 1,3) y Trastornos afectivos (d de Cohen= 1,2), tal y como se observa en la figura 4.16. Además se llevó a cabo un ANOVA entre ambos grupos para detectar si las diferencias encontradas eran significativas (tabla 4.47) obteniendo como resultado que dichas diferencias eran significativas en estas tres escalas (Total, Deterioro neurológico y Trastornos afectivos), en las que el grupo de pacientes con dolor crónico litigante alcanzaba puntuaciones medias más altas que las del grupo de no litigantes.

Tabla 4.46. Puntuaciones medias en las escalas del SIMS del grupo control y de los grupos de dolor crónico y fibromialgia en contextos médico-legales. Estudios de la adaptación española

Escalas del SIMS	Grupo control ^a		Grupo dolor crónico no litigante ^b		Grupo dolor crónico litigante ^c		Grupo fibromialgia litigante ^d		Tamaño del efecto Dolor crónico litigante frente a no litigante	
	M	Dt	M	Dt	M	Dt	M	Dt	d	Categoría
Total	7,6	3,6	6,9	2,8	14,1	7,0	25,5	10,2	1,3	Grande
Psicosis	0,4	0,7	0,2	0,4	0,6	0,8	2,1	3,0	0,6	—
Deterioro neurológico	0,8	1,2	0,8	1,2	3,9	3,2	8,3	3,5	1,3	Grande
Trastornos amnésicos	0,8	1,2	0,1	0,4	1,2	2,2	4,0	3,6	0,7	—
Baja inteligencia	1,8	1,4	2,1	1,5	2,5	1,3	2,6	1,4	0,3	—
Trastornos afectivos	3,8	1,7	3,7	1,4	6,0	2,4	8,5	1,7	1,2	Moderado

Nota. n^a= 147; n^b= 25; n^c= 30; n^d= 30.

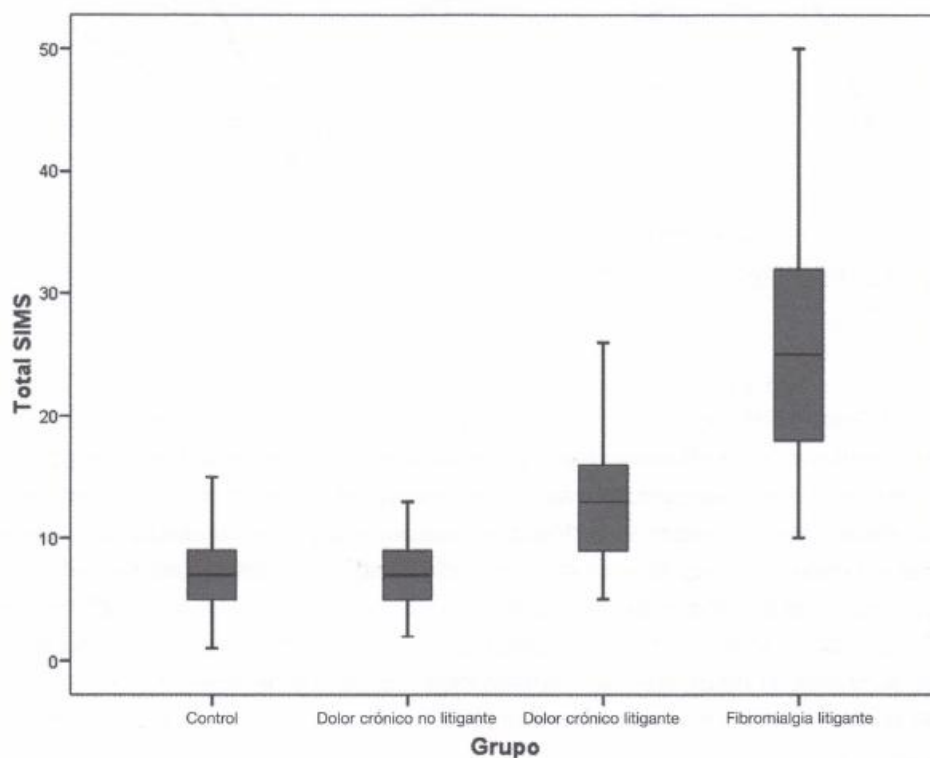


Tabla 4.47. Análisis de varianza (ANOVA) de las puntuaciones del SIMS en los grupos de dolor crónico no litigante y de dolor crónico litigante. Estudios de la adaptación española

Escalas del SIMS	<i>F</i>	<i>g.l.</i>	<i>p</i>	<i>R</i> ²
Total	26,3	1	<0,001	0,33
Psicosis	2,2	1	0,022	0,10
Deterioro neurológico	24,0	1	<0,001	0,31
Trastornos amnésicos	6,5	1	0,014	0,11
Baja inteligencia	2,0	1	0,328	0,02
Trastornos afectivos	19,2	1	<0,001	0,27

Nota. N= 55.

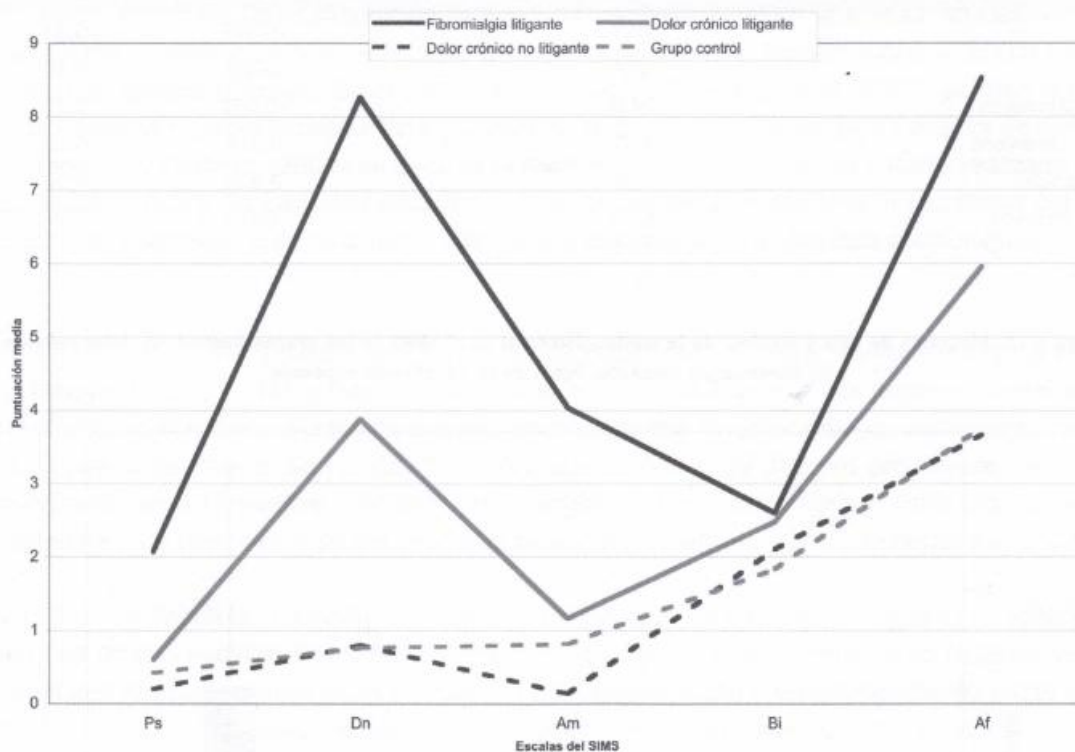
Figura 4.15. Diagrama de caja y bigotes⁷ de la puntuación total en el SIMS en los grupos control, de dolor crónico y de fibromialgia litigante. Datos de la adaptación española



7. Los diagramas de caja y bigotes son gráficos que representan la distribución de una puntuación en cada uno de los grupos. La caja central indica el rango en el que se concentra el 50% central de los datos. Sus extremos son, por lo tanto, el 1º y 3º cuartil de la distribución (percentil 25 y 75). La línea central en la caja es la mediana. Los extremos de los «bigotes» que salen de la caja son los valores que delimitan el 95% central de los datos. De este modo representa en qué rango de puntuaciones se sitúan la mayoría de los sujetos en cada uno de los grupos.



Figura 4.16. Puntuaciones medias en las escalas del SIMS en los grupos control, de dolor crónico y de fibromialgia litigante. Datos de la adaptación española



Los resultados obtenidos concuerdan con las expectativas de los investigadores que consideraban que la puntuación total del SIMS podía ser sensible en cierta medida a la simulación en los contextos de dolor crónico y que serían las escalas Deterioro neurológico y Trastornos afectivos aquellas que, después de la puntuación total, más claramente establecieran las diferencias entre los sujetos simuladores y los que respondían de forma honesta. En el estudio de simuladores análogos realizado en la adaptación española ya se mostró un patrón similar en el grupo de simuladores análogos de patología dolorosa. Aquellos a los que se les pedía simular la presencia de dolores intensos en distintas partes del cuerpo que limitaban y dificultaban su vida obtenían puntuaciones notablemente más altas tanto en el total de la prueba como en las escalas Deterioro neurológico y Trastornos afectivos.

Es necesario advertir, no obstante, que las puntuaciones medias en el total del SIMS del dolor litigante se sitúan sensiblemente por debajo de los puntos de corte clásicamente valorados (14 ó 16) (tabla 4.46 y figura 4.15). En estos casos los puntos de corte que mejor permitieron discriminar entre los grupos de dolor crónico litigante y no litigante fueron las puntuaciones totales del SIMS superiores a 6 puntos. Con este punto de corte (total >6) se obtenía una sensibilidad de 0,88 y una especificidad de 0,47, esto es, se detectaba al 88% de los miembros del grupo de dolor litigante y al 47% del grupo de dolor no litigante. En el caso de la escala Deterioro neurológico el punto de corte propuesto sería superior a 1 ($Dn > 1$) punto, lo que permitiría una sensibilidad de 0,72 y una especificidad de 0,87 (se detecta al 92% de los miembros de dolor litigante y al 50% del grupo de dolor no litigante; un punto de corte superior a 0 obtendría una sensibilidad de 0,92 y una especificidad de 0,50); en el caso de la escala Trastornos afectivos se obtuvo como punto de corte óptimo en estos grupos una puntuación superior a 3 ($Af > 3$) que ofrecería una sensibilidad de 0,84 y una especificidad de 0,47. Este conjunto de resultados sugiere que en la evaluación de la simulación de dolores crónicos (sin la presencia de sintomatología psicopatológica) con el SIMS deberían considerarse puntos de corte



inferiores a los tradicionalmente tenidos en cuenta. No obstante, los resultados de estos estudios son todavía preliminares y deberán confirmarse con los obtenidos en otras muestras independientes y más amplias.

Como previamente se ha podido observar, el grupo de fibromialgia litigante obtiene puntuaciones notablemente más altas que el resto de los grupos considerados (control, dolor crónico no litigante, dolor crónico litigante). Cabría plantearse qué ocurriría si se comparara a este grupo con el grupo clínico ya comentado previamente en los estudios de la adaptación española y con el grupo de simuladores análogos de patología dolorosa (también previamente descrito y estudiado en la adaptación española). Esta comparación podría indicarnos si las puntuaciones del SIMS permiten diferenciar entre los sujetos del grupo clínico, del grupo de fibromialgia litigante y del grupo de simuladores análogos de patología dolorosa. En la tabla 4.48 se muestran las medias y desviaciones típicas de cada uno de estos grupos y el tamaño del efecto de las diferencias entre el grupo clínico general y el grupo de fibromialgia litigante.

Los resultados de la tabla 4.48 y la figura 4.17 nos indican que existen diferencias en las puntuaciones totales del SIMS entre los distintos grupos considerados. Como cabría esperar hay un aumento gradual de las puntuaciones conforme pasamos del grupo control, al grupo clínico, al grupo de simulación análogo y al grupo de fibromialgia litigante, siendo este último el grupo que obtiene una puntuación más alta. De hecho los miembros del grupo de fibromialgia litigante obtienen puntuaciones en el total del SIMS moderadamente superiores al grupo clínico (d de Cohen=0,7), indicando con esto que la puntuación total del SIMS establece diferencias moderadas entre los sujetos clínicos y los que están en procesos litigantes en relación con su posible fibromialgia. En estos casos, el punto de corte de 16 (Total>16) ofrecía una sensibilidad de 0,80 y una especificidad de 0,48, esto es, detectaba al 80% de los miembros del grupo de fibromialgia litigante y al 48% del grupo clínico.

Cuando se analiza el perfil de cada una de las escalas del SIMS (tabla 4.48 y figura 4.18) se advierte que las diferencias entre los grupos clínicos y de simuladores (simulador análogo y fibromialgia litigante) se observan sobre todo en las escalas Deterioro neurológico (d de Cohen=1,3) y Trastornos afectivos (d de Cohen=1,0), en las que ambos grupos de simuladores obtienen puntuaciones más altas que el grupo control y que el grupo clínico. En el caso de la escala Deterioro neurológico, utilizando un punto de corte de 3 ($D_n > 3$) para discriminar entre los sujetos del grupo de fibromialgia litigante y el grupo de sujetos clínicos se obtuvo una sensibilidad de 0,90 y una especificidad de 0,47; en el caso de la escala Trastornos afectivos, utilizando el punto de corte de 7 ($A_f > 7$) se obtuvo una sensibilidad de 0,77 y una especificidad de 0,66, mientras que utilizando el punto de corte propuesto originalmente por los autores ($A_f > 5$) se obtenía una sensibilidad de 0,97 y una especificidad de 0,39. El conjunto de estos datos parece aportar una cierta evidencia sobre la capacidad del SIMS para detectar patrones de simulación en este tipo de población, siendo especialmente sensibles las escalas Deterioro neurológico y Trastornos afectivos. Además, estos datos sugieren que, cuando se trabaje en el campo de la simulación con este tipo de pacientes, las puntuaciones de estas escalas deberían tenerse en cuenta junto con la puntuación total.

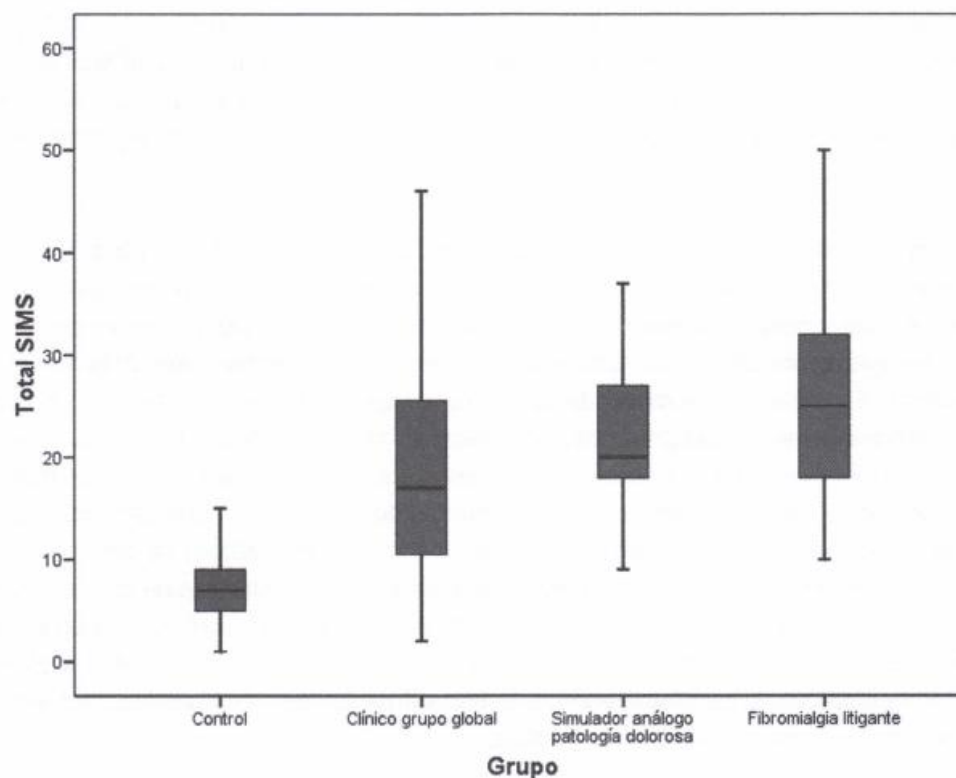


Tabla 4.48. Puntuaciones medias en las escalas del SIMS de los grupos control, clínico, simulador análogo de patología dolorosa y de fibromialgia litigante. Estudios de la adaptación española

Escalas del SIMS	Grupo control ^a		Grupo clínico ^b		Grupo simulador análogo: Patología dolorosa ^c		Grupo médico-legal fibromialgia litigante ^d		Tamaño del efecto Clínico frente a fibromialgia litigante	
	M	Dt	M	Dt	M	Dt	M	Dt	d	Categoría
Total	7,6	3,6	18,5	9,7	23,4	9,5	25,5	10,2	0,7	Moderado
Psicosis	0,4	0,7	1,9	2,3	2,7	3,0	2,1	3,0	0,1	—
Deterioro neurológico	0,8	1,2	4,1	3,1	5,7	3,4	8,3	3,5	1,3	Grande
Trastornos amnésicos	0,8	1,2	3,5	3,2	3,2	3,6	4,0	3,6	0,2	—
Baja inteligencia	1,8	1,4	2,7	1,7	2,6	1,4	2,6	1,4	-0,1	—
Trastornos afectivos	3,8	1,7	6,4	2,6	9,2	2,0	8,5	1,7	1,0	Moderado

Nota. n^a= 147; n^b= 152; n^c= 34; n^d= 30.

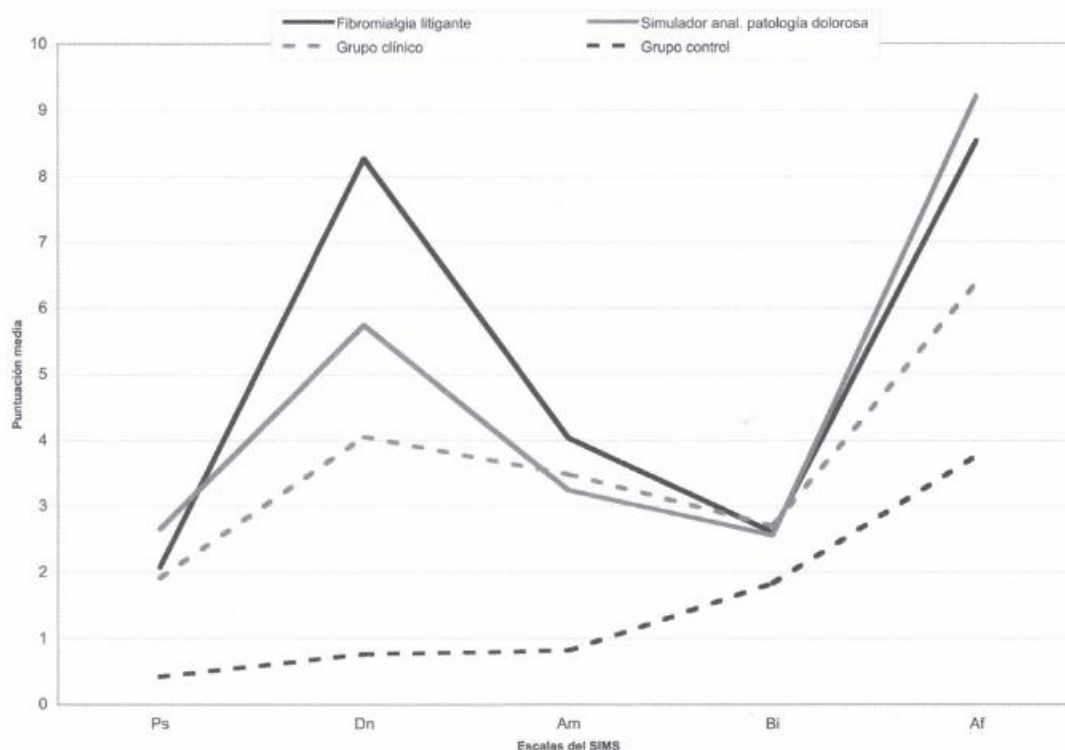
Figura 4.17. Diagrama de caja y bigotes^a de la puntuación total en el SIMS en los grupos control, clínico, simuladores análogos de patología dolorosa y fibromialgia litigante. Datos de la adaptación española



8. Los diagramas de caja y bigotes son gráficos que representan la distribución de una puntuación en cada uno de los grupos. La caja central indica el rango en el que se concentra el 50% central de los datos. Sus extremos son, por lo tanto, el 1^{er} y 3^{er} cuartil de la distribución (percentil 25 y 75). La línea central en la caja es la mediana. Los extremos de los «bigotes» que salen de la caja son los valores que delimitan el 95% central de los datos. De este modo representa en qué rango de puntuaciones se sitúan la mayoría de los sujetos en cada uno de los grupos.



Figura 4.18. Puntuaciones medias en las escalas del SIMS en los grupos control, clínico, simuladores análogos de patología dolorosa y fibromialgia litigante. Datos de la adaptación española



4.3.3. Estudios de convergencia con otras pruebas

4.3.3.1. Estudios originales

Como se puede ver en la tabla 4.49, en la que aparecen algunos análisis de Smith y Burger (1997) no publicados, el SIMS muestra una adecuada convergencia con otras medidas de simulación existentes. En concreto la puntuación total del SIMS tiene altas correlaciones tanto con la puntuación F ($r = 0,84$) y el índice F-K ($r = 0,81$) del MMPI como con las escalas Locura ($r = -0,71$) y Retraso ($r = -0,60$) de la *Escala de simulación* de Schretlen y Arkowitz (1990). La correlación hallada con la escala Manipulación de la imagen del 16 PF fue más moderada ($r = 0,45$), probablemente debido a la falta de solapamiento específico entre los constructos medidos por ambas escalas (p. ej., la escala Manipulación de la imagen del 16PF no refleja aspectos del deterioro cognitivo que sí se incluyen en el SIMS).

Cuando se analizan las correlaciones al nivel de las escalas del SIMS, éstas muestran correlaciones entre moderadas y altas con la escala F y el índice F-K del MMPI (rango= 0,47 a 0,84). Tal y como cabría esperar, y dado que la escala F y el índice F-K son considerados representaciones de niveles extremos de psicopatología, las correlaciones más altas se obtuvieron entre estas puntuaciones y la escala Psicosis del SIMS. Por otra parte, resulta interesante observar cómo las escalas Locura y Retraso de la *Escala de simulación* de Schretlen y Arkowitz (1990) obtienen sus mayores correlaciones con la escala Baja inteligencia del SIMS. Esto era esperable en el caso de la escala Retraso (ambas evalúan la simulación de retraso intelectual o baja inteligencia) pero no en la escala Locura que, sorprendentemente, correlaciona más con las puntuaciones de la escala Baja inteligencia del SIMS ($r = -0,83$) que con las de Psicosis ($r = -0,53$). No resulta sorprendente sin



embargo las bajas correlaciones de las puntuaciones de estas escalas (Locura y Retraso) con las de la escala Trastornos afectivos del SIMS ($r = -0,19$ y $r = -0,21$ respectivamente) ya que no fueron creadas con la intención de detectar individuos que simularan problemas de ansiedad o depresión. Con la escala Manipulación de la imagen del 16 PF las correlaciones han sido en general bajas, con la excepción de la escala Trastornos afectivos, con la que se obtiene una correlación moderada ($r = 0,58$). Esta correlación sugiere que el principal componente evaluado en esta escala del 16 PF son los aspectos afectivos.

Tabla 4.49. Correlaciones entre las escalas del SIMS y otras medidas de simulación. Estudios originales

Escalas del SIMS	MMPI		16 PF	Escala de simulación	
	F	Índice F-K	Manipulación de la imagen	Locura	Retraso
Total	0,84	0,81	0,45	-0,71	-0,60
Psicosis	0,84	0,83	0,47	-0,53	-0,43
Deterioro neurológico	0,78	0,76	0,45	-0,58	-0,50
Trastornos amnésicos	0,53	0,49	0,22	-0,61	-0,49
Baja inteligencia	0,53	0,47	0,10	-0,83	-0,70
Trastornos afectivos	0,63	0,65	0,58	-0,19	-0,21

Nota. MMPI (Inventario multifásico de personalidad de Minnesota, Hathaway y McKinley, 1943). 16PF (Cuestionario factorial de personalidad, Cattell, Eber y Tatsuoka, 1970). Escala de simulación (Schretlen y Arkowitz, 1990).

4.3.3.2. Estudios independientes

En el estudio independiente realizado por Heinze y Purisch (2001) con 57 varones clasificados como simuladores también se encontraron correlaciones entre moderadas y altas de la puntuación total del SIMS con otros índices habitualmente empleados en la detección de la simulación tales como las escalas de validez del MMPI-2 (con correlaciones entre $-0,47$ y $0,50$), las escalas de la SIRS (correlaciones entre $0,43$ y $0,80$) y el M-Test (correlaciones entre $0,58$ y $0,67$).

Los datos no publicados de West (C. West, comunicación personal, 28 de julio de 2004) con una muestra de 20 varones y mujeres evaluados para determinar su nivel de discapacidad también demostraron la validez convergente del SIMS. Incluso en esta pequeña muestra, se hallaron correlaciones altas entre las puntuaciones totales del SIMS y medidas de manipulación de la imagen (correlación con la escala Impresión negativa del PAI, $r = 0,94$), de simulación de psicopatología (puntuación total en el M-Fast, $r = 0,93$) y de simulación de problemas de memoria (TOMM ensayo 1, $r = -0,89$; TOMM ensayo 2, $r = -0,89$; y TOMM retención, $r = -0,91$).

4.3.3.3. Estudios de la adaptación española

Tal y como se describió en el apartado 4.1, en la adaptación española se pudo contar con una muestra de 453 casos procedentes de contextos médico-legales (mutuas de trabajo, aseguradoras o consultas de psicología forense) a los que se les había aplicado tanto el SIMS como otras pruebas clásicas como el MMPI-2, el MCMI-II y el MCMI-III. En concreto, se contó con 305 sujetos a los que se había evaluado con el SIMS y el MMPI-2, 81 sujetos evaluados con el SIMS y el MCMI-II y 67 casos con el MCMI-III y el SIMS.

A partir de estos datos se analizó la convergencia del SIMS con las puntuaciones clásicamente consideradas del MMPI-2 para la evaluación de la simulación (González Ordi e Iruarizaga Díez, 2005) y del MCMI-II y MCMI-III. En la tabla 4.50 puede observarse cómo existe una alta correlación entre la puntuación total del SIMS y las distintas puntuaciones e índices de simulación considerados en el MMPI-2 (correlaciones entre $0,77$ y $0,48$), dato que refuerza la validez convergente del SIMS.



Si analizamos el patrón de correlaciones al nivel de las escalas del SIMS se puede advertir un respaldo a la interpretación de cada una de las escalas del SIMS consideradas individualmente. La escala F obtiene su mayor correlación con la escala Psicosis del SIMS ($r=0,60$) así como con las escalas Deterioro neurológico y Trastornos amnésicos ($r=0,57$). Esto es coherente con el contenido de los ítems de la escala F, en la que aproximadamente un tercio de ellos reflejan ideación paranoide o procesos psicóticos mientras el resto están relacionados con apatía esquizoide y falta de implicación, cinismo y actitudes antisociales, hostilidad familiar y síntomas somáticos (Nichols, 2002). La escala Fb y el índice F-K muestran un patrón similar aunque con correlaciones ligeramente mayores con la escala Trastornos afectivos del SIMS. La escala Fp, tal y como cabría esperar, tiene menores correlaciones que las anteriores con la escala Psicosis del SIMS, ya que es menos sensible al psicoticismo y recoge un conjunto más heterogéneo de síntomas y patologías. En el caso de las escalas DsR y FBS las correlaciones son mayores con las escalas Deterioro neurológico y Trastornos afectivos. No en vano ambas fueron desarrolladas en el ámbito forense, DsR para diferenciar a sujetos que simulan síntomas de carácter neurótico y FBS para detectar la simulación de quejas somáticas y distrés emocional (Butcher, Arbisi, Atlis y McNulty, 2003). Este patrón de correlaciones de DsR y FBS refuerza la sensibilidad de las escalas Deterioro neurológico y Trastornos afectivos a la simulación de quejas somáticas y malestar emocional (tal y como se abordó en el estudio de la adaptación española con pacientes con dolor crónico y fibromialgia). Finalmente, destaca la baja correlación de la escala Baja inteligencia con todos los indicadores del MMPI-2 lo que parece indicar que este área de simulación no está cubierta por los índices desarrollados por el MMPI-2.

Tabla 4.50. Correlaciones entre las escalas del SIMS y las escalas del MMPI-2 de simulación. Estudios de la adaptación española

Escalas del SIMS	MMPI-2					
	F	F - K	Fb	Fp	DsR	FBS
Total	0,70	0,73	0,77	0,48	0,67	0,61
Psicosis	0,60	0,60	0,61	0,44	0,48	0,26
Deterioro neurológico	0,57	0,58	0,62	0,41	0,57	0,57
Trastornos amnésicos	0,57	0,59	0,65	0,38	0,51	0,46
Baja inteligencia	0,31	0,31	0,31	0,21	0,19	0,17
Trastornos afectivos	0,46	0,52	0,55	0,27	0,54	0,55

Nota. N= 305. Todas las correlaciones son significativas al nivel de $p<0,01$. F: Infrecuencia; F-K: Índice F-K de Gough; Fb: F posterior; Fp: Psicopatología infrecuente (Arbisi y Ben-Porath, 1995); DsR: Escala de disimulo revisada de Gough; FBS: Escala «Fake Bad Scale» de Less-Haley, English y Glenn (1991).

Las correlaciones con los índices de simulación del MCMI-II, el MCMI-III y el SIMS aparecen en la tabla 4.51. Como puede advertirse, tanto sólo se obtienen correlaciones moderadas entre la puntuación total del SIMS y la escala Mala imagen (Z) del MCMI-II y el MCMI-III. Si analizamos el perfil por escalas, se observa que la mayor correlación es con las escalas Deterioro neurológico y Trastornos afectivos del SIMS.

Tabla 4.51. Correlaciones entre las escalas del SIMS y la escala de devaluación o mala imagen (Z) del MCMI-II y MCMI-III. Estudios de la adaptación española

Escalas del SIMS	Escala Mala Imagen (Z)	
	MCMI-II	MCMI-III
Total	0,55	0,55
Psicosis	0,35	0,37
Deterioro neurológico	0,47	0,44
Trastornos amnésicos	0,33	0,33
Baja inteligencia	0,43	0,37
Trastornos afectivos	0,47	0,42



Aunque existe cierta convergencia entre el SIMS y la escala Mala imagen de las distintas versiones del MCMI, las correlaciones son mucho más moderadas que las encontradas con el MMPI-2. Ello puede ser debido a que, en esencia, el MCMI-II y el MCMI-III han demostrado resultados muy poco prometedores en cuanto a la detección de exageración de síntomas se refiere (McDermott y Feldman, 2007) y algunos autores no consideran aconsejable su utilización para la evaluación forense de la simulación (Sellbom y Bagby, 2008).

5. Normas de interpretación

En este capítulo se incluyen aspectos generales y específicos que deben tenerse en cuenta a la hora de interpretar las puntuaciones del SIMS. En primer lugar se valora de forma general el proceso de detección de la simulación y los posibles errores que pueden darse junto con sus consecuencias. A continuación se encuadra al SIMS en este marco y se describe resumidamente el proceso de establecimiento de los puntos de corte empleados en la adaptación española y los principales resultados obtenidos. Finalmente se incluyen las normas específicas a seguir en la interpretación de la prueba y un caso ilustrativo.

El profesional que desee obtener una visión de conjunto del SIMS en la detección de simulación encontrará útil la lectura de los dos primeros apartados. Aquellos interesados en consultar las normas específicas a seguir en la interpretación del SIMS (significado de la puntuación total y cada una de las escalas) deberán consultar el apartado 5.3 y a continuación observar el caso ilustrativo que se presenta en el apartado 5.4.

5.1. La detección de simulación: Implicaciones y tipos de errores en el proceso

Resulta inherente a la hora de determinar la presencia de simulación el discriminar entre los síntomas psicopatológicos o déficits neurocognitivos genuinos y los síntomas fingidos. Sin embargo, es posible que ambos puedan darse simultáneamente. En otras palabras, el diagnóstico de simulación no excluye la presencia de otro trastorno real. Por ejemplo, un individuo que trata de simular déficits cognitivos puede presentar también un trastorno depresivo diagnosticable tras un traumatismo craneoencefálico; o bien, un individuo que simula síntomas de trastorno por estrés postraumático puede presentar psicopatología concomitante asociada a un trastorno de personalidad o a un trastorno por abuso de sustancias. De este modo, la sospecha de simulación deducida a partir de los resultados del SIMS, no debiera negar la posibilidad de que existiera una incapacidad o trastorno genuino concomitante.

La correcta clasificación de un sujeto como simulador o no tiene importantes implicaciones referidas, por un lado, a la estigmatización y por otro, a la obtención de servicios o prestaciones. Los errores más frecuentes que se cometen al tratar de realizar esta clasificación dependen tanto del contexto de evaluación como del propósito de la prueba utilizada para la evaluación. Existen dos tipos de errores que suelen producirse cuando se utiliza un instrumento de medida para clasificar a los individuos: (a) *falsos positivos*, cuando los sujetos que responden honestamente o los individuos con sintomatología genuina son erróneamente identificados como simuladores (el test los clasifica como «positivos» en simulación pero son falsos positivos), y (b) *falsos negativos*, cuando un individuo que está simulando es erróneamente identificado y se da por válido el informe referido a su sintomatología (el test los clasifica como «negativos» en simulación, no simuladores, pero son falsos negativos).

En relación con la capacidad de detección de una prueba se encuentran los conceptos de sensibilidad y especificidad. La *sensibilidad* (probabilidad de que un simulador sea correctamente identificado como tal) y la



especificidad (probabilidad de que un individuo que responde honestamente sea clasificado como tal) aportan indicadores métricos útiles para comprobar la capacidad del test para clasificar correctamente a un individuo. El *valor predictivo positivo* —VPP— (la probabilidad de que un resultado positivo en el test sea indicativo de simulación) y el *valor predictivo negativo* —VPN— (la probabilidad de que un resultado negativo en el test sea indicativo de respuesta honesta o sintomatología genuina) aportan estimaciones alternativas de la capacidad de clasificación del test, teniendo en cuenta las tasas de prevalencia del trastorno. La capacidad total de la prueba para clasificar correctamente o identificar a los individuos como simuladores frente a individuos que responden honestamente se denomina *eficacia del test*¹.

Aunque la construcción de un instrumento que permita la clasificación completamente precisa de los individuos simuladores es sin duda un objetivo encomiable, la existencia de múltiples fuentes de variabilidad (p. ej., errores aleatorios, de muestreo, de contenido o de medida) impiden el desarrollo de medidas completamente libres de error para la mayoría de los constructos psicológicos. Aunque minimizar tanto los falsos positivos como los falsos negativos es una estrategia preferencial cuando se trata de diagnosticar o clasificar a los individuos, los instrumentos que presentan una mayor especificidad y VPP frente a una mayor sensibilidad y VPN son preferibles en el contexto de la evaluación de la simulación, dado que los falsos positivos se consideran más graves e implican mayores consecuencias para el individuo, que los falsos negativos. En concreto, el error falso positivo al etiquetar a un individuo sintomático como simulador, no siéndolo, puede conllevar la violación de sus derechos y libertades civiles y su inclusión en un proceso judicial con consecuencias penales. Así mismo, esta clasificación errónea podría suponer que el individuo no recibiera las ayudas sanitarias, compensaciones o prestaciones por su discapacidad a las que tendría derecho y que son necesarias para su recuperación o para mejorar su calidad de vida.

Por el contrario, el falso negativo, al diagnosticar la presencia de un trastorno físico o mental genuino en un individuo que está simulando, podría conllevar la concesión de prestaciones y atenciones médicas y psicológicas o compensaciones y retribuciones económicas que incrementan innecesariamente el gasto público y limitan los recursos disponibles para aquellas personas que presentan una discapacidad genuina. Además, en el contexto forense, los errores falsos negativos pueden implicar que no se procese a un individuo que es culpable o que dicho individuo consiga evitar el ingreso en instituciones penitenciarias, accediendo en virtud de su simulación al sistema sanitario. No obstante, en general, en el contexto de la evaluación de la simulación, los efectos concomitantes al diagnóstico de los falsos negativos son preferibles a los efectos derivados de los falsos positivos (violación de los derechos y libertades civiles).

Como se ha mencionado anteriormente, dependiendo del contexto de la evaluación y el propósito del test empleado, es admisible la existencia de ciertos errores en la clasificación de los individuos. Frente a la deseable minimización de los falsos positivos, cuando consideramos la utilización de test como prueba de *screening*, la importancia de la existencia de falsos positivos puede ser más relativa. Si el diagnóstico de simulación se fundamenta en base a una única fuente de información, entonces la tasa de falsos positivos debería tender a cero. Sin embargo, el SIMS se ha concebido como una prueba de *screening*, esto es un instrumento que nos indica la existencia de un determinado patrón de conductas (exageración de síntomas, en nuestro caso) y que es necesario realizar una evaluación más pormenorizada y exhaustiva sobre dicho patrón; por lo que una tasa de falsos positivos puede ser más tolerable. En dicha situación, se alcanza una mayor precisión en el proceso global de identificación de los simuladores cuando en una clasificación inicial a partir de los resultados del *screening* se clasifica incorrectamente a sujetos que pueden estar respondiendo honestamente (falsos positivos) ya que en fases posteriores, una evaluación más detallada y exhaustiva, con el empleo de otros instrumentos de medida

1. **Nota de los adaptadores:** Para obtener mayor información sobre los diferentes índices de validez de un test diagnóstico se puede consultar el capítulo 10 de Martínez Arias, M. R., Hernández Lloreda, M. J. y Hernández Lloreda, M. V. (2006). *Psicometría*. Madrid: Alianza Editorial.



más específicos, permitirá minimizar los falsos positivos. En otras palabras, los falsos positivos producidos por las medidas de *screening* podrán ser corregidos mediante una evaluación posterior más precisa.

Por tanto, el SIMS está diseñado para alertar de la existencia de un patrón de exageración de síntomas, la determinación de dicho patrón como simulación deberá ser posteriormente confirmada o refutada mediante una evaluación más detallada y exhaustiva, atendiendo a diversas fuentes de información y a otros instrumentos más específicos.

5.2. La detección de simulación con el SIMS: establecimiento de los puntos de corte de la adaptación española

Tal y como se comentaba en el apartado anterior, el SIMS fue concebido como una prueba de *screening* que detectara todos aquellos posibles casos en los que hay sospecha de simulación. El *screening* permite descartar un importante número de casos de los que realmente no hay sospecha de simulación para centrarse en aquellos en los que sí puede existir.

Para conseguir este objetivo los autores originales (Widows y Smith, 2005) establecieron que deberían ser consideradas como indicativas de intento de simulación aquellos valores de la puntuación total superiores a 14. No obstante, algunas investigaciones posteriores han empleado como punto de corte del SIMS una puntuación total superior a 16, tanto en estudios independientes (Lewis, Simcox y Berry, 2002; Geraerts, Jellicic y Meckelbach, 2006; Jellicic, Hessels y Merckelbach, 2006; Clegg, 2007; Alwes, Clark, Berry y Granacher, 2008) como en la propia adaptación realizada al holandés en colaboración con uno de los autores originales (Merckelbach y Smith, 2003).

Los estudios realizados con la adaptación española han valorado ambos puntos de corte (Total > 14 y Total > 16), tal y como se expone detalladamente en las páginas 54 a 71 de este manual. En su conjunto, los resultados obtenidos sugieren como más recomendable para su uso aplicado en la adaptación española el punto de corte de 16. Este punto de corte permite aumentar susceptiblemente la especificidad obtenida, mientras que su sensibilidad solo se ve mínimamente afectada. Estos resultados han motivado que en la corrección de la adaptación española se utilice por defecto el punto de corte de 16 (tanto en el gráfico obtenido en el perfil como en las pautas interpretativas que a continuación se describen).

En el conjunto de estudios realizados en la adaptación española en distintos contextos y condiciones, tomando como punto de corte 16, el valor predictivo negativo del SIMS (porcentaje de casos clasificados correctamente como de respuesta honesta) ha oscilado entre el 92% y el 98% y su valor predictivo positivo (porcentaje de casos clasificados como con sospecha de simulación que realmente son simuladores) ha fluctuado entre el 43% y el 83%. Estos resultados respaldan su uso como herramienta de *screening* que permite excluir con un alto grado de seguridad a aquellos con respuesta honesta y mantiene a aquellos en los que existe sospecha de simulación.

Con el objetivo ilustrativo de describir cuál podría ser el funcionamiento del SIMS en la práctica cotidiana, se procederá a describir su comportamiento en la muestra del estudio de la adaptación española con los grupos de exageración de síntomas determinados por el MMPI-2² (en las páginas 69 a 71 de este manual se ha incluido una descripción detallada de este estudio).

Si se considera una tasa de prevalencia de la simulación del 30% (Mittenberg, Patton, Canyock y Condit, 2002), de cada 100 casos de esta muestra:

2. Para un análisis más preciso y concreto de la utilidad del SIMS (sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo) se recomienda consultar el capítulo de fundamentación estadística de este manual. Los valores mostrados a continuación deben ser



❑ 53 serían clasificados por el SIMS como «sin sospecha de simulación» (Total ≤ 16):

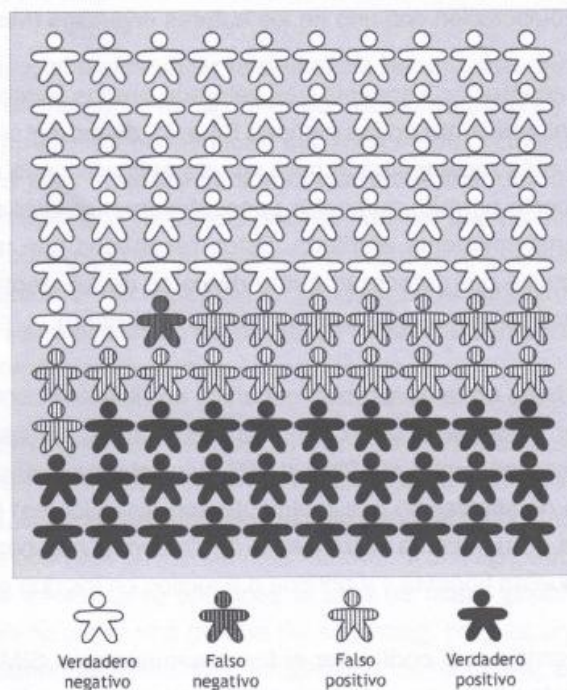
- 52 casos serían *verdaderos negativos*, esto es, habrían sido correctamente clasificados como de respuesta honesta de acuerdo al criterio externo del MMPI-2³.
- 1 caso sería un *falso negativo*, esto es, habría sido incorrectamente clasificado como de respuesta honesta de acuerdo al criterio externo del MMPI-2³.

❑ 47 casos serían clasificados por el SIMS como «con sospecha de simulación» (Total > 16):

- 29 casos serían *verdaderos positivos*, esto es, habrían sido correctamente clasificados como con exageración de síntomas de acuerdo al criterio externo del MMPI-2³.
- 18 casos serían *falsos positivos*, esto es, habrían sido incorrectamente clasificados como con exageración de síntomas de acuerdo al criterio externo del MMPI-2³.

En la figura 5.1 se ilustra gráficamente el porcentaje de casos que caería en cada categoría clasificatoria. Como se puede advertir en esta ilustración, el SIMS mostraría un satisfactorio índice de acierto global (clasificaría correctamente al 81% del total de casos), si bien como prueba de *screening* se focalizaría en la correcta exclusión de aquellos no simuladores (98% de acierto en la categoría de «sin sospecha de simulación», escasa presencia de falsos negativos) y algo menos en aquellos detectados como «con sospecha de simulación» (62% de acierto en la categoría de «con sospecha de simulación», existencia de falsos positivos), ya que posteriormente la evaluación convergente debería determinar quienes de este grupo serían clasificados como simuladores.

Figura 5.1. Representación ilustrativa de la capacidad clasificatoria del SIMS⁴



considerados a efectos meramente ilustrativos y orientativos. Diferencias en las tasas de prevalencia, los criterios externos de referencia o los patrones de simulación de los individuos evaluados influyen en los resultados concretos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos de la prueba.

3. En la página 32 se puede consultar los criterios concretos utilizados para clasificar a los sujetos dentro del grupo de exageración de síntomas a partir de sus puntuaciones en el MMPI-2.
4. Para un análisis más preciso y concreto de la utilidad del SIMS (sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo) se recomienda consultar el capítulo de fundamentación estadística de este manual. Los valores mostrados en esta figura están basados en el estudio del patrón de exageración de síntomas en contextos médico-legales de González Ordi, Santamaría Fernández, Blas-



Además de la puntuación total, el SIMS ofrece puntuaciones independientes de cada una de las cinco escalas de las que está compuesto. Estas puntuaciones permiten al profesional saber en qué área concreta está exagerando su sintomatología el sujeto evaluado. Tal y como se expondrá posteriormente, una vez detectada la sospecha de simulación a partir de la puntuación total de la prueba, se procede a analizar el perfil de las escalas.

Los autores originales establecieron puntos de corte en cada una de las escalas. Tal y como se ha comentado anteriormente, en los estudios de la adaptación española se valoraron dichos puntos de corte en varias muestras, contextos y condiciones. Los resultados obtenidos en estos estudios sugerían que era necesario elevar los puntos de corte originales en uno o dos puntos (un punto en las escalas Psicosis, Deterioro neurológico, Trastornos amnésicos y Baja inteligencia; dos puntos en la escala Trastornos afectivos). Estos puntos de corte alternativos aumentaban la especificidad y el valor predictivo positivo manteniendo niveles similares de sensibilidad y del valor predictivo negativo, por lo que se consideraron más adecuados para la adaptación española. A tenor de estos resultados, en la corrección de la adaptación española se utilizan por defecto estos puntos de corte alternativos (tanto en el gráfico obtenido en el perfil como en las pautas interpretativas que se describen a continuación).

5.3. Normas específicas de interpretación

La interpretación de las puntuaciones del SIMS se realiza en tres pasos:

1. Determinación de sospecha de simulación a partir de la puntuación total en la prueba.
2. Análisis descriptivo de las elevaciones en las puntuaciones de las escalas.
3. Análisis descriptivo de las respuestas dadas a los ítems.

La puntuación total es la mejor predictora de la sospecha de simulación y por lo tanto deberá ser la primera en interpretarse. Posteriormente, el análisis de las elevaciones en las puntuaciones de las escalas y de los ítems proporciona una información cualitativa adicional que puede ayudar a especificar la naturaleza de la sintomatología presentada por el individuo, si es genuina o fingida, con implicaciones para el diagnóstico, las interacciones interpersonales, la intervención terapéutica y la evaluación de los resultados del tratamiento.

El SIMS no emplea escalas transformadas de sus puntuaciones (p. ej., percentiles o puntuaciones T) sino puntos de corte que sirven al evaluador para tomar decisiones sobre si tiene que seguir profundizado y realizar una evaluación más exhaustiva y detallada o no. Tal y como se ha comentado anteriormente en este capítulo, estos puntos de corte han sido establecidos en la adaptación española a partir del estudio comparativo de muestras de controles, clínicos y simuladores en distintos contextos y condiciones. En el perfil que se obtiene al corregir el SIMS, aquellas puntuaciones inferiores al punto de corte aparecen en el área de «sin sospecha de simulación» y aquellas superiores en el área de «sospecha de simulación».

co y Gallardó (2008) (páginas 69 a 71 del manual). Diferencias en las tasas de prevalencia, los criterios externos de referencia o los patrones de simulación de los individuos evaluados influyen en los resultados concretos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos de la prueba.



Tabla 5.1. Puntos de corte propuestos en la adaptación española para sospecha de simulación

Escalas del SIMS	Puntos de corte propuestos en la adaptación española
Total	>16
Psicosis (Ps)	> 2
Deterioro neurológico (Dn)	> 3
Trastornos amnésicos (Am)	> 3
Baja inteligencia (Bi)	> 3
Trastornos afectivos (Af)	> 7

5.3.1. Determinación de sospecha de simulación a partir de la puntuación Total en la prueba

La puntuación total del SIMS proporciona una estimación general de la probabilidad de que un individuo esté fingiendo síntomas psicopatológicos o alteraciones neurocognitivas.

Los individuos que obtienen una puntuación en la escala Total del SIMS **mayor de 16** puntos son identificados como probables simuladores y, consecuentemente, debe realizarse una evaluación más precisa y detallada, debido a que contestan sistemáticamente a un número muy alto de ítems atípicos, improbables, inconsistentes o ilógicos.

Puesto que el objetivo de una prueba de *screening* de simulación como el SIMS es detectar a todos los simuladores potenciales para que puedan ser evaluados más detallada y exhaustivamente deberían tratar de minimizarse los errores del tipo falso negativo. Así, no es necesario evaluar más extensamente a los individuos que obtengan una puntuación total **igual o menor de 16 puntos** (incluso aunque en alguna de las escalas específicas superen el punto de corte), a no ser que otras fuentes de datos lo aconsejen (discrepancias extremas entre la información del paciente y su presentación clínica).

5.3.2. Interpretación de las escalas

En aquellos casos en los que se haya determinado sospecha de simulación (total > 16), resultará interesante conocer en qué áreas concretas parece centrarse el patrón de exageración de síntomas. El examen de las elevaciones en las puntuaciones de las escalas del SIMS proporciona evidencia sobre la posible simulación e información cualitativa acerca de la naturaleza de los síntomas (fingidos o genuinos). Dicha información cualitativa puede resultar de gran utilidad para conocer qué sintomatología se presenta de forma atípica, o bien, de qué manera el individuo intenta simular un trastorno en particular.

Aunque en el capítulo 1 de este manual ya se ofrecía una descripción de cada una de las escalas del SIMS (véase la tabla 1.1), este apartado aporta información más detallada sobre las mismas junto con ciertas claves para la interpretación de las elevaciones que servirán de guía para comprender el perfil clínico del individuo evaluado.

Psicosis (Ps)

La escala Psicosis se compone de 15 ítems que reflejan el grado en que el sujeto presenta síntomas psicóticos inusuales o extravagantes que no son típicos de la patología psicótica real. Los síntomas inconsistentes pueden incluir síntomas ilógicos o extravagantes (p. ej., «Me he dado cuenta de que mi sombra baila como



loca incluso cuando me quedo quieto») o síntomas muy extremos (p. ej., «No hay nada que pueda hacer, aparte de tomar medicación, que tenga algún efecto sobre las voces que oigo»). Los síntomas atípicos son aquellos que pueden ser sintomáticos de una psicosis genuina, pero que rara vez o de forma muy infrecuente ocurren en pacientes psicóticos genuinos (p. ej., «Creo que el gobierno ha instalado cámaras de vídeo en las señales de tráfico para espiarme»). Incluso un número bajo de ítems inconsistentes, extravagantes o atípicos respondidos en esta escala (**puntuación superior a 2**) es indicativo de simulación de psicosis, dada la infrecuencia con la que dichos ítems pueden presentarse clínicamente en pacientes psiquiátricos reales.

Deterioro neurológico (Dn)

La escala de Deterioro neurológico, compuesta por 15 ítems, evalúa el grado en que el sujeto presenta síntomas de tipo neurológico ilógicos o muy atípicos. Las elevaciones en esta escala aparecen cuando el individuo responde a un elevado número de síntomas que resultan ilógicos, son inconsistentes con los síntomas que aparecen en los trastornos neurológicos (p. ej., «Tengo dolor de cabeza y mareos justo cuando olvido algo») o que ocurren muy rara vez en pacientes con deterioro neurológico (p. ej., «No he experimentado cambios en mi sentido del olfato»). **Puntuaciones superiores a 3** en esta escala se presentan rara vez en individuos con trastornos neurológicos genuinos y, por tanto, son indicativas de una mayor probabilidad de existencia de simulación. Debido a las dificultades reales que los pacientes con daño cerebral traumático o traumatismo craneoencefálico tienen para describir sus síntomas es recomendable realizar un análisis de los ítems cuando se produzca una elevación en esta escala.

Trastornos amnésicos (Am)

La escala Trastornos amnésicos, compuesta por 15 ítems, evalúa el grado en que el sujeto presenta síntomas relacionados con trastornos de memoria que son inconsistentes con los patrones de deterioro producidos por disfunción o daño cerebral real. Dichos síntomas difieren de aquellos que presentan pacientes reales en su aparición, curso o naturaleza, y generalmente reflejan un conocimiento poco preciso de un trastorno amnésico genuino (p. ej., «Mi vida pasada y acontecimientos importantes se vuelven borrosos durante la noche»). Otros síntomas pueden ocurrir en pacientes con daño o disfunción cerebral, pero son muy atípicos o muy rara vez se presentan (p. ej., «Cuando no puedo recordar algo, las instrucciones o consejos no me sirven de ayuda»). Puntuaciones elevadas en esta escala (**superiores a 3**) son indicativas de una posible simulación de alteraciones en la memoria, debido a la gran inconsistencia o infrecuencia de los ítems respondidos.

Baja inteligencia (Bi)

La escala Baja inteligencia está compuesta por 15 ítems que evalúan el grado en que el individuo intenta fingir discapacidad cognitiva general o déficit intelectual. Los ítems de esta escala exigen un nivel de conocimientos tan básico, que incluso pacientes con déficits intelectuales los responderían correctamente (p. ej., «Cristóbal Colón descubrió América»; «La capital de Italia es Hungría»). Una puntuación elevada en esta escala (**superior a 3**) conlleva la sospecha de que el individuo podría estar fingiendo su discapacidad intelectual, debido a que responde consistentemente mal a un número alto de ítems simples.

Trastornos afectivos (Af)

La escala Trastornos afectivos contiene 15 ítems que evalúan el grado en que el sujeto informa de síntomas atípicos de depresión y ansiedad. Estos ítems se centran principalmente en síntomas que pueden estar presentes en pacientes ansiosos o depresivos, pero que ocurren con tanta infrecuencia que resultan atípicos incluso para pacientes con trastornos afectivos genuinos (p. ej., «Mi estado de ánimo empeora a medida que



pasa el día»). Por tanto, no existe un síntoma en sí mismo que resulte indicativo de simulación; más bien, lo que hace pensar en la posibilidad de simulación es el hecho de que el individuo responda consistentemente a un número alto de ítems de esta escala (**puntuación superior a 7**), que generalmente no se presentarían como una constelación de síntomas, incluso en casos clínicos atípicos de trastornos afectivos o de ansiedad.

5.3.3. Consideraciones sobre la interpretación de los ítems

Aunque no existe una evaluación formal de la simulación a nivel de la interpretación de los ítems, su examen puede ofrecer información útil sobre el particular estilo de respuestas atípicas o simuladas que presenta el sujeto evaluado. En concreto, si un sujeto presenta una frecuencia alta de ítems extravagantes o ilógicos en diversas escalas, puede ser indicativo de una forma poco sofisticada de presentación de los síntomas simulados o de que el individuo pretenda ofrecer una imagen lo más deteriorada posible. Sin embargo, responder a más ítems atípicos que ilógicos puede indicar la presencia de un trastorno psicopatológico o cognitivo genuino pero atípico, sobre todo cuando la puntuación total sea igual o inferior al punto de corte recomendado. El análisis de los ítems es recomendable cuando se evalúe a individuos que presenten daño cerebral traumático o traumatismo craneoencefálico, debido a las dificultades concomitantes que dichos pacientes tienen para describir sus síntomas.

Aunque el SIMS no incluye ninguna escala que evalúe formalmente el estilo de respuesta inconsistente o aleatorio (como sí lo hace por ejemplo el MMPI-2), el análisis de los ítems proporciona información cualitativa adicional acerca de la actitud ante la prueba y la veracidad de las quejas sintomáticas. Específicamente, el análisis de determinados grupos de ítems puede indicar si el individuo evaluado presenta un estilo general de respuesta inconsistente o si los síntomas reflejados son inconsistentes entre sí.

En la relación de ítems que aparece a continuación se incluyen diversos grupos de elementos que son relevantes para la evaluación clínica de la consistencia de las respuestas:

- 15. *El mayor problema que tengo es con mi memoria.*
- 18. *Más de tres veces al día, me levanto para coger algo pero olvido qué es lo que era.*
- 59. *Siento partes de mis extremidades entumecidas, aunque puedo moverlas sin dificultad.*
- 64. *A veces mis pantorrillas están tan entumecidas que soy incapaz de moverlas.*

- 16. *Incluso estando deprimido la mayor parte del tiempo, me siento mejor por la mañana tras una buena noche de sueño.*
- 17. *Mi estado de ánimo es peor por la noche.*
- 37. *Mi estado de ánimo empeora a medida que pasa el día.*
- 47. *Me siento deprimido todo el tiempo.*

5.4. Caso ilustrativo

Con el fin de ilustrar el uso del SIMS, se presenta a continuación un caso real en el que se ha empleado como medida de *screening* y como instrumento para proporcionar información convergente acerca de la posibilidad de simulación. El diagnóstico de simulación sólo debe establecerse tras la obtención de la evidencia convergente de diversas fuentes de información mediante una evaluación multimétodo/multisistema (González Ordi y Gancedo Rojí, 1999; Slick, Sherman y Iverson, 1999; González Ordi, Capilla Ramírez y Matalobos Veiga, 2008).



Este caso pertenece a la muestra de sujetos de la adaptación española y la aplicación del SIMS se realizó con fines de investigación por lo que dicha evaluación no supuso en ningún caso consecuencias legales posteriores.

La evaluación psicológica encaminada a detectar una posible simulación se activaba ante la existencia de sospecha clínica de simulación, al presentar tres de los cuatro indicadores propuestos por el DSM-IV (véase capítulo 1): (1) presentación en un contexto médico-legal, (2) discrepancia acusada entre el estrés o la alteración explicados por la persona y los datos objetivos de la exploración médica y (3) falta de cooperación durante la valoración diagnóstica e incumplimiento del régimen de tratamiento prescrito. Dada esta sospecha previa, se decidió emplear el SIMS como medida de *screening* y, si se obtenían resultados positivos, otros instrumentos de evaluación de la personalidad (MMPI-2) que permitieran obtener evidencia convergente que confirmara dicha hipótesis.

Se han omitido el nombre y otras características personales de la paciente, así como el centro de procedencia del caso con el fin de mantener la confidencialidad de los datos.

5.4.1. Descripción del caso

Mujer de 49 años, diagnosticada de **fibromialgia** y de **depresión mayor** en el Sistema Público de Salud, pasa a seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes por la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de referencia. Se le prescribe la siguiente medicación: Seroxat, Diacepam, Tryptizol, Omeprazol, Tonopan y Airtal. Manifiesta experimentar severos dolores de tipo generalizado y estados de intensa tristeza, astenia y anhedonia, que le impiden realizar su vida normal. Acude a la mutua para las citas de control de la baja laboral con un bastón inglés y en actitud flexa del tronco. Pronto empieza a no acudir a las citas programadas. Ante las ausencias reiteradas, el servicio de enfermería de la mutua intenta contactar por teléfono, comprobando que no se encuentra en su casa en repetidas ocasiones. Por medio de la empresa donde trabaja se consigue su teléfono móvil, mediante el cual se contacta con ella «coincidiendo» con que durante esa llamada se escucha por megafonía el anuncio de las rebajas en unos grandes almacenes. Se le cita de nuevo y una vez más vuelve a faltar a la cita.

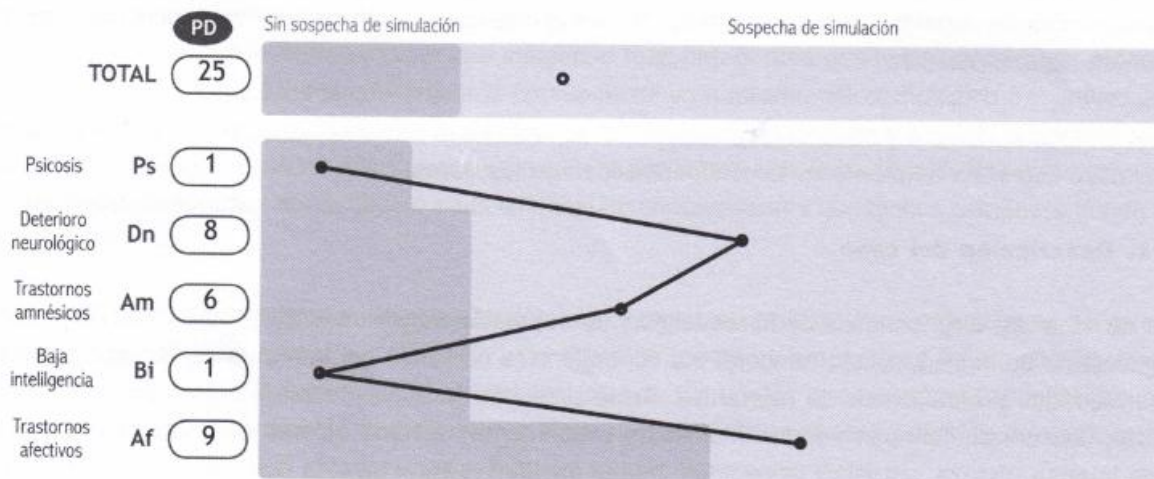
Durante una de las pocas citas a las que había acudido, la paciente se prestó sin mucha predisposición a la evaluación psicológica que se le proponía, que incluyó el SIMS.

Los resultados de *screening* del SIMS fueron los que aparecen en la figura de la siguiente página.



Figura 5.2. Perfil del SIMS de D.F.B.

PERFIL		Nombre: D.F.B.
		Edad: 49 años Sexo: Mujer Fecha de aplicación: 02/04/2009
		Baremo: Adaptación española
		Responsable de la aplicación:



La puntuación total en el SIMS resulta superior a la recomendada como punto de corte para determinar la existencia de sospecha de simulación. El individuo contesta con frecuencia a ítems referidos a síntomas atípicos en pacientes con trastornos psicopatológicos o neurocognitivos genuinos, lo que hace sospechar que pueda estar simulando. El perfil del SIMS refleja un patrón centrado en la presentación de síntomas de tipo neurológico ilógicos o muy atípicos, síntomas relacionados con trastornos de memoria que son inconsistentes con los patrones de deterioro producidos por disfunción o daño cerebral real y síntomas atípicos de depresión y ansiedad. Se recomienda una evaluación más extensa y exhaustiva con el fin de confirmar esta sospecha.



TEA Ediciones

Copyright © 2009 by TEA Ediciones, S.A.
Informe generado desde www.teacorrige.com
Prohibida la reproducción total o parcial. Todos los derechos reservados.



Tal y como reflejan estas puntuaciones y el breve informe incluido en el perfil, la puntuación total en el SIMS resulta superior a la recomendada como punto de corte para determinar la existencia de sospecha de simulación. La paciente contesta con frecuencia a ítems referidos a síntomas atípicos en pacientes con trastornos psicopatológicos o neurocognitivos genuinos, lo que hace sospechar de la posibilidad de que esté simulando. El perfil del SIMS refleja un patrón de exageración de síntomas centrado en la presentación de síntomas de tipo neurológico ilógicos o muy atípicos, síntomas relacionados con trastornos de memoria que son inconsistentes con los patrones de deterioro producidos por disfunción o daño cerebral real e informa de síntomas atípicos de depresión y ansiedad.

El hecho de que, además de la escala total, las escalas Deterioro neurológico y Trastornos afectivos sean las que presenten mayores puntuaciones resulta muy característico en pacientes fibromiálgicos litigantes, donde el patrón de exageración de síntomas está específicamente relacionado con el componente somático (dolor) y el componente emocional (depresión) vinculados a esta patología (Capilla Ramírez, González Ordi y Santa-maría Fernández, 2008).

Con el fin de obtener datos convergentes que ayudaran a confirmar la hipótesis de una probable simulación, se aplicó posteriormente el MMPI-2, obteniendo las siguientes puntuaciones en las escalas de validez:

MMPI-2: escalas de validez	Puntuación Directa	Puntuación T
F: Infrecuencia	18	75
K: Defensividad	9	38
F-K: Índice de Gough	+9	
Fb: F posterior	13	73
TRIN	18	99
VRIN	10	57

Los datos del MMPI-2 convergen con los del SIMS a la hora de detectar un patrón significativo de exageración de síntomas, ya que cuatro de las escalas de validez apuntan en esa dirección. Las elevaciones en F y Fb y las puntuaciones bajas en K indican exageración deliberada de la sintomatología psicopatológica y, además, el índice F-K es positivo e indicativo de simulación (González Ordi y Gómez Segura, 2002). Adicionalmente, la escala suplementaria Es (Fuerza del Yo) presenta puntuaciones T extremadamente bajas (T=26). Según los criterios propuestos recientemente por Aguerrevere, Greve, Bianchini y Meyers (2008), los valores obtenidos por la paciente en las escalas F, F-K y Es contribuyen significativamente a considerar sospecha de simulación. Debemos señalar también que la paciente muestra un sesgo deliberado a contestar «verdadero» a las preguntas de la prueba, lo que probablemente esté contribuyendo a presentarse a sí misma con la peor imagen posible.

Ante los hechos acaecidos referidos al incumplimiento de las citas y la baja adherencia al régimen de tratamiento prescrito, la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales encarga a un detective que realice un seguimiento fotográfico y videográfico de la conducta de la paciente en su ambiente cotidiano. De dicho seguimiento se concluye que realiza una vida activa completamente normal, lo que incluye hacer la compra diaria y cargar con bolsas pesadas, alternar con amigas en cafeterías y restaurantes, visitar grandes almacenes con frecuencia, etc.

Se suspenden las prestaciones económicas y ante las protestas de la paciente, los abogados de la mutua presentan la documentación fotográfica y videográfica obtenida, explicándole que existe la alternativa de darse de alta o bien entrar en un proceso de demanda judicial; ante lo cual, la paciente decide darse de alta voluntaria ese mismo día en el Sistema Público de Salud.

- Aguerrevere, L. E., Greve, K. W., Bianchini, K. J. y Meyers, J. E. (2008). Detecting malingering in traumatic brain injury and chronic pain with an abbreviated version of the Meyers Index for the MMPI-2. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 23, 831-838.
- Alwes, Y. R., Clark, J. A., Berry, D. T. R. y Granacher, R. P. (2007). Screening for Feigning in a Civil Forensic Setting. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 30, 1-8.
- American Educational Research Association, American Psychological Association y National Council on Measurement in Education (1999). *Standards for educational and psychological testing*. Washington, DC: American Psychological Association.
- American Psychiatric Association (1980). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (3ª ed.). Washington, DC: Autor.
- American Psychiatric Association (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4ª ed.). Washington, DC: Autor.
- Anderson, E. W., Trethowan, W. H. y Kenna, J. C. (1956). An experimental approach to the problem of simulation in mental disorder. *Proceedings of the Royal Society of Medicine*, 49, 513-520.
- Arbisi, P. A. y Ben-Porath, Y. S. (1995). An MMPI-2 infrequent response scale for use with psychopathological populations: The F(p) Scale. *Psychological Assessment*, 7, 424-431.
- AA. VV. (2005). Monográfico sobre «Evaluar la simulación, el fingimiento y la mentira. Detección de la simulación en la evaluación psicológica. Fingimiento en los ámbitos forense, clínico y laboral». *Papeles del Psicólogo*, 26, 57-137.
- Beaber, R. J., Marston, A., Michelli, J. y Mills, M. J. (1985). A brief test for measuring malingering in schizophrenic individuals. *American Journal of Psychiatry*, 142, 1478-1481.
- Beck, A. T. y Steer, R. A. (1987). *Manual for the Beck Depression Inventory*. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.
- Beck, A. T., Steer, R. A. y Brown, G. K. (1996). *Beck Depression Inventory manual* (2ª ed.). San Antonio, TX: The Psychological Corporation.
- Bender, S. D. y Rogers, R. (2004). Detection of neurocognitive feigning: Development of a multistrategy assessment. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 19, 49-60.
- Bleuler, E. P. (1951). *Textbook of psychiatry* (A. A. Brill, ed. y trad.). Oxford, Inglaterra: Dover (Obra original publicada en 1924).
- Borum, R., Otto, R. y Golding, S. (1993). Improving clinical judgment and decision making in forensic evaluation. *Journal of Psychiatry and Law*, 21, 35-76.
- Burkett, B. G. y Whitley, F. (1998). *Stolen valor: How the Vietnam generation was robbed of its heroes and its history*. Dallas, TX: Verity Press.
- Bury, A. S. y Bagby, R. M. (2002). The detection of feigned uncoached and coached posttraumatic stress disorder with the MMPI-2 in a sample of workplace accident victims. *Psychological Assessment*, 14, 472-484.
- Butcher, J. N., Dahlstrom, W. G., Graham, J. R., Tellegen, A. y Kaemmer, B. (1989). *Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) manual*. Minneapolis: University of Minnesota Press. Edición española: Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2, TEA Ediciones, 2002.
- Calhoun, P. S., Earnst, K. S., Tucker, D. D., Kirby, A. C. y Beckharn, J. C. (2000). Feigning combat-related posttraumatic stress disorder on the Personality Assessment Inventory. *Journal of Personality Assessment*, 75, 338-350.



- Cannon, B. J. (2003). An emotional Stroop effect to malingering-related words. *Perceptual and Motor Skills*, 96, 827-834.
- Capilla Ramírez, P., González Ordi, H. y Santamaría Fernández, P. (2008). *Detección de simulación en dolor crónico*. Comunicación presentada en el VIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Traumatología Laboral – SETLA. Logroño, 27-29 de Noviembre de 2008.
- Cattell, R. B., Eber, H. W. y Tatsuoaka, M. M. (1970). *Handbook of the 16 PF*. Champaign, IL: Institute of Personality and Ability Testing.
- Clegg, C. B. (2007). *Utility of the Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS) and the Assessment of Depression Inventory (ADI) in Screening for Malingering Among Disability Seeking Outpatients* (tesis doctoral, West Virginia University, 2007). Obtenido el 26 de Febrero de 2008 de: https://eidr.wvu.edu/files/5256/Clegg_Carl_thesis.pdf
- Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20, 37-46.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioural sciences* (2ª edición). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
- Colegio Oficial de Psicólogos y Comisión Internacional para el uso de los tests (2000). *Directrices internacionales para el uso de los tests*. Obtenido el 7 de mayo de 2008 de <http://www.cop.es/vernumero.asp?id=40>.
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16, 297-334.
- Cunnen, A. (1997). Psychiatric and medical syndromes associated with deception. En R. Rogers (Ed.), *Clinical assessment of malingering and deception*. 2ª edición (pp. 23-46). Nueva York: Guilford Press.
- Dawes, R. M., Faust, D. y Meehl, P. E. (1989). Clinical versus actuarial judgment. *Science*, 243, 1668-1674.
- DeClue, G. (2002). Practitioner's corner: Feigning ≠ Malingering: A case study. *Behavioral Sciences and the Law*, 20, 717-726.
- Delis, D. C., Kramer, J. H., Kaplan, E. y Ober, B. A. (1987). *CVLT-California Verbal Learning Test manual adult version*. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.
- Derogatis, L. R. (1975). *Symptom Checklist-90 Revised (SCL-90-R) administration, scoring, and procedures manual*. Minneapolis, MN: NCS/Pearson. Edición española: Cuestionario de 90 síntomas - revisado, TEA Ediciones, 2002.
- Drob, S. L., Berger, R. H. y Weinstein, H. C. (1987). Competency to stand trial: A conceptual model for its proper assessment. *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 15, 85-94.
- Edens, J. F., Otto, R. K. y Dwyer, T. (1989). Susceptibility of the Trauma Symptom Inventory to malingering. *Journal of Personality Assessment*, 71, 379-392.
- Edens, J. F., Otto, R. K. y Dwyer, T. (1999). Utility of the Structured Inventory of Malingered Symptomatology in identifying persons motivated to malingering psychopathology. *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 27, 387-396.
- Edens, J. F., Poythress, N. G. y Watkins-Clay, M. M. (2007). Detection of malingering in psychiatric unit and general population prison inmates: A comparison of the PAI, SIMS, and SIRS. *Journal of Personality Assessment*, 88, 33-42.
- Eissler, K. R. (1951). Malingering. En G. B. Wilbur y W. Muensterberger (Eds.), *Psychoanalysis and culture: Essays in honor of Géza Róheim* (pp. 218-253). Nueva York: International Universities Press.
- Elhai, J. D., Naifeh, J. A., Zucker, I. S., Gold, S. V., Deitsch, S. E. y Frueh, B. C. (2004). Discriminating malingering from genuine civilian posttraumatic stress disorder: A validation of three MMPI-2 infrequency scales (F, Fp, and Fptsd). *Assessment*, 11, 139-144.
- Fernández Marín, P., González Ordi, H. y Santamaría Fernández, P. (2008). *Evaluación y detección de la simulación en pacientes del Hospital y Centros Asistenciales de ASEPEYO que cursan baja por AT y por ITCC*. Proyecto de investigación UCM-ASEPEYO. Manuscrito sin publicar.
- Fleiss, J. L. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological Bulletin*, 76, 378-382.
- Fleiss, J. L. (1981). *Statistical methods for rates and proportions* (2ª ed.). Nueva York: Wiley.
- Frueh, B. C. y Kinder, B. N. (1994). The susceptibility of the Rorschach Inkblot Test to malingering of combat-related PTSD. *Journal of Personality Assessment*, 62, 280-298.
- Geraerts, E., Jelicic, M. y Meckelbach, H. (2006). Symptom overreporting and recovered memories of childhood sexual abuse. *Law and Human Behavior*, 30, 621-630.
- Gerson, A. R. (2002). Beyond DSM-IV: A meta-review of the literature on malingering. *American Journal of Forensic Psychology*, 20, 57-69.
- Gervais, R. O., Russell, A. S., Green P. et al. (2001). Effort testing in patients with fibromyalgia and disability incentives. *Journal of Rheumatology*, 28, 1892-1899.
- Gervais, R. O., Green, P., Allen, L. M. et al. (2001). Effects of coaching on symptom validity testing in chronic pain patients presenting for disability assessment. *Journal of Forensic Neuropsychology*, 2, 1-19.
- Gillis, J. R., Rogers, R. y Bagby, R. M. (1991). Validity of the M Test: Simulation-design and natural-group approaches. *Journal of Personality Assessment*, 57, 130-140.
- Golden, C. J. (1978). *Stroop Color and Word Test: A manual for clinical and experimental users*. Wood Dale, IL: Stoelting. Edición española: Test Stroop de Colores y Palabras, TEA Ediciones, 2001.

- González Ordi, H. (2005). *Informe interpretativo informatizado del Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota para Adolescentes – MMPI-A*. Madrid: TEA Ediciones.
- González Ordi, H., Capilla Ramírez, P. y Matalobos Veiga, B. (2008). Simulación del dolor en el contexto médico-legal. *Clínica y Salud*, 19, 391-413.
- González Ordi, H. y Gancedo Rojí, M. (1999). Evaluación de la simulación de respuesta: diagnóstico, técnicas y procedimientos. En A. Ruano, J. M. Muñoz Céspedes y C. Cid Rojo (Coords.), *Psicología de la Rehabilitación* (pp. 405-441). Madrid: Fundación MAPFRE-Medicina.
- González Ordi, H. y Gómez Segura, J. (2002). *Informe interpretativo informatizado del Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota 2 – MMPI-2*. Madrid: TEA Ediciones.
- González Ordi, H. e Iruarrizaga Díez, I. (2005). Evaluación de las distorsiones de respuestas mediante el MMPI-2. *Papeles del Psicólogo*, 26, 129-137.
- González Ordi, H. y Matalobos Veiga, B. (2006). *Simulación de respuestas emocionales. Un estudio con diseño análogo*. Comunicación presentada en el VI Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés –SEAS. Benidorm (Alicante), 21-23 de Septiembre de 2006.
- González Ordi, H. y Santamaría Fernández, P. (2008). *Detection of Malingering in Clinical, Medicolegal, and Forensic Settings*. Poster presentado en la 29th Stress and Anxiety Research Society (STAR) Conference. Londres, 16-18 de Julio de 2008.
- González Ordi, H., Santamaría Fernández, P. y Matalobos Veiga, B. (2008). Inventario estructurado de simulación de síntomas – SIMS. Una medida de screening de simulación de síntomas psicopatológicos y neuropsicológicos. 9^o Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2008. Obtenido el 26 de Febrero de 2008 de: <http://www.psiquiatria.com/imprimir.ats?34494>
- Goodwin, D. W., Alderson, P. y Rosenthal, R. (1971). Clinical significance of hallucinations in psychiatric disorders. *Archives of General Psychiatry*, 24, 76-80.
- Gough, H. G. (1950). The F minus K dissimulation index for the MMPI. *Journal of Consulting Psychology*, 14, 408-413.
- Green, P., Rohling, M. L., Lees-Haley, P. R. y Allen L. M., III. (2001). Effort has a greater effect on test scores than severe brain injury in compensation claimants. *Brain Injury*, 15, 1045-1060.
- Greene, R. L. (2008). Malingering and defensiveness on the MMPI-2. En R. Rogers (Ed.), *Clinical assessment of malingering and deception* (pp. 159-181). New York: The Guilford Press.
- Guriel, L. y Fremouw, W. (2003). Assessing malingered post-traumatic stress disorder: A critical review. *Clinical Psychology Review*, 23, 881-904.
- Hamilton J. C. y Feldman M. D. (2001). «Chest pain» in patients who are malingering. En Hurst J. W. y Morris, D. C. (Eds.). *Chest pain*. Armork, NY: Futura Publishing Co.
- Hathaway, S. R. y McKinley, J. C. (1943). *Manual for the Minnesota Multiphasic Personality Inventory*. Nueva York: The Psychological Corporation. Edición española: *Inventario multifásico de personalidad de Minnesota*, TEA Ediciones, 1975.
- Heinze, M. C. y Purisch, A. D. (2001). Beneath the mask: Use of psychological tests to detect and subtype malingering in criminal defendants. *Journal of Forensic Psychology Practice*, 1, 23-52.
- Hunt, W. A. y Older, H. J. (1943). Detection of malingering through psychometric tests. *Naval Medical Bulletin*, 41, 1318-1323.
- Hutchinson, G. L. (2001). *Disorders of simulation: Malingering, factitious disorders, and compensation neurosis*. Madison, CT: Psychosocial Press.
- Iverson, G. L. (2003). Detecting malingering in civil forensic evaluations. En H. A. MacNeill, Jr. y L. C. Hartlage (Eds.), *Handbook of forensic neuropsychology* (pp. 137-177). Nueva York: Springer.
- Jelicic, M., Hessels, A. y Merckelbach, H. (2006). Detection of feigned psychosis with the structured inventory of malingered symptomatology (SIMS): A study of coached and uncoached simulators. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 28, 19-22.
- Jelicic, M., Peters, M. J. V., Leckie, V. y Merckelbach, H. (2007). Basic knowledge of psychopathology does not undermine the efficacy of the Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS) to detect feigned psychosis. *Journal of Psychology*, 63, 107-110.
- Jelicic, M., Candel, I. y Geraerts, E. (2007). Detection of feigned cognitive dysfunction using special malingering tests: A simulation study in naïve and coached malingerers. *International Journal of Neuroscience*, 117, 1185-1192.
- Langeluddecke, P. M. y Lucas, S. K. (2003). Quantitative measures of memory malingering on the Wechsler Memory Scale-third edition in mild head injury litigants. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 18, 181-197.
- Larrabee, G. J. (2003). Detection of malingering using atypical performance patterns on standard neuropsychological tests. *The Clinical Neuropsychologist*, 17, 410-425.
- Lattin, J., Carroll, D. J. y Green, P. E. (2003). *Analyzing multivariate data* (pp. 114-116). Duxbury Press.
- Lees-Haley, P. R. (1997). MMPI-2 base rates for 492 personal injury plaintiffs: Implications and challenges for forensic assessment. *Journal of Clinical Psychology*, 53, 745-755.



- Less-Haley, P. R., English, L. T. y Glenn, W. J. (1991). A fake bad scale on the MMPI-2 for personal-injury claimants. *Psychological Reports*, 68, 203-210.
- Lewis, J. L., Simcox, A. M. y Berry, D. T. R. (2002). Screening for feigned psychiatric symptoms in a forensic sample by using the MMPI-2 and the Structured Inventory of Malingered Symptomatology. *Psychological Assessment*, 14, 170-176.
- Lorenzo-Seva, U. y Ferrando, P. J. (2006). FACTOR: A computer program to fit the exploratory factor analysis model. *Behavioral Research Methods, Instruments and Computers*, 38(1), 88-91. Programa obtenido el 10 de junio de 2008 de: <http://psico.fcep.urv.es/utilitats/factor/>
- Lu, P. H., Boone, K. B., Cozolino, L. y Mitchell, C. (2003). Effectiveness of the Rey-Osterrieth Complex Figure Test and the Meyers and Meyers Recognition Trial in the detection of suspect effort. *The Clinical Neuropsychologist*, 17, 426-440.
- MacDonald, J. M. (1976). *Psychiatry and the criminal: A guide to psychiatric examinations for the criminal courts* (3ª Ed.). Springfield, IL: C. C. Thomas.
- Martens, M., Donders, J. y Millis, S. R. (2001). Evaluation of invalid response sets after traumatic head injury. *Journal of Forensic Neuropsychology*, 2, 1-18.
- Martínez Arias, R., Hernández Lloreda, Mª. J. y Hernández Lloreda, Mª. V. (2006). *Psicometría*. Madrid: Alianza Editorial.
- McDermott, B. E. y Feldman, M. D. (2007). Malingering in the medical setting. *Psychiatric Clinics of North America*, 30, 645-662.
- Merckelbach, H. y Smith, G. P. (2003). Diagnostic accuracy of the Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS) in detecting instructed malingering. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 18, 145-152.
- Meyers, J. E. y Meyers, K. (1995). *Rey Complex Figure and Recognition Trial professional manual*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. Edición española: Rey, *Test de copia de una figura completa*, TEA Ediciones, 1999.
- Meyers, J. E., Millis, S. R. y Volkert, K. (2002). A validity index for the MMPI-2. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 17, 157-169.
- Meyers, J. E. y Volbrecht, M. E. (2003). A validation of multiple malingering detection methods in a large clinical sample. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 18, 261-276.
- Miller, H. A. (2001). *M-FAST Miller Forensic Assessment of Symptoms Test professional manual*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
- Miller, H. A. (2004). Examining the use of the M-FAST with criminal defendants incompetent to stand trial. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 48, 268-280.
- Millon, T., Millon, C. y Davis, R. (1994). *Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III) manual*. Minneapolis, MN: NCS/Pearson. Edición española: MCMI-III. *Inventario Clínico Multiaxial de Millon-III*, TEA Ediciones, 2008.
- Mittenberg, W., Patton, C., Canyock, E. M. y Condit, D. C. (2002). Base rates of malingering and symptom exaggeration. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 24, 1094-1102.
- Mogge, N. L. y LePage, J. P. (2004). The assessment of depression inventory (ADI): A new instrument used to measure depression and to detect honesty of response. *Depression and Anxiety*, 20, 107-113.
- Morey, L. (1991). *Personality Assessment Inventory professional manual*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. Edición española: PAI. *Inventario de evaluación de la personalidad*, TEA Ediciones, en prensa.
- Mossman, D. y Somoza, E. (1991). ROC curves, test accuracy, and the description of diagnostic tests. *Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences*, 3, 330-333.
- Navran, L. A. (1954). A rationally derived MMPI scale to measure dependence. *Journal of Consulting Psychology*, 18, 192.
- Nichols, D. S. (2002). *Claves para la evaluación con el MMPI-2*. Madrid: TEA Ediciones.
- Norris, M. P. y May, M. C. (1998). Screening for malingering in a correctional setting. *Law and Human Behavior*, 22, 315-323.
- O'Bryant, S. E., Hilsabeck, R. C., Fisher, J. M. y McCaffrey, R. J. (2003). Utility of the Trail Making Test in the assessment of malingering in a sample of mild traumatic brain injury litigants. *The Clinical Neuropsychologist*, 17, 69-74.
- Ossipov, V. (1944). Malingering: The simulation of psychosis. *Bulletin of the Menninger Clinic*, 8, 39-42.
- Poythress, N. G., Edens, J. F. y Watkins, M. M. (2001). The relationship between psychopathic personality features and malingering symptoms of major mental illness. *Law and Human Behavior*, 25, 567-582.
- Reitan, R. M. y Wolfson, D. (1985). *The Halstead-Reitan Neuropsychological Battery*. Tucson, AZ: Neuropsychology Press.
- Resnick, P. J. (1984). The detection of malingered mental illness. *Behavioral Sciences and the Law*, 2, 21-38.
- Resnick, P. J. (2003). Guidelines for the evaluation of malingering in PTSD. En R. L. Simon (Ed.), *Posttraumatic stress disorder in litigation: Guidelines for forensic assessment* (2ª edición, pp. 187-205). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
- Rey, A. (1964). *L'examen clinique en psychologie*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Rogers, R. (1984). Towards an empirical model of malingering and deception. *Behavioral Sciences and the Law*, 2, 93-111.
- Rogers, R. (Ed.). (1988). *Clinical assessment of malingering and deception*. Nueva York: Guilford Press.

- Rogers, R. (1990). Development of a new classificatory model of malingering. *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 18, 323-333.
- Rogers, R. (Ed.) (1997). *Clinical Assessment of Malingering and Deception* (2ª edición). Nueva York: Guilford Press.
- Rogers, R. (1997). Introduction. En R. Rogers (Ed.), *Clinical assessment of malingering and deception*, 2ª edición, (pp. 1-19). Nueva York: Guilford Press.
- Rogers, R. (2008a). Detection Strategies for Malingering and Defensiveness. En R. Rogers (Ed.), *Clinical Assessment of Malingering and Deception*, 3ª edición, (pp. 14-35). Nueva York: Guilford Press.
- Rogers, R. (Ed.) (2008b). *Clinical Assessment of Malingering and Deception* (3ª edición). Nueva York: Guilford Press.
- Rogers, R., Bagby, R. M. y Dickens, S. E. (1992). *Structured Interview of Reported Symptoms (SIRS) professional manual*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
- Rogers, R. y Bender, S. D. (2003). Evaluation of Malingering and Deception. En A. M. Goldstein (Ed.), *Handbook of Psychology. Vol. 11: Forensic Psychology* (pp. 109-129). Nueva Jersey: Wiley.
- Rogers, R., Gillis, J. R. y Bagby, R. M. (1990). The SIRS as a measure of malingering: A validation study with a correctional sample. *Behavioral Sciences and the Law*, 8, 85-92.
- Rogers, R., Harrell, E. H. y Liff, C. D. (1993). Feigning neuropsychological impairment: A critical review of methodological and clinical considerations. *Clinical Psychology Review*, 13, 255-274.
- Rogers, R., Hinds, J. D. y Sewell, K. W. (1996). Feigning psychopathology among adolescent offenders: Validation of the SIRS, MMPI-A, and SIMS. *Journal of Personality Assessment*, 67, 244-257.
- Rogers, R., Jackson, R. L., Salekin, K. L. y Neuman, C. S. (2003). Assessing Axis I symptomatology on the SADS-C in two correctional samples: The validation of subscales and a screen for malingered presentations. *Journal of Personality Assessment*, 81, 281-290.
- Rogers, R., Jackson, R. L., Sewell, K. W. y Harrison, K. S. (2004). An examination of the ECST-R as a screen for feigned incompetency to stand trial. *Psychological Assessment*, 16, 139-145.
- Rogers, R., Jackson, R. L. y Kaminski, P. L. (2005). Factitious psychological disorders: The overlooked response style in forensic evaluations. *Journal of Forensic Psychology Practice*, 5, 21-41.
- Rogers, R., Salekin, R. T., Sewell, K. W., Goldstein, A. y Leonard, K. (1998). A comparison of forensic and non-forensic malingerers: A prototypical analysis of explanatory models. *Law and Human Behavior*, 22, 353-367.
- Rogers, R., Sewell, K. W. y Goldstein, A. M. (1994). Explanatory models of malingering: A prototypical analysis. *Law and Human Behavior*, 18, 543-552.
- Rogers, R., Sewell, K. W., Martin, M. A. y Vitacco, M. J. (2003). Detection of feigned mental disorders: A meta-analysis of the MMPI-2 and malingering. *Assessment*, 10, 160-177.
- Rogers, R. y Shuman, D. W. (2000). *Conducting insanity evaluations* (2ª edición). Nueva York: Guilford Press.
- Rogers, R., Tillbrook, C. E. y Sewell, K. W. (2004). *ECST-R Evaluation of Competency to Stand Trial-Revised professional manual*. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources.
- Rohling, M. L., Langhinrichsen-Rohling, J. y Miller, L. S. (2003). Actuarial assessment of malingering: Rohling's interpretive method. En R. D. Franklin (Ed.), *Prediction in forensic and neuropsychology: Sound statistical practices* (pp. 171-207). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Samuel, R. Z. y Mittenberg, W. (2006). Determination of malingering in disability evaluations. *Primary Psychiatry*, 12. Obtenido el 7 de Enero de 2008, de <http://www.primarypsychiatry.com/asp/articleDetail.aspx?articleId=122>
- Schinka, J. A. y Borum, R. (1993). Readability of adult psychopathology inventories. *Psychological Assessment*, 5, 384-386.
- Schinka, J. A. y Borum, R. (1994). Readability of normal personality inventories. *Journal of Personality Assessment*, 62, 95-101.
- Schoenberg, M. R., Dorr, D. y Morgan, C. D. (2003). The ability of the Millon Clinical Multiaxial Inventory- Third edition to detect malingering. *Psychological Assessment*, 15, 198-204.
- Schretlen, D. J. (1987). Malingering: The use of a psychological test battery to detect two kinds of simulation. (Tesis doctoral, University of Arizona, 1987). *Dissertation Abstracts International*, 47, 3125B.
- Schretlen, D. y Arkowitz, H. (1990). A psychological test battery to detect prison inmates who fake insanity or mental retardation. *Behavioral Sciences and the Law*, 8, 782-786.
- Seamons, D. T., Howell, R. J., Carlisle, A. L. y Roe, A. V. (1981). Rorschach simulation of mental illness and normality by psychotic and nonpsychotic legal offenders. *Journal of Personality Assessment*, 45, 130-135.
- Seigel, R. K. y West, L. J. (Eds.) (1975). *Hallucinations: Behaviour, experience, and theory*. Nueva York: Wiley.
- Sellbom, M. y Bagby, R. M. (2008). Response styles on multiscale inventories. En R. Rogers (Ed.), *Clinical assessment of malingering and deception* (3ª edición, pp. 182-206). Nueva York: Guilford Press.
- Slick, D., Hopp, G., Strauss, E. y Thompson, G. B. (1997). *Victoria Symptom Validity Test version 1.0. Professional manual*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
- Slick, D. J., Sherman, E. M. e Iverson, G. L. (1999). Diagnostic criteria for malingered neurocognitive dysfunction: Proposed standards for clinical practice and research. *The Clinical Neuropsychologist*, 13, 545-561.



- Smith, G. P. (1993). Detection of malingering: A validation study of the SLAM test. (Tesis doctoral, University of Missouri-St. Louis, 1993). *Dissertation Abstracts International*, 53, 3795B.
- Smith, G. P. (1997). Assessment of malingering with self-report instruments. En R. Rogers (Ed.), *Clinical assessment of malingering and deception* (2ª edición, pp. 351-370). Nueva York: Guilford Press.
- Smith, G. P. (2008). Brief screening measures for the detection of feigned psychopathology. En R. Rogers (Ed.), *Clinical assessment of malingering and deception* (3ª edición, pp. 323-339). Nueva York: Guilford Press.
- Smith, G. P. y Burger, G. K. (1997). Detection of malingering: Validation of the Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS). *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 25, 183-789.
- Spielberger, C. D. (1983). *Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (STAI)*. Redwood City, CA: Mind Garden. Edición española: STAI. Cuestionario de ansiedad estado rasgo, TEA Ediciones, 1997.
- Spitzer, R. L. y Endicott, J. (1975). *Schedule of Affective Disorders and Schizophrenia (SADS)*. Nueva York: Nueva York State Psychiatric Institute, Biometrics Research Unit.
- Strauss, E., Slick, D. J., Levy-Bencheton, J., Hunter, M., MacDonald, S. W. y Hultsch, D. F. (2002). Intraindividual variability as an indicator of malingering in head injury. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 17, 423-444.
- Strong, D. R., Greene, R. L. y Schinka, J. A. (2000). A taxometric analysis of MMPI-2 infrequency scales [F and F(p)] in clinical settings. *Psychological Assessment*, 12, 166-173.
- Sweet, J. J., Wolfe, P., Sattlberger, E., Numan, B., Rosenfeld, J. P., Clingerman, S. et al. (2000). Further investigation of traumatic brain injury versus insufficient effort in the California Verbal Learning Test. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 15, 105-113.
- Szasz, T. S. (1956). Malingering: «Diagnosis» or social condemnation? Analysis of the meaning of «diagnosis» in the light of some interrelations of social structure, value judgment, and the physician's role. *Archives of Neurology and Psychiatry*, 76, 432-443.
- Tombaugh, T. N. (1996). *Test of Memory Malingering: TOMM*. North Tonawanda, Nueva York: Multi-Health.
- Vickery, C. D., Berry, D. T., Inman, T. H., Harris, M. J. y Orey, S. A. (2001). Detection of inadequate effort on neuropsychological testing: A meta-analytic review of selected procedures. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 16, 45-73.
- Vitacco, M., Rogers, R., Gabel, J. y Munizza, J. (2007). Evaluation of malingering screens with competency to stand Trial patients: A known-groups comparison. *Law and Human Behavior*, 31, 249-260.
- Wachspress, M., Berenberg, A. N. y Jacobson, A. (1953). Simulation of psychosis. *Psychiatric Quarterly*, 27, 463-473.
- Walters, G. D., Rogers, R., Berry, D. T. R., Miller, H. A., Duncan, S. A., McCusker, P. J., Payne, J. W. y Granacher, R. P. (2008). Malingering as a categorical or dimensional construct: the latent structure of feigned psychopathology as measured by the SIRS and the MMPI-2. *Psychological Assessment*, 20, 238-247.
- Wechsler, D. (1997a). *Wechsler Adult Intelligence Scale-Third edition*. San Antonio, TX: The Psychological Corporation. Edición española: WAIS-III. Escala de Inteligencia de Wechsler para adultos-III. TEA Ediciones, 1999.
- Wechsler, D. (1997b). *Wechsler Memory Scale-Third edition*. San Antonio, TX: The Psychological Corporation. Edición española: WMS-III. Escala de Memoria de Wechsler-III. TEA Ediciones, 2004.
- Wedding, D. y Faust, D. (1989). Clinical judgment and decision making in neuropsychology. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 4, 233-265.
- Weiner, D. N. (1948). Subtle and obvious keys for the Minnesota Multiphasic Personality Inventory. *Journal of Consulting Psychology*, 12, 164-170.
- Wertham, F. (1949). *The show of violence*. Nueva York: Doubleday.
- Williams, J. M. (1998). The malingering of memory disorder. En C. R. Reynolds (Ed.), *Detection of malingering during head injury litigation* (pp. 105-132). Nueva York: Plenum Press.

TEA Ediciones, S. A.

www.teaediciones.com

MADRID • BARCELONA • BILBAO • ZARAGOZA • SEVILLA

La simulación de síntomas o trastornos psicológicos es un problema al que se enfrentan en su práctica múltiples profesionales de distintos ámbitos. Su evaluación y detección es todo un desafío que requiere de instrumentos de medida que faciliten dicha labor.

La adaptación española del SIMS surge precisamente con esa intención, proporcionar a los psicólogos de habla española una herramienta breve, fiable y válida para explorar y detectar patrones de falseamiento y exageración de síntomas psicopatológicos y neurocognitivos. Compuesto de 75 ítems de verdadero-falso, se caracteriza por su sencilla interpretación y su gran versatilidad, adaptándose a las diferentes necesidades que requieran los ámbitos clínicos, laborales, médico-legales y forenses.

La puntuación total del SIMS permite determinar la sospecha de simulación. Posteriormente, el análisis de las elevaciones en las puntuaciones de las escalas que lo componen (Psicosis, Deterioro neurológico, Trastornos amnésicos, Baja inteligencia y Trastornos afectivos) permite observar qué sintomatología se presenta de forma atípica, o bien, de qué manera el individuo intenta simular un trastorno en particular. Para cada una de las cinco escalas, así como para la puntuación total, se proporcionan puntos de corte para considerar sospecha de simulación.

Los estudios realizados en su adaptación española avalan su capacidad como prueba de *screening* para la evaluación de simulación, mostrando altas tasas de detección de sujetos simuladores en diversos contextos clínicos, médico-legales y forenses, junto con satisfactorios valores de fiabilidad y convergencia con pruebas reconocidas en este ámbito.

ISBN 978-84-7174-903-1



9 788471 749031